

Bunga Rampai

PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

A. Miftahul Khair • Febriyanti • Yourisna Pasambo • Silvia Nova
Hega Valentine • Afifah Fauziyyah • Salman • Rahima

Editor : Nurna Ningsih



BUNGA RAMPAI: PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

Penulis:

A. Miftahul Khair, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep

Yourisna Pasambo, Ners, M.Kes

Dr. Bd. Silvia Nova, SST, M.Kes

Hega Valentine, SKM., MKM

apt. Afifah Fauziyyah, S.Farm., M.Farm

Salman, SKM, M.Kes

Dr. Rahima., S.ST., M.Kes., AIFO

Editor:

Nurna Ningsih, SKp., M.Kes

Bunga Rampai: Peran Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan

Penulis:

A. Miftahul Khair, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep
Yourisna Pasambo, Ners, M.Kes
Dr. Bd. Silvia Nova, SST, M.Kes
HEGA VALENTINE, SKM.,MKM
apt. Afifah Fauziyyah, S.Farm., M.Farm
Salman, SKM, M.Kes
Dr. Rahima., S.ST., M.Kes., AIFO

Editor: Nurna Ningsih, SKp., M.Kes

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7556-61-5

Cetakan Pertama: Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya bunga rampai berjudul “Peran Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan” ini dapat disusun dan diselesaikan. Bunga rampai ini hadir sebagai upaya untuk memperkaya wawasan dan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif yang terintegrasi.

Tantangan kesehatan saat ini tidak hanya berkaitan dengan masih ditemukannya berbagai penyakit menular, namun juga meningkatnya beban penyakit tidak menular yang erat kaitannya dengan perubahan gaya hidup. Di sisi lain, masalah kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi wanita usia subur, isu keselamatan penggunaan obat, serta permasalahan gizi juga masih menjadi fokus utama dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif tenaga kesehatan lintas disiplin yang mampu bekerja kolaboratif serta mengedepankan pelayanan yang berbasis bukti ilmiah dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bunga rampai ini memuat pembahasan dari berbagai bidang yang saling melengkapi, meliputi: peran tenaga kesehatan dalam pencegahan penyakit menular, peran tenaga kesehatan dalam pencegahan penyakit tidak menular, upaya promosi gaya hidup sehat di masyarakat, peran kebidanan dalam pencegahan masalah kesehatan ibu dan anak, penerapan evidence-based practice dalam penyelesaian masalah kesehatan reproduksi wanita usia subur, kontribusi farmasi dalam pencegahan kesalahan penggunaan obat, peran gizi dalam pencegahan masalah gizi dan penyakit terkait, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan. Setiap topik disusun untuk menegaskan bahwa pencegahan tidak dapat berjalan sendiri, melainkan memerlukan sinergi antarprofesi, dukungan sistem, dan partisipasi masyarakat.

Kami berharap bunga rampai ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi tenaga kesehatan, serta seluruh pihak yang peduli terhadap penguatan pelayanan kesehatan. Semoga buku ini mampu mendorong lahirnya ide, inovasi, dan praktik terbaik dalam pencegahan serta pengendalian berbagai masalah kesehatan di Indonesia.

Kami menyadari bahwa bunga rampai ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini memberi manfaat luas dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya.

Februari 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN

PENYAKIT MENULAR.....	1
A. Miftahul Khair Imran, S.Kep., Ns., M.Kep.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Fungsi Strategis Tenaga Kesehatan	2
C. Peran Spesifik Tenaga Kesehatan	4
D. Kesimpulan.....	9
E. Referensi	9

CHAPTER 2 PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN

PENYAKIT TIDAK MENULAR.....	11
Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep.	11
A. Pendahuluan.....	11
B. Urgensi Pencegahan Penyakit Tidak Menular	12
C. Konsep Dasar Penyakit Tidak Menular (PTM).....	12
D. Empat Kelompok Utama Penyakit Tidak Menular	14
E. Strategi Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM).....	16
F. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM). 19	
G. Referensi	22
H. Glosarium.....	23

CHAPTER 3 UPAYA PROMOSI GAYA HIDUP SEHAT DI MASYARAKAT .25

Yourisna Pasambo, Ners., M.Kes	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Konsep Dasar Gaya Hidup Sehat	26
C. Peran Tenaga Kesehatan dalam Promosi Gaya Hidup Sehat	29
D. Strategi Promosi Gaya Hidup Sehat Berbasis Masyarakat.....	32
E. Simpulan	35
F. Referensi	35

CHAPTER 4 PERAN KEBIDANAN DALAM PENCEGAHAN MASALAH

KESEHATAN IBU DAN ANAK.....43

Dr. Bd. Silvia Nova, SST., M.Kes	43
A. Pendahuluan/Prolog.....	43
B. Kebidanan sebagai pilar <i>continuum of care</i> dan layanan primer KIA	44
C. Peran bidan pada fase pra-kehamilan dan perencanaan keluarga (pencegahan primer)	45
D. Peran bidan pada masa kehamilan (ANC) untuk deteksi dini dan pencegahan komplikasi.....	46
E. Peran bidan saat persalinan (inpartu) pencegahan kegawatdaruratan dan asuhan bermartabat.....	47
F. Peran bidan pada masa nifas dan bayi baru lahir (postnatal neonatal) mencegah kematian dan masalah jangka panjang.....	48
G. Model layanan: <i>continuity of midwifery care</i> untuk meningkatkan mutu pencegahan	50
H. Peran bidan di komunitas literasi kesehatan, pencegahan keterlambatan rujukan, dan pemberdayaan keluarga.....	50
I. Tantangan dan penguatan sistem: pendidikan, regulasi, mutu, dan jejaring rujukan.....	51
J. Simpulan	51
K. Referensi	52

CHAPTER 5 EVIDENCE-BASED PRACTICE DALAM PENYELESAIAN

MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI WANITA USIA SUBUR.....55

Hega Valentine, SKM., MKM.....	55
A. Pendahuluan.....	55
B. WUS dengan Kehamilan Usia Remaja.....	56
C. Program Kontrasepsi	66
D. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan	69
E. Simpulan	69
F. Referensi	70
G. Glosarium.....	74

CHAPTER 6 KONTRIBUSI FARMASI DALAM PENCEGAHAN

KESALAHAN PENGGUNAAN OBAT.....75

apt. Afifah Fauziyyah, S.Farm., M.Farm.	75
A. Pendahuluan.....	75
B. Konsep dan Jenis Kesalahan Penggunaan Obat	75
C. Peran Farmasi dalam Sistem Pelayanan Kesehatan	76
D. Kontribusi Farmasi dalam Pencegahan Kesalahan Penggunaan Obat.....	78
E. Pendekatan Sistem untuk Meningkatkan Keamanan Penggunaan Obat	79

F. Tantangan dan Peluang Peran Farmasi di Indonesia.....	80
G. Penutup	81
H. Referensi	81

CHAPTER 7 PERAN GIZI DALAM PENCEGAHAN MASA GIZI DAN PENYAKIT TERKAIT83

Salman, SKM., M.Kes.	83
A. Pendahuluan/Prolog.....	83
B. Strategi Gizi dalam Pencegahan dan Penatalaksanaan Stunting Melalui 1000 HPK.....	84
C. Pentingnya Penerapan Pedoman Gizi Seimbang.....	86
D. Gizi Buruk; Gejala, Mencegah dan Mengobati.....	90
E. Strategi Penanggulangan Masalah Gizi Ganda.....	92
F. Simpulan	95
G. Referensi	96
H. Glosarium.....	99

CHAPTER 8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN100

Dr. Rahima, S.SiT., M.Kes., AIFO	100
A. Pendahuluan.....	100
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	101
C. Model dan Pendekatan Teoritis Dalam Pemberdayaan Masyarakat	105
D. Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan Masalah Kesehatan	107
E. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit.....	108
F. Implementasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	110
G. Tantangan dan Peluang Dalam Pemberdayaan Masyarakat	111
H. Simpulan	112
I. Referensi	113
J. Glosarium.....	116

PROFIL PENULIS121

CHAPTER 1

PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR

A. Miftahul Khair Imran, S.Kep., Ns., M.Kep

A. Pendahuluan

Penyakit menular tetap menjadi tantangan kesehatan global yang signifikan, terutama dengan munculnya patogen baru yang memiliki kecepatan transmisi tinggi (Adisasmito, 2007). Tenaga kesehatan berperan sebagai pilar utama dalam mendeteksi dan menghentikan laju infeksi sebelum menjadi krisis yang lebih luas. Tanpa keterlibatan aktif mereka, sistem kesehatan akan mengalami kolaps saat menghadapi lonjakan kasus.

Intervensi pencegahan membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan promosi kesehatan dan perlindungan spesifik bagi kelompok rentan (Notoatmodjo, 2018). Tenaga kesehatan tidak hanya bekerja di dalam gedung rumah sakit, tetapi juga harus menjangkau masyarakat untuk mengubah perilaku berisiko. Strategi ini sangat krusial dalam menciptakan kemandirian masyarakat terhadap ancaman kesehatan.

Sinergi antarprofesi kesehatan menjadi kunci keberhasilan dalam memutuskan rantai penularan di lapangan (WHO, 2021). Dokter, perawat, sanitarian, hingga tenaga laboratorium harus bekerja dalam satu sistem koordinasi yang terintegrasi. Ketidakharmonisan peran antar-profesi dapat menyebabkan celah keamanan kesehatan yang berbahaya bagi publik.

Perubahan pola penyebaran penyakit akibat globalisasi menuntut tenaga kesehatan untuk terus memperbarui kompetensi teknis dan literasi digital mereka (Kemenkes RI, 2020). Kemampuan mengelola data informasi dan melakukan komunikasi risiko adalah aset penting di era modern. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan berbasis bukti ilmiah.

Buku ini disusun untuk mendalami peran-peran tersebut secara sistematis, mulai dari fungsi strategis hingga peran spesifik berdasarkan profesi masing-masing tenaga kesehatan. Melalui pemahaman yang komprehensif, diharapkan para praktisi dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam melindungi bangsa dari penyakit menular.

B. Fungsi Strategis Tenaga Kesehatan

1. Peran sebagai Edukator Kesehatan

Tenaga kesehatan bertindak sebagai sumber informasi utama yang menerjemahkan bahasa medis yang kompleks ke dalam bahasa masyarakat yang sederhana (Notoatmodjo, 2018). Edukasi yang efektif fokus pada cara pencegahan mandiri, seperti etika batuk dan pentingnya sirkulasi udara yang baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat secara fundamental.

Edukator harus mampu melakukan pendekatan persuasif untuk menghilangkan stigma negatif terhadap penderita penyakit menular tertentu (Kemenkes RI, 2020). Dengan hilangnya stigma, pasien akan lebih terbuka untuk melaporkan kondisinya sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Peran ini memerlukan keterampilan komunikasi antarpersonal yang sangat baik.

Penggunaan media informasi digital merupakan strategi edukasi modern yang harus dikuasai oleh tenaga kesehatan saat ini (Sari & Herawati, 2022). Melalui konten kreatif di media sosial, pesan pencegahan dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan muda. Inovasi ini membantu mempercepat penyebaran instruksi kesehatan di saat darurat.

Pelatihan bagi kader kesehatan di tingkat desa juga menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan dalam fungsi edukasinya (Purnama, 2017). Kader yang terlatih menjadi perpanjangan tangan tenaga kesehatan dalam memantau kesehatan warga di lingkungannya. Hal ini menciptakan sistem pengawasan berbasis komunitas yang sangat efektif.

Evaluasi terhadap perubahan perilaku masyarakat dilakukan secara berkala untuk mengukur keberhasilan edukasi yang telah diberikan (Notoatmodjo, 2018). Jika masyarakat belum mengubah kebiasaan buruknya, tenaga kesehatan harus mencari metode edukasi yang lebih relevan dengan budaya lokal. Keberlanjutan edukasi adalah kunci perubahan perilaku permanen.

2. Peran sebagai Promotor dan Preventor

Fungsi promotor kesehatan ditekankan pada penguatan kapasitas masyarakat untuk hidup sehat secara kolektif (Purnama, 2017). Tenaga kesehatan memfasilitasi gerakan masyarakat seperti kerja bakti dan gerakan satu rumah satu jumantik. Fokus utamanya adalah memodifikasi lingkungan agar tidak mendukung penyebaran kuman penyakit.

Sebagai preventor, tenaga kesehatan melakukan tindakan pencegahan spesifik seperti pemberian kemoprofilaksis pada kelompok berisiko tinggi (WHO, 2021). Langkah ini diambil untuk mencegah munculnya gejala klinis pada individu

yang sudah terpapar agen penyakit. Tindakan preventif selalu lebih murah dibandingkan biaya pengobatan yang mahal.

Identifikasi faktor risiko lingkungan dan perilaku dilakukan secara rutin untuk memetakan potensi masalah di masa depan (Adisasmito, 2007). Tenaga kesehatan menggunakan data ini untuk merancang program intervensi yang tepat sasaran di suatu wilayah. Pencegahan yang didasarkan pada data akan memberikan hasil yang jauh lebih optimal.

Kolaborasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan tersedianya sarana pendukung kesehatan seperti air bersih dan jamban sehat (Purnama, 2017). Tanpa infrastruktur sanitasi yang memadai, upaya promosi kesehatan akan sulit membuahkan hasil yang nyata. Tenaga kesehatan berperan sebagai katalisator dalam kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan.

Pengawasan ketat terhadap pintu masuk wilayah, seperti pelabuhan dan bandara, juga merupakan bagian dari peran preventor dalam mencegah penyakit lintas batas (Kemenkes RI, 2020). Pemeriksaan kesehatan dan validasi dokumen vaksinasi dilakukan untuk memastikan tidak ada "kasus impor" yang masuk. Langkah ini adalah pertahanan pertama negara terhadap pandemi global.

3. Peran dalam Deteksi Dini dan Surveilans Epidemiologi

Surveilans epidemiologi adalah kegiatan pengumpulan data kesehatan secara sistematis dan terus menerus (Purnama, 2017). Tenaga kesehatan di puskesmas memantau laporan penyakit setiap hari untuk melihat adanya kecenderungan peningkatan kasus. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menjadi dasar pengambilan tindakan cepat.

Deteksi dini dilakukan melalui kegiatan skrining massal pada populasi yang dianggap rentan atau memiliki riwayat kontak (WHO, 2020). Semakin cepat kasus ditemukan, semakin kecil peluang penderita untuk menularkan penyakitnya kepada orang lain. Kecepatan diagnosis adalah faktor penentu dalam meminimalkan angka kesakitan di masyarakat.

Pelacakan kontak (*contact tracing*) merupakan aktivitas lapangan yang krusial dalam peran surveilans ini (Kemenkes RI, 2020). Tenaga kesehatan harus menelusuri siapa saja yang pernah berinteraksi erat dengan pasien terkonfirmasi. Proses ini membutuhkan dedikasi tinggi karena melibatkan wawancara mendalam dan pemantauan harian.

Sistem kewaspadaan dini (SKD) dibangun untuk memberikan peringatan sebelum wabah mencapai puncaknya (Adisasmito, 2007). Tenaga kesehatan melaporkan gejala yang tidak biasa melalui sistem informasi digital yang terpusat secara nasional. Hal ini memungkinkan respons darurat dapat dilakukan hanya dalam hitungan jam setelah laporan diterima.

Penyajian data hasil surveilans dalam bentuk peta persebaran kasus membantu penentuan zonasi wilayah risiko (Purnama, 2017). Dengan pemetaan yang akurat, pembatasan aktivitas sosial dapat dilakukan secara selektif dan tidak merugikan seluruh wilayah. Visualisasi data adalah alat komunikasi penting bagi para pembuat keputusan.

4. Peran dalam Pelaksanaan Imunisasi

Pelaksanaan imunisasi merupakan strategi pencegahan penyakit menular yang paling efektif dan terukur secara global (WHO, 2021). Tenaga kesehatan bertanggung jawab dalam perencanaan sasaran, mulai dari bayi hingga kelompok dewasa berisiko. Cakupan imunisasi yang tinggi sangat diperlukan untuk mencapai *herd immunity*.

Manajemen rantai dingin (*cold chain*) vaksin harus dikelola dengan standar yang sangat ketat untuk menjaga potensi antigen (Sari & Herawati, 2022). Tenaga kesehatan memastikan suhu penyimpanan vaksin tetap stabil selama transportasi dan penyimpanan di fasilitas kesehatan. Kegagalan menjaga suhu dapat menyebabkan vaksin menjadi tidak efektif dan sia-sia.

Selama sesi imunisasi, tenaga kesehatan harus menerapkan prosedur penyuntikan yang aman guna menghindari kejadian ikutan (Kemenkes RI, 2021). Monitoring terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dilakukan untuk menjamin keamanan dan membangun kepercayaan publik. Respon cepat terhadap laporan KIPI akan meminimalkan keresahan di masyarakat.

Edukasi mengenai manfaat imunisasi dilakukan untuk melawan gerakan anti-vaksin yang sering menyebarkan informasi keliru (Sari & Herawati, 2022). Tenaga kesehatan memberikan pemahaman bahwa manfaat perlindungan vaksin jauh lebih besar daripada risiko efek sampingnya. Pendekatan persuasif dan empatik sangat diperlukan dalam menghadapi keraguan orang tua.

Pencatatan hasil imunisasi kini dilakukan secara digital untuk memudahkan pemantauan status vaksinasi setiap individu (Kemenkes RI, 2020). Data ini juga berguna bagi pemerintah untuk mengevaluasi keberhasilan program eliminasi penyakit tertentu seperti Polio. Akurasi data menjadi dasar perencanaan kebutuhan logistik vaksin di masa mendatang.

C. Peran Spesifik Tenaga Kesehatan

1. Peran Dokter dalam Pencegahan Penyakit Menular

Dokter memiliki otoritas utama dalam penegakan diagnosis klinis yang menjadi dasar bagi seluruh langkah pengendalian penyakit menular (WHO, 2020). Melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik yang komprehensif, dokter dapat

membedakan etiologi penyakit serta menentukan tingkat penularannya. Kecepatan dokter dalam mendiagnosis kasus indeks sangat menentukan keberhasilan pemutusan rantai infeksi di komunitas.

Dalam aspek pencegahan, dokter berperan memberikan profilaksis atau terapi pencegahan bagi individu yang terpapar namun belum menunjukkan gejala (Kemenkes RI, 2020). Hal ini sering diterapkan pada kasus-kasus seperti TB paru atau infeksi menular seksual guna mencegah replikasi patogen lebih lanjut. Intervensi medis pada tahap dini ini secara signifikan menurunkan risiko komplikasi berat pada pasien.

Dokter juga bertindak sebagai pemimpin klinis yang menetapkan protokol isolasi dan karantina medis bagi pasien di fasilitas kesehatan (Kemenkes RI, 2021). Keputusan dokter mengenai kapan seorang pasien dinyatakan sembuh atau tidak lagi menular adalah dasar bagi operasional rumah sakit. Peran ini memastikan bahwa lingkungan pelayanan kesehatan tidak menjadi sumber penularan silang.

Sebagai praktisi berbasis bukti, dokter berperan dalam edukasi medis mendalam kepada keluarga pasien mengenai risiko transmisi di tingkat rumah tangga (Notoatmodjo, 2018). Dokter memberikan penjelasan mengenai efektivitas pengobatan dan pentingnya kepatuhan jangka panjang untuk mencegah resistensi obat. Komunikasi antara dokter dan pasien membangun kepercayaan yang esensial dalam keberhasilan program kesehatan masyarakat.

Terakhir, dokter berkontribusi dalam riset epidemiologi klinis untuk menemukan metode deteksi dan pengobatan yang lebih efisien (Adisasmito, 2007). Data klinis yang dikumpulkan oleh dokter di lapangan menjadi bahan evaluasi nasional dalam merumuskan pedoman penanganan penyakit menular baru. Inovasi medis yang lahir dari peran dokter sangat menentukan ketahanan sistem kesehatan di masa depan.

2. Peran Perawat dalam Pencegahan Penyakit Menular

Perawat adalah tenaga kesehatan yang menghabiskan waktu paling banyak dalam kontak langsung dengan pasien, sehingga peran mereka dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sangat krusial (Kemenkes RI, 2021). Perawat memastikan setiap tindakan medis dilakukan dengan teknik aseptik yang ketat guna melindungi pasien maupun tenaga medis lainnya. Konsistensi perawat dalam menjaga kebersihan lingkungan perawatan adalah benteng utama melawan infeksi nosokomial.

Dalam pencegahan penyakit di masyarakat, perawat sering kali menjadi koordinator pelacakan kontak atau contact tracing (Kemenkes RI, 2020). Perawat melakukan kunjungan rumah untuk memantau kondisi kesehatan orang-orang yang berisiko tertular dan memberikan instruksi isolasi mandiri. Kemampuan

komunikasi empatik perawat memudahkan masyarakat untuk terbuka mengenai kondisi kesehatan mereka yang sebenarnya.

Perawat berperan besar dalam manajemen pengobatan pasien dengan penyakit menular kronis, seperti kusta atau HIV, untuk memastikan kepatuhan berobat (Sari & Herawati, 2022). Melalui asuhan keperawatan, mereka memantau efek samping obat dan memberikan solusi praktis agar pasien tidak putus obat. Kepatuhan pengobatan yang dipantau oleh perawat secara langsung menurunkan beban penularan di lingkungan sosial pasien.

Sebagai edukator, perawat memberikan pelatihan keterampilan hidup bersih seperti cara mencuci tangan yang benar dan pemakaian masker bagi pasien serta pengunjung (WHO, 2021). Demonstrasi praktis yang diberikan perawat lebih mudah diserap oleh masyarakat dibandingkan sekadar teori tertulis. Perawat mengubah pengetahuan pencegahan menjadi kebiasaan harian yang menyelamatkan nyawa.

Selain itu, perawat bertugas melakukan dokumentasi perkembangan status infeksi pasien secara mendetail untuk kepentingan surveilans (Purnama, 2017). Data observasi perawat menjadi sinyal awal bagi dokter dan epidemiolog jika ditemukan pola penyebaran yang tidak biasa di bangsal rumah sakit. Ketelitian perawat dalam mencatat gejala klinis adalah komponen penting dalam sistem peringatan dini kesehatan.

3. Peran Bidan dalam Pencegahan Penyakit Menular

Bidan memiliki peran strategis dalam mencegah penularan penyakit dari ibu ke anak (Mother-to-Child Transmission) seperti HIV, Sifilis, dan Hepatitis B (Kemenkes RI, 2020). Melalui pemeriksaan antenatal (ANC) yang rutin, bidan melakukan skrining awal pada ibu hamil untuk mendeteksi adanya infeksi tersembunyi. Intervensi tepat waktu yang dilakukan bidan dapat memastikan bayi lahir dalam keadaan sehat dan bebas dari infeksi vertikal.

Dalam pelaksanaan program imunisasi dasar, bidan adalah ujung tombak di tingkat desa dan posyandu (Sari & Herawati, 2022). Bidan bertanggung jawab memastikan setiap bayi mendapatkan rangkaian vaksin lengkap sesuai jadwal guna membangun kekebalan spesifik. Peran bidan sangat menentukan tinggi rendahnya cakupan imunisasi di suatu wilayah kerja puskesmas.

Bidan juga berperan sebagai promotor kesehatan reproduksi yang memberikan edukasi mengenai infeksi saluran reproduksi dan penyakit menular seksual kepada remaja dan pasangan usia subur (Notoatmodjo, 2018). Pengetahuan yang diberikan bidan membantu individu membuat keputusan yang aman terkait kesehatan seksual mereka. Upaya preventif ini secara langsung menurunkan prevalensi penyakit menular di tingkat komunitas.

Selama proses persalinan, bidan menerapkan standar kewaspadaan universal yang ketat untuk mencegah paparan darah dan cairan tubuh (Kemenkes RI, 2021). Penggunaan alat pelindung diri (APD) yang benar oleh bidan melindungi ibu, bayi, dan diri bidan sendiri dari potensi infeksi silang. Disiplin bidan dalam sterilisasi alat persalinan adalah prosedur pencegahan infeksi yang tidak bisa ditawar.

Terakhir, bidan melakukan pendataan dan pelaporan terhadap kasus penyakit menular yang ditemukan pada ibu dan anak di wilayah tugasnya (Purnama, 2017). Informasi ini sangat penting bagi program kesehatan ibu dan anak dalam memetakan risiko kesehatan di suatu daerah. Kehadiran bidan di tengah masyarakat menjadikannya sumber data primer yang sangat berharga bagi surveilans epidemiologi.

4. Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat (Kesmas)

Tenaga Kesmas berperan sebagai arsitek program pencegahan penyakit yang bekerja pada level populasi dan kebijakan (Adisasmito, 2007). Mereka menganalisis tren data penyakit untuk merancang strategi intervensi yang paling efektif berdasarkan bukti lapangan. Fokus utama Kesmas adalah menghilangkan faktor risiko lingkungan dan sosial yang memicu penyebaran patogen.

Dalam aspek surveilans, tenaga Kesmas bertugas mengelola sistem informasi kesehatan agar data dari lapangan dapat diproses secara cepat dan akurat (Purnama, 2017). Mereka mampu membaca pola penyebaran penyakit melalui pemetaan geografis dan analisis statistik. Analisis ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) atau wabah.

Tenaga Kesmas juga ahli dalam advokasi dan mobilisasi sumber daya masyarakat guna mendukung program pencegahan (Notoatmodjo, 2018). Mereka melakukan pendekatan kepada pembuat kebijakan agar memberikan dukungan anggaran bagi ketersediaan sarana sanitasi dan air bersih. Kemampuan advokasi ini sangat krusial agar kesehatan tetap menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Sebagai promotor, mereka merancang kampanye komunikasi risiko yang masif melalui berbagai kanal media (WHO, 2020). Tenaga Kesmas memastikan pesan-pesan pencegahan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek budaya lokal. Komunikasi yang tepat sasaran membantu mencegah kepanikan publik saat terjadi ancaman penyakit baru.

Terakhir, tenaga Kesmas melakukan evaluasi terhadap dampak dari program pencegahan yang telah dijalankan (Sari & Herawati, 2022). Jika sebuah intervensi tidak menurunkan angka kesakitan, mereka bertugas melakukan

rekayasa ulang program agar lebih tepat sasaran. Evaluasi berkelanjutan oleh tenaga Kesmas menjamin efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan negara.

5. Peran Tenaga Farmasi

Tenaga farmasi atau apoteker berperan penting dalam manajemen ketersediaan obat-obatan infeksi dan vaksin yang berkualitas (Sari & Herawati, 2022). Mereka memastikan rantai pasokan logistik farmasi tidak terputus, terutama saat terjadi lonjakan permintaan selama masa wabah. Pengelolaan stok yang baik mencegah terjadinya kelangkaan obat esensial di fasilitas pelayanan kesehatan.

Apoteker memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan antibiotik yang bijak guna mencegah resistensi antimikroba (WHO, 2021). Resistensi adalah ancaman serius yang membuat penyakit menular menjadi sulit diobati dan lebih mematikan. Dengan memberikan konseling obat yang tepat, apoteker memastikan pasien menghabiskan rejimen obat sesuai instruksi medis.

Dalam pencegahan infeksi di rumah sakit, apoteker berperan dalam penyediaan antiseptik dan disinfektan yang sesuai standar (Kemenkes RI, 2021). Mereka memberikan rekomendasi mengenai jenis bahan kimia yang paling efektif untuk menonaktifkan patogen tertentu di lingkungan medis. Keahlian kimia farmasi ini sangat mendukung kerja tim PPI dalam menjaga sterilitas rumah sakit.

Tenaga farmasi juga terlibat dalam pemantauan efek samping obat dan pelaporan reaksi obat yang merugikan (pharmacovigilance) pada pasien penyakit menular (Kemenkes RI, 2020). Hal ini sangat penting pada penggunaan obat-obat infeksi baru yang memiliki profil risiko yang belum sepenuhnya diketahui. Keamanan pasien selama masa pengobatan adalah tanggung jawab profesional apoteker.

Terakhir, apoteker di apotek komunitas sering menjadi titik kontak pertama bagi masyarakat yang mencari pengobatan mandiri untuk gejala infeksi ringan (Notoatmodjo, 2018). Apoteker berperan melakukan skrining awal dan merujuk pasien ke puskesmas atau rumah sakit jika menemukan tanda-tanda penyakit menular yang berbahaya. Peran deteksi dini di apotek dapat mempercepat penanganan kasus secara signifikan.

D. Kesimpulan

Tenaga kesehatan merupakan pilar utama dan garda terdepan dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional terhadap ancaman penyakit menular. Keberhasilan pengendalian infeksi di masyarakat tidak hanya bergantung pada intervensi medis di rumah sakit, tetapi juga pada kekuatan pencegahan multidimensi yang mencakup aspek edukasi, proteksi spesifik, dan kebijakan berbasis data.

E. Referensi

- Adisasmito, W. (2007). Sistem Kesehatan Nasional dan Penanggulangan Penyakit Menular. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (KESMAS)*, 1(6), 267-273.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021). *Principles of Epidemiology in Public Health Practice*. Atlanta: CDC. (Mendalami peran surveilans dan deteksi dini secara teknis).
- Cipolle, R. J., et al. (2012). *Pharmaceutical Care Practice: The Patient-Centered Approach to Medication Management*. McGraw-Hill. (Mendukung peran apoteker dalam manajemen pengobatan penyakit menular).
- Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach*. McGraw-Hill. (Penting untuk memperkuat bagian peran Tenaga Kesmas dalam merancang intervensi perilaku).
- Heymann, D. L. (2015). *Control of Communicable Diseases Manual*. Washington D.C.: American Public Health Association. (Referensi standar global untuk prosedur pengendalian berbagai jenis penyakit menular).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kozier, B., et al. (2020). *Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice*. Pearson. (Mendukung bagian peran perawat dalam teknik aseptik dan kontrol infeksi nosokomial).
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purnama, S. G. (2017). *Dasar-Dasar Epidemiologi*. Denpasar: Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana.
- Sari, N. M., & Herawati, L. (2022). Peran Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap pada Masa Pandemi. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 17(1), 45-56.

World Health Organization. (2020). Health workforce policy and management in the context of the COVID-19 pandemic response. *Interim Guidance*, 1-15.

World Health Organization. (2021). *Core competencies for infection prevention and control professionals*. Geneva: World Health Organization.

CHAPTER 2

PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep.

A. Pendahuluan

Penyakit Tidak Menular (PTM) atau *Noncommunicable Diseases (NCDs)* saat ini menjadi tantangan utama dalam sistem kesehatan global. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) melaporkan bahwa PTM menyumbang sekitar 74% dari seluruh kematian di dunia setiap tahunnya, dengan sebagian besar kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa PTM bukan lagi sekadar masalah kesehatan individu, tetapi telah menjadi isu kesehatan masyarakat dan pembangunan global.

Empat kelompok utama PTM yaitu penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes mellitus, dan penyakit pernapasan kronis merupakan penyebab utama mortalitas dan morbiditas global. Faktor risiko utama seperti merokok, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebihan, serta faktor metabolik seperti hipertensi dan obesitas berkontribusi besar terhadap meningkatnya prevalensi PTM (WHO, 2023).

Di Indonesia, tren peningkatan PTM juga menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa PTM menjadi penyebab kematian tertinggi, dengan prevalensi hipertensi, diabetes, dan obesitas yang terus meningkat dalam satu dekade terakhir (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Kemenkes RI], 2023). Transisi epidemiologi dari dominasi penyakit menular menuju penyakit kronis memperlihatkan perubahan pola hidup masyarakat yang semakin berisiko terhadap PTM.

Dalam konteks ini, pendekatan kuratif semata tidak lagi memadai. Upaya promotif dan preventif menjadi strategi kunci dalam menekan laju peningkatan PTM. Tenaga kesehatan memiliki posisi strategis dalam upaya tersebut, baik melalui edukasi, deteksi dini, manajemen faktor risiko, maupun advokasi kebijakan kesehatan berbasis komunitas.

B. Urgensi Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Secara konseptual, pencegahan PTM didasarkan pada teori determinan kesehatan yang menyatakan bahwa status kesehatan individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor perilaku, lingkungan, sosial, dan sistem pelayanan kesehatan. Model *Health Determinants* dan pendekatan *life-course* menekankan pentingnya intervensi sejak dini untuk mencegah akumulasi faktor risiko sepanjang kehidupan (WHO, 2023).

Pencegahan PTM tidak hanya berdampak pada penurunan angka kematian, tetapi juga pada pengurangan beban ekonomi akibat biaya pengobatan jangka panjang. WHO melalui *Global Action Plan for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases* menargetkan pengurangan prematur mortalitas akibat PTM sebesar sepertiga pada tahun 2030 sebagai bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs) (WHO, 2023).

Di Indonesia, implementasi program seperti Posbindu PTM, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan skrining faktor risiko di pelayanan kesehatan primer merupakan bentuk konkret strategi preventif nasional (Kemenkes RI, 2023). Namun, efektivitas program tersebut sangat bergantung pada kompetensi dan keterlibatan aktif tenaga kesehatan di berbagai level pelayanan.

C. Konsep Dasar Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit Tidak Menular (PTM) atau *Noncommunicable Diseases* (NCDs) merupakan kelompok penyakit kronis yang tidak ditularkan dari individu ke individu dan umumnya berkembang secara perlahan dalam jangka waktu panjang. PTM seringkali berkaitan erat dengan faktor risiko perilaku, lingkungan, genetik, serta proses degeneratif (WHO, 2023).

PTM memiliki karakteristik utama yaitu bersifat kronis, membutuhkan pengelolaan jangka panjang, dan seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus terdiagnosis pada stadium lanjut, sehingga meningkatkan beban pembiayaan kesehatan dan risiko komplikasi.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengelompokkan Penyakit Tidak Menular (PTM) sebagai penyakit kronis yang tidak ditularkan dari orang ke orang, berlangsung lama (kronis), dan umumnya berkembang secara perlahan. Dalam berbagai dokumen strategis nasional seperti *Rencana Aksi Nasional Penanggulangan PTM* dan pedoman Posbindu PTM, Kemenkes RI menegaskan bahwa terdapat empat kelompok utama PTM yang menjadi prioritas pengendalian di Indonesia, yaitu:

1. Definisi Penyakit Tidak Menular Menurut WHO dan Kemenkes RI

Penyakit Tidak Menular (PTM) atau Noncommunicable Diseases (NCDs) adalah penyakit yang tidak ditularkan dari individu ke individu dan umumnya berlangsung lama (kronis), berkembang secara perlahan, serta memerlukan pengelolaan jangka panjang. World Health Organization (WHO, 2023) mendefinisikan PTM sebagai penyakit kronis yang cenderung berlangsung lama dan merupakan hasil kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, serta perilaku. WHO (2023) melaporkan bahwa PTM bertanggung jawab atas sekitar 74% dari seluruh kematian global setiap tahunnya, dengan sebagian besar kematian terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI, 2023) mendefinisikan PTM sebagai penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang, memiliki durasi panjang, bersifat kronis dan progresif, serta berkaitan erat dengan faktor risiko perilaku dan metabolik. Dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan PTM, pemerintah menegaskan bahwa PTM menjadi prioritas nasional karena kontribusinya terhadap angka kesakitan, kematian, dan pembiayaan kesehatan yang tinggi.

2. Karakteristik Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari penyakit menular. Pertama, bersifat kronis dan berlangsung jangka panjang bahkan seumur hidup, seperti diabetes melitus dan hipertensi. Kedua, bersifat progresif dan sering berkembang secara perlahan tanpa gejala awal (silent progression). Ketiga, tidak ditularkan antar individu karena tidak disebabkan oleh agen infeksius. Keempat, bersifat multifaktorial, yaitu terjadi akibat kombinasi faktor perilaku (merokok, diet tidak sehat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol), faktor metabolik (hipertensi, obesitas, hiperglikemia, dislipidemia), faktor genetik, serta determinan sosial kesehatan. WHO (2023) menegaskan bahwa empat faktor risiko perilaku utama berkontribusi besar terhadap peningkatan PTM secara global.

3. Dampak Sosial, Ekonomi, dan Sistem Kesehatan

Penyakit Tidak Menular memberikan dampak luas terhadap individu, keluarga, dan negara. Secara sosial, PTM meningkatkan angka disabilitas, ketergantungan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat. Secara ekonomi, PTM menimbulkan biaya langsung berupa pengobatan jangka panjang, rawat inap, dan terapi berkelanjutan, serta biaya tidak langsung berupa kehilangan produktivitas dan kematian prematur. Di Indonesia, pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagian besar terserap untuk penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal yang termasuk dalam kelompok

PTM (Kemenkes RI, 2023). Dari sisi sistem kesehatan, peningkatan PTM menuntut penguatan pelayanan kesehatan primer, skrining dan deteksi dini, serta manajemen penyakit kronis berkelanjutan berbasis Primary Health Care.

D. Empat Kelompok Utama Penyakit Tidak Menular

World Health Organization (WHO, 2023) mengelompokkan Penyakit Tidak Menular (PTM) ke dalam empat kelompok utama yang menyumbang sebagian besar kematian global, yaitu penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes melitus, dan penyakit pernapasan kronis termasuk Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK). Keempat kelompok ini memiliki karakteristik kronis, progresif, berkaitan erat dengan faktor risiko perilaku dan metabolik, serta memberikan beban besar terhadap sistem kesehatan.

1. Penyakit Kardiovaskular

Penyakit kardiovaskular (PKV) merupakan kelompok PTM yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Penyakit ini meliputi penyakit jantung koroner, stroke, gagal jantung, hipertensi, dan penyakit pembuluh darah perifer. Secara global, penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor satu, menyumbang sekitar 20 juta kematian per tahun (WHO, 2023).

Secara patofisiologis, sebagian besar penyakit kardiovaskular berkaitan dengan proses aterosklerosis, yaitu penumpukan plak pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan penyempitan atau sumbatan aliran darah. Kondisi ini dapat memicu serangan jantung (infark miokard) maupun stroke. Faktor risiko utama penyakit kardiovaskular meliputi:

- a. Hipertensi
- b. Dislipidemia
- c. Diabetes melitus
- d. Merokok
- e. Obesitas
- f. Kurang aktivitas fisik
- g. Pola makan tinggi garam dan lemak jenuh

Di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru, prevalensi hipertensi dan penyakit jantung menunjukkan tren peningkatan, sehingga penguatan deteksi dini dan pengendalian faktor risiko menjadi strategi utama dalam pencegahan.

2. Kanker

Kanker adalah penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dan dapat menyerang jaringan sekitarnya serta menyebar ke

organ lain (metastasis). Kanker terjadi akibat perubahan genetik (mutasi) yang mengganggu mekanisme pengaturan pertumbuhan sel normal.

WHO (2023) melaporkan bahwa kanker merupakan penyebab kematian terbesar kedua di dunia. Jenis kanker yang paling sering ditemukan secara global antara lain kanker paru, payudara, kolorektal, hati, dan serviks.

Faktor risiko kanker bersifat multifaktorial, meliputi:

- a. Merokok (penyebab utama kanker paru)
- b. Konsumsi alkohol
- c. Pola makan tidak sehat
- d. Obesitas
- e. Paparan zat karsinogenik (asbes, radiasi, bahan kimia)
- f. Infeksi tertentu (HPV pada kanker serviks, Hepatitis B/C pada kanker hati)
- g. Faktor genetik

Secara konseptual, kanker berkembang melalui proses multistep carcinogenesis, yaitu inisiasi, promosi, dan progresi. Pencegahan kanker dilakukan melalui pendekatan promotif dan preventif seperti vaksinasi HPV, deteksi dini (IVA, Pap smear, SADANIS), serta pengendalian faktor risiko.

3. Diabetes Melitus

Diabetes melitus adalah gangguan metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Secara klinis, diabetes dibagi menjadi beberapa tipe, dengan tipe 2 sebagai bentuk yang paling dominan (lebih dari 90% kasus).

Secara patofisiologis, diabetes tipe 2 berkaitan dengan resistensi insulin dan disfungsi sel beta pankreas. Kondisi hiperglikemia kronis dapat menyebabkan komplikasi makrovaskular (penyakit jantung, stroke) dan mikrovaskular (nefropati, neuropati, retinopati).

Faktor risiko utama diabetes melitus tipe 2 meliputi:

- a. Obesitas sentral
- b. Kurang aktivitas fisik
- c. Pola makan tinggi gula dan lemak
- d. Riwayat keluarga
- e. Usia lanjut
- f. Hipertensi dan dislipidemia

WHO (2023) menyatakan bahwa prevalensi diabetes global terus meningkat seiring perubahan gaya hidup dan urbanisasi. Di Indonesia, peningkatan prevalensi diabetes menjadi perhatian serius karena berkontribusi pada komplikasi katastropik dan beban pembiayaan JKN.

Pengendalian diabetes menekankan pendekatan manajemen penyakit kronis berbasis perawatan berkelanjutan (continuity of care) dan perubahan gaya hidup.

4. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)

Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) merupakan penyakit pernapasan kronis yang ditandai dengan hambatan aliran udara yang persisten dan bersifat progresif. PPOK mencakup bronkitis kronis dan emfisema. Secara patofisiologi, PPOK terjadi akibat peradangan kronis pada saluran napas yang menyebabkan penyempitan bronkus dan kerusakan alveoli. Akibatnya, terjadi gangguan pertukaran gas yang menyebabkan sesak napas kronis.

Faktor risiko utama PPOK adalah:

- a. Merokok (aktif maupun pasif)
- b. Paparan polusi udara dalam dan luar ruangan
- c. Paparan debu dan bahan kimia di tempat kerja
- d. Riwayat infeksi saluran pernapasan berulang

WHO menempatkan PPOK sebagai salah satu penyebab utama kematian global. Penyakit ini sering tidak terdiagnosis pada tahap awal karena gejalanya berkembang perlahan. Oleh karena itu, pencegahan primer melalui pengendalian tembakau dan peningkatan kualitas udara menjadi strategi kunci.

E. Strategi Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan tantangan utama kesehatan global dan nasional karena bersifat kronis, progresif, dan membutuhkan pembiayaan jangka panjang. World Health Organization (WHO, 2023) menegaskan bahwa sebagian besar PTM sebenarnya dapat dicegah melalui intervensi yang efektif terhadap faktor risiko perilaku dan metabolik. Dalam pendekatan kesehatan masyarakat klasik yang dikemukakan oleh Leavell dan Clark (1965), pencegahan penyakit dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kerangka ini masih relevan dan digunakan dalam kebijakan pengendalian PTM hingga saat ini, termasuk dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan PTM oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI, 2023).

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer adalah upaya yang dilakukan sebelum penyakit terjadi, dengan tujuan menghilangkan atau mengendalikan faktor risiko sehingga individu tidak jatuh sakit. Dalam konteks PTM, pencegahan primer berfokus pada modifikasi gaya hidup dan pengendalian determinan sosial kesehatan.

WHO (2023) mengidentifikasi empat faktor risiko perilaku utama PTM, yaitu:

- a. Konsumsi tembakau
- b. Pola makan tidak sehat
- c. Kurang aktivitas fisik
- d. Konsumsi alkohol berlebihan

Keempat faktor tersebut berkontribusi terhadap faktor risiko metabolik seperti hipertensi, obesitas, hiperglikemia, dan dislipidemia. Strategi pencegahan primer meliputi:

a. Promosi Gaya Hidup Sehat

Promosi kesehatan dilakukan melalui edukasi masyarakat tentang pentingnya aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu, konsumsi buah dan sayur, pembatasan gula, garam, dan lemak, serta penghentian merokok. Di Indonesia, pendekatan ini diwujudkan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang mendorong aktivitas fisik, konsumsi pangan sehat, dan pemeriksaan kesehatan rutin (Kemenkes RI, 2023).

b. Kebijakan Pengendalian Tembakau

WHO melalui *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) merekomendasikan kebijakan kenaikan cukai rokok, kawasan tanpa rokok, pelarangan iklan, dan peringatan kesehatan bergambar. Kebijakan ini terbukti efektif menurunkan prevalensi merokok dan risiko penyakit kardiovaskular serta kanker paru (WHO, 2023).

c. Intervensi Berbasis Lingkungan dan Kebijakan Publik

Pendekatan *Health in All Policies* mendorong integrasi kebijakan kesehatan dalam sektor transportasi, pendidikan, pertanian, dan industri. Misalnya, penyediaan ruang terbuka hijau untuk aktivitas fisik, regulasi kandungan gula pada minuman, serta pelabelan gizi pada produk pangan. Secara konseptual, pencegahan primer tidak hanya menargetkan individu, tetapi juga lingkungan sosial dan ekonomi yang memengaruhi perilaku kesehatan. Pendekatan ini sejalan dengan teori Determinan Sosial Kesehatan (WHO Commission on Social Determinants of Health, 2008), yang menekankan bahwa kondisi sosial-ekonomi sangat menentukan risiko PTM.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder bertujuan mendeteksi penyakit pada tahap awal sebelum muncul komplikasi, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Dalam konteks PTM, strategi ini berfokus pada skrining, deteksi dini, dan pengobatan awal.

Menurut WHO (2023), deteksi dini sangat penting karena banyak PTM berkembang tanpa gejala awal (*silent progression*), seperti hipertensi dan diabetes melitus.

Beberapa bentuk pencegahan sekunder antara lain:

a. Skrining Penyakit Kardiovaskular

Pemeriksaan tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah secara rutin dapat mengidentifikasi individu berisiko tinggi. Di Indonesia, Posbindu PTM merupakan strategi berbasis masyarakat untuk skrining faktor risiko PTM (Kemenkes RI, 2023).

b. Deteksi Dini Kanker

Program skrining kanker serviks (IVA dan Pap smear), SADANIS untuk kanker payudara, serta skrining kanker kolorektal merupakan contoh intervensi sekunder. Deteksi dini meningkatkan peluang keberhasilan terapi dan menurunkan angka kematian.

c. Skrining Diabetes dan PPOK

Pemeriksaan gula darah puasa dan HbA1c dilakukan untuk mendeteksi diabetes. Pada PPOK, pemeriksaan spirometri dapat membantu diagnosis dini, terutama pada perokok aktif atau mantan perokok. Secara teori, pencegahan sekunder bertujuan menurunkan prevalensi penyakit melalui diagnosis dan pengobatan dini (Gordis, 2014). Intervensi ini terbukti cost-effective karena mencegah komplikasi berat yang membutuhkan biaya tinggi.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier adalah upaya untuk mengurangi dampak penyakit yang sudah terjadi, mencegah komplikasi lebih lanjut, dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Pada tahap ini, fokus utama adalah rehabilitasi, pengelolaan penyakit kronis, serta pencegahan kecacatan.

WHO (2023) menekankan pentingnya pendekatan continuity of care dalam manajemen PTM, yaitu pelayanan berkelanjutan dari fasilitas kesehatan primer hingga rujukan spesialisasi. Strategi pencegahan tersier meliputi:

a. Manajemen Penyakit Kronis

Pengelolaan hipertensi dengan terapi antihipertensi teratur, pengendalian gula darah pada diabetes, kemoterapi atau radioterapi pada kanker, serta terapi bronkodilator pada PPOK merupakan contoh intervensi tersier. Model Chronic Care Model (Wagner et al., 2001) menekankan kolaborasi antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan dalam pengelolaan penyakit kronis secara berkelanjutan.

b. Rehabilitasi dan Pencegahan Disabilitas

Rehabilitasi jantung pasca-serangan jantung, rehabilitasi stroke, serta terapi paru pada PPOK bertujuan mengembalikan fungsi optimal pasien dan mencegah kecacatan permanen.

c. Dukungan Psikososial

PTM seringkali berdampak pada kesehatan mental dan produktivitas pasien. Oleh karena itu, dukungan konseling, edukasi keluarga, dan penguatan kelompok dukungan menjadi bagian penting dalam pencegahan tersier. Di Indonesia, penguatan pelayanan kesehatan primer melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dalam sistem JKN merupakan bentuk implementasi pencegahan tersier berbasis komunitas.

Strategi pencegahan PTM harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer menitikberatkan pada pengendalian faktor risiko dan promosi kesehatan; pencegahan sekunder pada deteksi dini dan intervensi awal; sedangkan pencegahan tersier berfokus pada pengelolaan penyakit kronis dan rehabilitasi.

WHO dan Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa pengendalian PTM memerlukan pendekatan multisektor, penguatan pelayanan kesehatan primer, serta pemberdayaan masyarakat. Integrasi ketiga tingkat pencegahan ini menjadi kunci dalam menurunkan angka kesakitan, kematian prematur, dan beban pembiayaan akibat PTM.

F. Peran Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan masalah kesehatan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional. WHO (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian PTM sangat bergantung pada penguatan pelayanan kesehatan primer dan kapasitas tenaga kesehatan dalam promosi, pencegahan, deteksi dini, serta manajemen penyakit kronis. Dalam konteks sistem kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan RI (2023) juga menekankan pentingnya transformasi layanan primer dengan pendekatan promotif dan preventif sebagai garda terdepan pengendalian PTM.

Tenaga kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi, apoteker, dan tenaga profesional lainnya memiliki peran strategis dalam setiap level pencegahan (primer, sekunder, dan tersier). Peran tersebut tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga edukatif, sosial, dan advokatif.

1. Peran sebagai Edukator

Sebagai edukator, tenaga kesehatan berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat terkait faktor risiko dan pencegahan PTM. WHO (2023) menekankan bahwa modifikasi perilaku merupakan intervensi paling cost-effective dalam menurunkan angka kematian prematur akibat PTM. Namun,

perubahan perilaku hanya dapat terjadi apabila individu memiliki pengetahuan yang memadai.

Edukasi kesehatan mencakup:

- a. Informasi tentang bahaya merokok dan konsumsi alkohol
- b. Pentingnya aktivitas fisik teratur
- c. Pola makan seimbang dan pembatasan gula, garam, serta lemak
- d. Pengendalian berat badan dan pemeriksaan kesehatan berkala

Pendekatan edukasi yang efektif harus mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat. Model Health Belief Model (HBM) menjelaskan bahwa seseorang akan mengubah perilaku jika ia merasa rentan terhadap penyakit dan memahami manfaat tindakan pencegahan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu menyampaikan informasi secara persuasif dan berbasis bukti. Di Indonesia, implementasi edukasi dilakukan melalui Posbindu PTM, Puskesmas, serta program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

2. Peran sebagai Konselor Perubahan Perilaku

Selain memberikan informasi, tenaga kesehatan berperan sebagai konselor dalam membantu individu mengubah perilaku berisiko. Perubahan perilaku merupakan proses bertahap yang dijelaskan dalam Transtheoretical Model (Prochaska & DiClemente), yang meliputi tahap prekontemplasi, kontemplasi, persiapan, aksi, dan pemeliharaan.

Dalam praktiknya, konseling dapat dilakukan melalui:

- a. Konseling berhenti merokok
- b. Konseling diet pada pasien obesitas atau diabetes
- c. Konseling aktivitas fisik pada individu sedentari
- d. Konseling kepatuhan terapi pada pasien hipertensi

Pendekatan motivational interviewing sering digunakan untuk meningkatkan komitmen pasien terhadap perubahan perilaku. WHO (2023) menekankan bahwa intervensi berbasis konseling individual terbukti efektif dalam mengendalikan faktor risiko metabolik. Peran ini menuntut keterampilan komunikasi interpersonal, empati, serta kemampuan membangun hubungan terapeutik yang kuat antara tenaga kesehatan dan pasien.

3. Peran sebagai Fasilitator dan Koordinator Layanan

Pengendalian PTM memerlukan pelayanan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator dan koordinator layanan untuk memastikan pasien mendapatkan akses yang tepat ke berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Konsep continuity of care yang ditekankan WHO (2023) mengharuskan adanya koordinasi antara:

- a. Pelayanan kesehatan primer

- b. Rumah sakit rujukan
- c. Layanan rehabilitasi
- d. Dukungan komunitas

Di Indonesia, Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan contoh pendekatan terintegrasi untuk pasien diabetes dan hipertensi. Tenaga kesehatan berperan dalam memantau kepatuhan terapi, menjadwalkan kunjungan rutin, serta mengoordinasikan rujukan jika terjadi komplikasi. Peran ini juga mencakup kolaborasi interprofesional, di mana dokter, perawat, ahli gizi, dan farmasis bekerja secara tim dalam pengelolaan pasien PTM.

4. Peran sebagai Advokat Kebijakan Kesehatan

Tenaga kesehatan tidak hanya bekerja di ranah klinis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai advokat kebijakan kesehatan. WHO mendorong pendekatan “Health in All Policies,” yang menekankan bahwa kebijakan di berbagai sektor harus mempertimbangkan dampak kesehatan.

Peran advokasi meliputi:

- a. Mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok
- b. Mengkampanyekan pembatasan gula dan minuman berpemanis
- c. Mendorong penyediaan ruang publik untuk aktivitas fisik
- d. Memberikan rekomendasi berbasis data kepada pembuat kebijakan

Tenaga kesehatan memiliki legitimasi ilmiah dan moral untuk menyuarakan kepentingan kesehatan masyarakat. Keterlibatan mereka dalam forum kebijakan dapat memperkuat regulasi yang mendukung pencegahan PTM.

5. Peran dalam Skrining dan Deteksi Dini

Skrining merupakan komponen utama pencegahan sekunder. Banyak PTM berkembang secara silent progression tanpa gejala awal, seperti hipertensi dan diabetes. Oleh karena itu, tenaga kesehatan berperan penting dalam melakukan:

- a. Pemeriksaan tekanan darah rutin
- b. Pengukuran indeks massa tubuh (IMT)
- c. Pemeriksaan gula darah dan kolesterol
- d. Skrining kanker serviks (IVA/Pap smear)
- e. Skrining kanker payudara (SADANIS)

Kemendes RI (2023) menekankan pentingnya penguatan Posbindu PTM sebagai wadah skrining berbasis masyarakat. Tenaga kesehatan bertugas melakukan identifikasi faktor risiko, pencatatan, pelaporan, serta tindak lanjut hasil skrining. Skrining yang efektif dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas melalui intervensi dini sebelum terjadi komplikasi berat.

6. Peran dalam Manajemen Penyakit Kronis Berkelanjutan

Pada tahap pencegahan tersier, tenaga kesehatan berperan dalam pengelolaan penyakit kronis secara jangka panjang. Model Chronic Care Model (Wagner) menekankan pentingnya sistem pelayanan proaktif, dukungan pengambilan keputusan klinis, serta pemberdayaan pasien dalam self-management. Manajemen berkelanjutan meliputi:

- a. Pemantauan tekanan darah pada pasien hipertensi
- b. Pengendalian HbA1c pada pasien diabetes
- c. Terapi inhalasi dan rehabilitasi paru pada PPOK
- d. Rehabilitasi jantung dan stroke
- e. Edukasi self-care dan kepatuhan obat

Pendekatan ini bertujuan mencegah komplikasi, menurunkan angka rawat inap, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. WHO (2023) menegaskan bahwa investasi dalam manajemen kronis berbasis pelayanan primer lebih efektif dibandingkan pendekatan kuratif di tingkat lanjut.

Peran tenaga kesehatan dalam pencegahan PTM bersifat komprehensif dan multidimensional, mencakup fungsi edukatif, konseling, koordinatif, advokatif, preventif, dan kuratif berkelanjutan. Keberhasilan pengendalian PTM sangat bergantung pada kapasitas tenaga kesehatan dalam mengintegrasikan ketiga tingkat pencegahan (primer, sekunder, tersier) secara sistematis dan berkesinambungan.

Penguatan kompetensi, kolaborasi interprofesional, serta dukungan kebijakan nasional menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan kontribusi tenaga kesehatan terhadap penurunan beban PTM di Indonesia dan global.

G. Referensi

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020–2024*. <https://www.kemkes.go.id/>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk teknis Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)*. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). <https://www.kemkes.go.id/>
- Leavell, H. R., & Clark, E. G. (1965). *Preventive medicine for the doctor in his community: An epidemiologic approach* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(3), 390–395. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.51.3.390>

- Wagner, E. H., Austin, B. T., & Von Korff, M. (2001). Organizing care for patients with chronic illness. *The Milbank Quarterly*, 79 (4), 511–544. <https://doi.org/10.1111/1468-0009.00225>
- World Health Organization. (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health . <https://doi.org/10.1136/jech.2008.099424>
- World Health Organization. (2023). Noncommunicable diseases. <https://www.who.int/health-topics/noncommunicable-diseases>

H. Glosarium

PTM	= Penyakit Tidak Menular
NCDs	= Noncommunicable Diseases
WHO	= World Health Organization
Kemenkes RI	= Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Depkes RI	= Departemen Kesehatan Republik Indonesia
GERMAS	= Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Posbindu PTM	= Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular
Prolanis	= Program Pengelolaan Penyakit Kronis
JKN	= Jaminan Kesehatan Nasional
BPJS	= Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
HBM	= Health Belief Model
CCM	= Chronic Care Model
IMT	= Indeks Massa Tubuh
PPOK	= Penyakit Paru Obstruktif Kronis
DM	= Diabetes Melitus
T2DM	= Type 2 Diabetes Melitus
CVD	= Cardiovascular Disease
IVA	= Inspeksi Visual dengan Asam Asetat
Pap Smear	= Papanicolaou Smear (Tes Deteksi Dini Kanker Serviks)
SADANIS	= Pemeriksaan Payudara Klinis
HbA1c	= Hemoglobin A1c
HDL	= High Density Lipoprotein
LDL	= Low Density Lipoprotein
SBP	= Systolic Blood Pressure
DBP	= Diastolic Blood Pressure
KTR	= Kawasan Tanpa Rokok
SDGs	= Sustainable Development Goals
PHC	= Primary Health Care

PEN	= Package of Essential Noncommunicable Disease Interventions
KIE	= Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
UKM	= Upaya Kesehatan Masyarakat
UKP	= Upaya Kesehatan Perorangan

CHAPTER 3

UPAYA PROMOSI GAYA HIDUP SEHAT DI MASYARAKAT

Yourisna Pasambo, Ners., M.Kes

A. Pendahuluan

Promosi gaya hidup sehat semakin menjadi kebutuhan mendasar dalam upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Cara orang makan, bergerak, beristirahat, serta kebiasaan sehari-hari seperti merokok atau mengelola stres bukan sekadar pilihan personal, tetapi faktor yang membentuk risiko kesehatan jangka panjang. Berbagai kajian menegaskan bahwa promosi kesehatan yang menargetkan perubahan gaya hidup berperan besar dalam menekan beban penyakit kronis, termasuk penyakit kardiovaskular yang masih menjadi penyebab kematian utama di banyak negara. Bahkan, *World Health Organization* (WHO) memperkirakan sebagian besar kematian dini akibat penyakit-penyakit tersebut dapat dicegah melalui pola makan sehat, aktivitas fisik yang memadai, dan menghindari tembakau (Kolip, 2016).

Selain Penyakit Tidak Menular (PTM), promosi gaya hidup sehat juga relevan untuk masalah kesehatan lain yang kerap berjalan beriringan, terutama kesehatan mental. Upaya promosi kesehatan mental pada level individu, komunitas, dan kebijakan dapat menurunkan kejadian masalah kesehatan mental, termasuk risiko *self-harm* dan bunuh diri pada kelompok rentan (Selestrin, 2021). Dengan demikian, gaya hidup sehat perlu dipahami sebagai fondasi kesehatan yang bersifat lintas isu—mendukung pencegahan penyakit, memperkuat kesejahteraan, dan meningkatkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi tekanan hidup dan perubahan sosial.

Di Indonesia, berbagai masalah kesehatan berkaitan erat dengan pola hidup sehari-hari. Kebiasaan makan yang kurang sehat misalnya konsumsi minuman manis, makanan tinggi lemak, dan fast food serta rendahnya konsumsi buah dan sayur, turut berkontribusi terhadap meningkatnya obesitas dan risiko PTM seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular (Rifqi et al., 2025; Rosmiati et al., 2023; Suhito et al., 2025). Kondisi ini diperkuat oleh aktivitas fisik yang rendah dan gaya hidup sedentari, terutama pada kelompok urban dan remaja (Nurwanti et al., 2019; Purwaningsih & Solikhah, 2020). Di sisi lain, perilaku merokok masih banyak dijumpai dan diketahui berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit kronis (Amalia & Kismiantini, 2022).

Promosi gaya hidup sehat tidak cukup jika hanya menekankan edukasi pada individu. Perubahan perilaku lebih mudah terjadi ketika didukung oleh lingkungan sosial dan kondisi komunitas yang memungkinkan orang memilih hidup sehat. Karena itu, promosi kesehatan berbasis masyarakat penting untuk pencegahan primer, sekaligus membantu menekan beban biaya kesehatan melalui upaya pencegahan yang relatif lebih hemat dibandingkan penanganan penyakit kronis (Kolip, 2016). Pendekatan ini perlu mempertimbangkan determinan sosial kesehatan agar program lebih sesuai dengan realitas masyarakat dan tidak menyalahkan individu semata (Marcellus et al., 2022; Møller & Merrild, 2020). Bila dirancang berbasis bukti dan dipantau secara teratur, promosi kesehatan dapat memberi dampak pada level populasi dan memperkuat ketahanan komunitas (Kok & de Vries, 2015).

B. Konsep Dasar Gaya Hidup Sehat

1. Definisi dan komponen gaya hidup sehat

Gaya hidup sehat adalah pola kebiasaan sehari-hari yang membantu seseorang menjaga kebugaran, mencegah penyakit, dan mempertahankan kualitas hidup. Pola ini terbentuk dari pilihan yang dilakukan secara konsisten—mulai dari aktif bergerak dan mengurangi perilaku sedentari, hingga mengatur asupan makan agar lebih seimbang. WHO menegaskan pentingnya aktivitas fisik sekaligus pengurangan sedentari untuk kesehatan populasi (WHO, 2020d), serta menekankan bahwa pola makan sehat (misalnya meningkatkan konsumsi buah dan sayur serta membatasi komponen yang berisiko) berperan dalam menurunkan risiko PTM (WHO, 2020b). Dalam paket gaya hidup sehat, berhenti merokok menjadi komponen kunci karena tembakau berdampak besar pada kesehatan dan dapat membunuh hingga setengah penggunanya yang tidak berhenti (WHO, 2025c).

Selain itu, gaya hidup sehat juga mencakup tidur yang cukup dan berkualitas. CDC merekomendasikan orang dewasa tidur setidaknya 7 jam per hari (CDC, 2024), serta kemampuan mengelola stres dan menjaga kesehatan mental. WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai keadaan sejahtera yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi stres kehidupan, belajar dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitas (WHO, 2025a). Komponen lain yang tidak kalah penting adalah perilaku aman dan kebersihan diri/lingkungan, termasuk kebiasaan kebersihan tangan di komunitas yang menjadi langkah efektif untuk menurunkan penularan penyakit (WHO, 2025d).

2. Determinan perilaku kesehatan

Perilaku kesehatan tidak terbentuk hanya oleh niat individu. Pilihan untuk makan sehat, aktif bergerak, berhenti merokok, atau tidur cukup dipengaruhi oleh banyak lapisan: apa yang seseorang ketahui dan yakini, dukungan sosial yang ia miliki, kondisi lingkungan yang memudahkan atau justru menghambat, serta kebijakan yang mengatur apa yang tersedia dan apa yang dianggap normal di masyarakat. WHO menjelaskan determinan kesehatan mencakup lingkungan sosial–ekonomi, lingkungan fisik, serta karakteristik dan perilaku individu (WHO, 2024b).

a. Faktor individu (pengetahuan, self-efficacy, motivasi)

Faktor individu adalah titik awal, karena perilaku sehat sering dimulai dari pemahaman yang memadai tentang risiko dan manfaat, lalu diikuti keyakinan bahwa seseorang mampu melakukannya. Literasi kesehatan dan kebiasaan mencari informasi kesehatan berkaitan dengan perilaku perawatan diri yang lebih baik (Soroya et al., 2024). Pengetahuan tentang perilaku kesehatan juga membantu pengambilan keputusan yang lebih terarah (Kim et al., 2013). Di sisi lain, pengetahuan saja sering tidak cukup. Efikasi diri (self-efficacy) yaitu rasa mampu untuk menjalankan perilaku sehat berulang kali ditemukan berhubungan dengan praktik kesehatan yang lebih positif dan konsisten (Hsu, 2025).

Motivasi melengkapi dua komponen tadi. Dorongan intrinsik (misalnya ingin lebih bugar, ingin menjadi teladan keluarga) maupun motivasi yang terkait identitas diri (“saya orang yang peduli kesehatan”) memengaruhi niat dan keberlanjutan perilaku sehat (Scott & Morgan, 2023). Ketika pengetahuan, efikasi diri, dan motivasi berjalan bersama, individu cenderung lebih siap mencoba perubahan kecil yang realistis dan mempertahankannya dalam jangka panjang.

b. Faktor sosial-budaya (norma, dukungan keluarga dan teman sebaya)

Perilaku kesehatan juga merupakan perilaku sosial. Banyak kebiasaan sehari-hari dibentuk oleh norma—apa yang dianggap wajar di rumah, di pergaulan, atau di komunitas. Pada remaja, norma dari teman sebaya dan orang tua dapat memengaruhi pola makan dan aktivitas fisik (Rice & Klein, 2019). Keyakinan budaya dan faktor sosial dapat menjadi pendorong (misalnya budaya olahraga bersama) atau hambatan (misalnya normalisasi makanan tinggi gula/lemak pada acara tertentu) (Rangan, 2024). Dukungan keluarga dan teman sebaya berperan sebagai “penguat” perubahan. Dukungan emosional dan dukungan praktis, misalnya keluarga ikut menyiapkan menu sehat atau teman mengajak

aktivitas fisik dapat membantu seseorang bertahan ketika motivasi menurun (Yau, 2023).

c. Faktor lingkungan (akses pangan sehat, ruang aktivitas fisik, iklan rokok)

Lingkungan tempat kita tinggal sering kali menentukan apakah hidup sehat terasa mudah atau justru berat. Orang akan lebih mudah membiasakan makan sehat jika bahan pangan yang baik tersedia, harganya terjangkau, dan bisa didapat tanpa usaha yang berlebihan. Sebaliknya, bila yang paling mudah dijumpai justru makanan tinggi gula/lemak atau pilihan sehat sulit diakses, kebiasaan makan sehat jadi lebih sulit dipertahankan (Oli et al., 2025). Penelitian di komunitas juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan lokal—termasuk ketersediaan pilihan pangan dan fasilitas—ikut membentuk kebiasaan sehat yang bisa dijalankan dalam rutinitas sehari-hari (Joseph et al., 2012).

Hal yang sama terjadi pada aktivitas fisik. Jika lingkungan menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk berjalan kaki, bersepeda, atau beraktivitas (misalnya taman, jalur pejalan kaki, ruang rekreasi), orang cenderung lebih aktif (Ashe et al., 2011). Sebaliknya, keterbatasan ruang gerak, akses fasilitas yang jauh, atau lingkungan yang tidak ramah pejalan kaki membuat orang lebih mudah “terjebak” pada pola hidup kurang gerak. Faktor harga dan ketersediaan di sekitar tempat tinggal juga dapat memengaruhi pilihan makan dan berhubungan dengan risiko obesitas pada kelompok muda (Chaloupka & Powell, 2009). Selain itu, paparan iklan dan pemasaran rokok di sekitar kita—misalnya di toko atau ruang publik—dapat mendorong orang untuk mencoba atau terus merokok, sehingga pembatasan promosi menjadi bagian penting dalam mengurangi perilaku merokok (D’Angelo et al., 2015).

d. Faktor kebijakan (aturan kawasan tanpa rokok, label gizi, dsb.)

Kebijakan membantu membuat “pilihan sehat” menjadi lebih mudah dilakukan. Contohnya, kawasan bebas rokok tidak hanya melindungi orang dari asap rokok, tetapi juga dapat mengurangi kebiasaan merokok jika diterapkan dengan dukungan tempat kerja dan masyarakat (Kamal et al., 2024). Pada level global, WHO menekankan perlindungan dari asap rokok serta pembatasan iklan/promosi sebagai langkah penting pengendalian tembakau (WHO, 2025b). Kebijakan lain yang juga membantu adalah label gizi di bagian depan kemasan (front-of-pack). Label yang jelas dan mudah dipahami membuat orang lebih cepat memilih makanan yang lebih sehat dan dapat mendorong produsen memperbaiki komposisi produknya (Agroia, 2025).

C. Peran Tenaga Kesehatan dalam Promosi Gaya Hidup Sehat

1. Perawat komunitas/puskesmas

Di tingkat puskesmas dan komunitas, perawat sering menjadi “penggerak lapangan” promosi gaya hidup sehat. Perawat melakukan pengkajian risiko melalui skrining faktor risiko PTM (misalnya tekanan darah, status gizi, gula darah sesuai kewenangan dan program) serta mengarahkan masyarakat ke tindak lanjut yang tepat (BPJS, 2014; WHO, 2020a). Perawat juga berperan kuat dalam edukasi individual–keluarga dan konseling perilaku, membantu orang menetapkan target sederhana yang bisa dilakukan, memantau hambatan, dan memberi penguatan agar perubahan bertahan (Daly et al., 2019; Hasson et al., 2018).

Kegiatan home visit dan pembinaan keluarga penting terutama pada kelompok rentan (lansia, komorbid, atau keterbatasan akses), karena perubahan kebiasaan sering lebih mudah ketika pendampingan dilakukan di konteks rumah tangga. Perawat juga membina kader dan mendampingi kegiatan kelompok seperti Posbindu atau kelompok manajemen penyakit kronis (termasuk Prolanis bila berjalan di wilayah kerja), sehingga edukasi dan pemantauan dapat dilakukan rutin dan berkelanjutan (BPJS, 2014). Pada saat yang sama, literatur mengingatkan bahwa perilaku sehat perawat sendiri memengaruhi kekuatan pesan promosi—keteladanan dan konsistensi menjadi bagian dari kredibilitas di masyarakat (Tong et al., 2023).

2. Dokter

Dokter berperan penting dalam konseling klinis gaya hidup sehat karena masyarakat sering memandang dokter sebagai sumber utama penjelasan medis dan penentu keputusan klinis. Konseling tentang diet, aktivitas fisik, dan berhenti merokok akan lebih kuat ketika dikaitkan dengan kondisi pasien, faktor risiko pribadi, dan target klinis yang terukur. Dokter juga berperan dalam penatalaksanaan faktor risiko (misalnya hipertensi, diabetes, dislipidemia) dan melakukan rujukan ke program perubahan perilaku atau layanan pendukung bila diperlukan (WHO, 2020c).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa konseling promosi kesehatan oleh dokter dipengaruhi oleh keyakinan dan kesiapan dokter sendiri, serta kondisi organisasi dan sistem yang mendukung praktik promosi kesehatan (Kromme et al., 2022). Bahkan, perilaku sehat dokter dapat memperkuat pesan promosi yang disampaikan kepada pasien—dokter yang lebih sehat cenderung menyampaikan pesan promosi kesehatan lebih efektif (Garg et al., 2022). Karena itu, peran dokter tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga memimpin integrasi promosi gaya hidup sehat ke dalam praktik klinis harian (Kromme et al., 2022).

3. Ahli gizi

Ahli gizi memegang peran penting karena merekalah yang membantu masyarakat “menerjemahkan” pesan makan sehat menjadi langkah yang nyata dan bisa dilakukan. Melalui konseling gizi, ahli gizi membantu orang memahami porsi yang sesuai, memilih bahan pangan yang lebih baik, menyusun pola makan harian, serta menyesuaikan diet untuk mencegah dan mengendalikan penyakit kronis (WHO, 2020b). Kegiatan praktis seperti menyusun menu komunitas dan demo masak sehat juga sangat membantu, karena banyak orang lebih mudah belajar dari contoh dan praktik langsung dibandingkan penjelasan teori (Ghosh, 2023).

Di tingkat komunitas, peran ahli gizi dapat diperluas lewat kerja sama dengan sekolah, program pangan lokal, dan edukasi pemilihan pangan sehari-hari, sehingga kebiasaan makan sehat bisa dibangun sebagai budaya bersama (De Souza et al., 2017). Saat ini, promosi makan sehat juga mulai diarahkan agar selaras dengan keberlanjutan pangan, sehingga pilihan makanan bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga lebih ramah lingkungan dan realistis untuk diterapkan (Basfi-Fer et al., 2025). Ahli gizi juga dapat menjadi narasumber utama untuk mengajarkan cara membaca label gizi—termasuk label depan kemasan—agar masyarakat lebih cepat memilih produk yang lebih sehat (WHO, 2019, 2022a).

4. Promotor kesehatan

Promotor kesehatan berperan sebagai penguat sistem dalam promosi gaya hidup sehat. Tugasnya bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menyusun strategi komunikasi yang mudah dipahami, menggerakkan kampanye, dan melakukan advokasi agar lingkungan sosial serta kebijakan ikut mendukung pilihan sehat (Permenkes Nomor 44 Tahun 2018, 2018). Promotor kesehatan dapat memimpin kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menyiapkan materi edukasi yang relevan untuk berbagai kelompok, serta memfasilitasi kerja lintas sektor—misalnya dengan sekolah, pemerintah desa/kelurahan, dan komunitas—agar program tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi benar-benar berjalan dalam aktivitas masyarakat (Kemenkes, 2011). Kebutuhan tenaga terlatih untuk menopang kebijakan sosial juga ditegaskan dalam literatur, karena perubahan gaya hidup akan lebih kuat bila didukung program yang terstruktur dan kebijakan yang konsisten (Turzin et al., 2019).

5. Sanitarian

Sanitarian melengkapi promosi gaya hidup sehat dari sisi kesehatan lingkungan. Perannya membantu memastikan kondisi hidup yang aman dan sehat—mulai dari sanitasi, higiene, air bersih, hingga lingkungan permukiman

yang mendukung pencegahan penyakit (Kemenkes, 2011). Dalam praktik sehari-hari, sanitarian membuat pesan kesehatan menjadi nyata: mendorong kebiasaan cuci tangan, menjaga kebersihan rumah dan fasilitas umum, serta membantu masyarakat membangun lingkungan yang lebih bersih dan aman. WHO juga menekankan pentingnya kebersihan tangan di setting komunitas sebagai langkah efektif untuk menurunkan penularan penyakit (WHO, 2025d).

6. Bidan

Bidan berperan strategis karena mendampingi fase kehidupan yang sangat menentukan kebiasaan kesehatan: masa remaja, kehamilan, nifas, dan pengasuhan awal. Konseling bidan dapat mencakup pola makan sehat selama hamil, aktivitas fisik yang aman, pencegahan anemia dan Kekurangan Energi Kronis (KEK), dukungan kesehatan mental ibu, serta pembiasaan perilaku sehat dalam keluarga (Rohmawati et al., 2020; WHO, 2022c). Bidan juga menjadi pintu masuk penting untuk edukasi “parenting sehat”—mendorong kebiasaan makan, tidur, dan aktivitas yang baik sejak awal kehidupan anak—sehingga promosi gaya hidup sehat bersifat preventif sejak dini (WHO, 2022c).

7. Apoteker

Apoteker memiliki posisi yang sangat dekat dengan masyarakat, terutama di apotek komunitas, sehingga berperan besar dalam edukasi penggunaan obat rasional dan monitoring kepatuhan pada penyakit kronis. Pendekatan ini relevan karena pengendalian PTM bukan hanya soal obat, tetapi juga perubahan kebiasaan yang konsisten—dan apoteker dapat membantu pasien memahami tujuan terapi dan cara penggunaan obat yang benar (Presnell, 2025).

8. Dokter gigi

Dokter gigi berperan penting karena kesehatan mulut tidak berdiri sendiri—ia berkaitan dengan kualitas hidup, status gizi, komunikasi, dan bahkan pengendalian penyakit kronis. WHO menempatkan penyakit mulut sebagai masalah kesehatan masyarakat yang perlu ditangani lebih serius dan diintegrasikan ke layanan kesehatan, termasuk melalui promosi dan pencegahan yang kuat. Dalam praktik promosi gaya hidup sehat, dokter gigi tidak hanya “menambal gigi”, tetapi juga membantu masyarakat membangun kebiasaan yang melindungi kesehatan mulut sejak dini, seperti kebersihan mulut yang benar dan pola konsumsi yang lebih bijak, terutama terkait paparan gula yang berlebihan yang dikenal berkontribusi pada karies (WHO, 2024a).

Selain itu, klinik gigi adalah tempat strategis untuk intervensi faktor risiko bersama. Dokter gigi dapat melakukan edukasi dan konseling singkat terkait berhenti merokok, karena dampak rokok sering tampak jelas pada rongga mulut dan jaringan periodontal. Organisasi kedokteran gigi dunia (FDI) secara khusus

menegaskan peran fundamental praktisi kesehatan gigi dalam mendukung penghentian tembakau, baik di klinik maupun kegiatan komunitas. Arah kebijakan global terbaru juga mendorong kolaborasi lintas profesi dan integrasi layanan kesehatan mulut ke agenda PTM dan cakupan kesehatan semesta, sehingga pesan gaya hidup sehat menjadi lebih utuh—mencakup tubuh dan kesehatan mulut sebagai satu kesatuan (FDI, 2021).

D. Strategi Promosi Gaya Hidup Sehat Berbasis Masyarakat

1. Edukasi dan komunikasi perubahan perilaku

Edukasi yang efektif biasanya tidak berhenti pada “menambah pengetahuan”, tetapi membantu orang mengubah kebiasaan secara bertahap. Di layanan primer dan komunitas, strategi praktis yang sering berhasil adalah konseling singkat yang fokus pada satu-dua target kecil (misalnya kurangi minuman manis, tambah jalan kaki 10–15 menit), lalu diikuti pemantauan dan umpan balik. Pendekatan ini sejalan dengan panduan perubahan perilaku yang menekankan penetapan tujuan, perencanaan, dukungan sosial, serta monitoring sebagai kunci perubahan yang lebih bertahan (NICE, 2014).

Dalam praktik lapangan, motivational interviewing (MI) dapat dipakai saat seseorang “tahu tapi belum siap”. MI membantu tenaga kesehatan menggali alasan personal, hambatan, dan motivasi pasien tanpa menggurui, sehingga perubahan terasa lebih realistis untuk dijalankan (Miller & Rollnick, 2023). Di era digital, edukasi juga dapat diperkuat melalui kelas atau modul interaktif; program edu-komunikasi digital terbukti dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait gaya hidup sehat pada kelompok sasaran tertentu (Caputi et al., 2025). Media sederhana seperti poster, pesan singkat, dan konten WA/IG juga membantu menjaga pesan tetap “hidup”, apalagi bila dibuat dekat dengan konteks lokal dan bahasa sehari-hari (Miller & Rollnick, 2023; NICE, 2014).

2. Pemberdayaan masyarakat

Promosi gaya hidup sehat akan lebih kuat jika komunitas tidak hanya menjadi “sasaran”, tetapi ikut menjadi pelaku. Prinsip ini selaras dengan pendekatan promosi kesehatan yang menekankan partisipasi, kemitraan, dan pemberdayaan—terutama melalui kerja nyata di lingkungan tempat orang hidup (Phourai & Samukkethum, 2023). Contohnya, pelatihan kader dan penguatan kegiatan rutin seperti Posbindu PTM membuat pemantauan faktor risiko dan edukasi bisa berjalan konsisten, tidak bergantung pada kunjungan sesekali. Bentuk pemberdayaan lain misalnya kelas sehat (DM/hipertensi), klub jalan sehat, atau kebun gizi. Kegiatan seperti ini biasanya lebih mudah diterima karena

masyarakat belajar sambil praktik, saling menguatkan, dan melihat contoh langsung di lingkungannya (WHO, 2017).

3. Pendekatan keluarga

Kebiasaan sehat jarang terbentuk sendirian—makan, tidur, aktivitas fisik, bahkan kebiasaan merokok sering dipengaruhi suasana rumah. Karena itu, promosi kesehatan berbasis keluarga menekankan tujuan bersama yang sederhana: misalnya “semua anggota keluarga minum air putih lebih sering” atau “jalan sore bersama 3 kali seminggu”. Pada tahap ini, pendekatan seperti *family-based lifestyle modification*, kontrak perilaku (kesepakatan kecil yang ditulis/diingat bersama), dan monitoring bersama (cek rutin dan saling mengingatkan) membantu perubahan terasa lebih ringan dan tidak “sendirian”. Bukti program keluarga dan jejaring sosial keluarga juga menunjukkan bahwa keterlibatan anggota keluarga dapat menguatkan motivasi dan menjaga konsistensi perubahan (Colineau & Paris, 2011; Linville et al., 2018).

4. Intervensi berbasis sekolah/kerja/tempat ibadah

Strategi berbasis tatanan biasanya efektif karena menyentuh kebiasaan pada rutinitas harian. Di sekolah, pendekatan *health-promoting schools* mendorong sekolah tidak hanya memberi edukasi, tetapi juga membangun lingkungan yang mendukung: kantin lebih sehat, aktivitas fisik terjadwal, serta budaya sekolah yang mendukung perilaku sehat. WHO menekankan standar global agar sekolah menjadi tempat yang sistematis membentuk perilaku sehat (WHO, 2022b).

Di tempat kerja, program promosi kesehatan dapat diarahkan pada hal-hal praktis: jeda aktif, dukungan aktivitas fisik, edukasi gizi, serta dukungan kesehatan mental. Kerangka WHO *Healthy Workplace* menempatkan promosi kesehatan kerja sebagai upaya terencana yang melibatkan kebijakan tempat kerja, lingkungan kerja, dan dukungan bagi pekerja (Burton, 2010).

Tempat ibadah juga dapat menjadi ruang strategis karena punya kekuatan jejaring sosial, keteladanan tokoh, dan kegiatan rutin. Pendekatannya bisa sederhana: pesan sehat yang konsisten, kegiatan komunitas (misalnya jalan sehat bersama), dukungan berhenti merokok, dan praktik kebersihan yang baik.

5. Perubahan lingkungan dan kebijakan

Sering kali orang sudah paham pesan kesehatan, tetapi lingkungannya tidak mendukung. Karena itu, promosi gaya hidup sehat perlu didampingi perubahan yang membuat pilihan sehat menjadi lebih mudah. Contoh yang paling jelas adalah kawasan tanpa rokok: bukan hanya melindungi orang lain dari asap, tetapi juga membantu menurunkan paparan dan menormalisasi lingkungan yang lebih sehat (Sarjiyanto et al., 2026). Kerangka global WHO FCTC menekankan

perlindungan dari paparan asap rokok dan pengendalian promosi tembakau sebagai langkah penting (WHO, 2025b, 2025c). Di Indonesia, regulasi pengamanan produk tembakau juga menjadi payung, sehingga pemerintah daerah dan komunitas punya dasar untuk mendorong lingkungan yang lebih protektif.

Pada aspek pangan, label gizi terutama model yang mudah dipahami di bagian depan kemasan (*front-of-pack*) dipandang WHO sebagai alat kebijakan untuk membantu konsumen memilih lebih sehat. WHO menyediakan policy brief dan pedoman pengembangan/implementasi FOPL, termasuk aspek monitoring-evaluasinya (WHO, 2022a).

6. Pemanfaatan teknologi (*mHealth/telehealth*)

Teknologi sebaiknya dipakai bukan untuk menggantikan interaksi manusia, tetapi untuk memperkuat konsistensi. Pengingat (reminder), edukasi singkat terjadwal, grup WA edukasi, atau “challenge” aktivitas fisik bisa menjadi cara sederhana menjaga motivasi (Caputi et al., 2025; Pasambo et al., 2022). WHO juga telah menerbitkan rekomendasi tentang intervensi digital untuk penguatan sistem kesehatan, yang menegaskan bahwa intervensi digital perlu mempertimbangkan konteks, kualitas implementasi, serta kesiapan layanan (Koepsell, 2019). Pada promosi aktivitas fisik, WHO menegaskan manfaat aktivitas fisik dan pentingnya mengurangi sedentari, sehingga pesan-pesan *mHealth* yang mendorong gerak (misalnya target langkah, pengingat aktivitas) dapat menjadi pelengkap yang berguna bila dikaitkan dengan rutinitas harian komunitas (Bull et al., 2020).

Pemanfaatan teknologi dalam promosi kesehatan dapat terlihat jelas pada aplikasi ponsel untuk aktivitas fisik. Aplikasi semacam ini umumnya menyediakan target langkah, pengingat untuk bergerak saat terlalu lama sedentari, serta umpan balik kemajuan harian atau mingguan. Fitur yang sederhana ini membantu pengguna membangun rutinitas karena perilaku sehat dipandu secara konsisten dan kemajuannya dapat dipantau. Studi uji coba menunjukkan bahwa intervensi berbasis aplikasi dapat meningkatkan aktivitas fisik, terutama ketika target dan umpan balik disajikan secara jelas (Shcherbina et al., 2019).

Teknologi juga dapat digunakan dalam bentuk program yang lebih terstruktur, misalnya program pencegahan diabetes berbasis digital yang memberikan materi bertahap, pencatatan perilaku, dan dukungan pendampingan jarak jauh. Pendekatan ini membantu peserta menjaga konsistensi perubahan gaya hidup dan berkaitan dengan penurunan berat badan dalam periode tindak lanjut tertentu (Toro-Ramos et al., 2020). Selain itu, strategi yang lebih ringan seperti pesan teks terarah (edukasi singkat, pengingat, dan dukungan dua arah)

dapat membantu pengelolaan faktor risiko, termasuk dalam pengendalian tekanan darah, karena informasi dan penguatan perilaku diberikan secara rutin dan dekat dengan rutinitas harian (Cutrona et al., 2025).

E. Simpulan

Promosi gaya hidup sehat tidak cukup hanya dengan memberi penyuluhan atau poster “ayo hidup sehat”. Kebiasaan orang terbentuk dari banyak hal: pengetahuan, motivasi, dukungan keluarga, kebiasaan di lingkungan sekitar, kemudahan akses makanan sehat dan tempat aktivitas fisik, sampai aturan dan kebijakan yang berlaku. Karena itu, upaya promosi yang paling kuat biasanya bukan satu cara saja, melainkan gabungan beberapa cara yang saling menguatkan.

Di tingkat masyarakat, ada beberapa strategi yang bisa berjalan bersama. Edukasi dan komunikasi membantu orang memahami langkah kecil yang bisa dilakukan. Pemberdayaan masyarakat membuat kegiatan lebih hidup karena warga ikut terlibat dan merasa memiliki. Pendekatan keluarga penting karena banyak kebiasaan sehat dimulai dari rumah. Sekolah, tempat kerja, dan tempat ibadah juga strategis karena menjadi bagian dari rutinitas harian. Perubahan lingkungan dan kebijakan membuat pilihan sehat terasa lebih mudah. Teknologi seperti WA group, pesan pengingat, atau telekonseling dapat membantu menjaga semangat dan konsistensi.

Tenaga kesehatan memiliki peran besar agar semua strategi itu benar-benar jalan, bukan hanya rencana. Perawat, dokter, bidan, dokter gigi, ahli gizi, apoteker, promotor kesehatan, dan sanitarian, bisa bekerja saling melengkapi: melakukan skrining risiko, memberi konseling, mendampingi keluarga dan kelompok, sampai menguatkan lingkungan sehat bersama pihak lain. Jika dikerjakan bersama dan konsisten, promosi gaya hidup sehat bisa membantu menurunkan risiko PTM, mencegah masalah kesehatan lain termasuk penyakit menular melalui PHBS, dan membuat komunitas lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kesehatan.

F. Referensi

- Agroia, H. (2025). Exploring Food Label Characteristics, Accessibility, and Regulation in an Era of Technological Advancements and Shifting Consumer Needs. In *Nutrition and Health (United Kingdom): Vol. Part F1022* (pp. 269–294). Humana Press. https://doi.org/10.1007/978-3-031-95373-6_12
- Amalia, R., & Kismiantini, K. (2022). Analysis of the effect of smoking and exercise habits on coronary heart disease in Indonesia using logistic regression. In B. Somerkoski, S. null, A. M. Abadi, H. Retnawati, D. U. Wutsqa, H. null, E. Retnowati, S. null, S. Andayani, K. null, & W. Setyaningrum (Eds.), *AIP*

- Conference Proceedings* (Vol. 2575). American Institute of Physics Inc. <https://doi.org/10.1063/5.0111575>
- Ashe, M., Graff, S., & Spector, C. (2011). Changing places: Policies to make a healthy choice the easy choice. *Public Health*, 125(12), 889–895. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2011.04.010>
- Basfi-Fer, K., Molina, P., Barrera, C., Cabezas, R., & Cáceres, P. (2025). Contribution of the dietitian nutritionist to food sustainability: guidelines for its incorporation in the formation. *Revista Chilena de Nutricion*, 52(1), 83–90. <https://doi.org/10.4067/s0717-75182025000100083>
- BPJS. (2014). PROLANIS (Program Pengelolaan Penyakit Kronis). In *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*.
- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., DiPietro, L., Ekelund, U., Firth, J., Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), 1451–1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Burton, J. (2010). *WHO Healthy Workplace Framework and Model: Background and Supporting Literature and Practices*. WHO Library.
- Caputi, J. C. U., Chinchilla, D. M. D., Martínez, R. O., Rodríguez, R. A. P., & Carreño, N. A. (2025). Routed people: A Digital Edu-communication Strategy to Promote Healthy Lifestyles in Older Adults. *Revista Cubana de Informacion En Ciencias de La Salud*. <https://www.scopus.com/pages/publications/105010655963?origin=scopusAI>
- CDC. (2024, May). *FastStats: Sleep in Adults*. Cdc.Gov. https://www.cdc.gov/sleep/data-research/facts-stats/adults-sleep-facts-and-stats.html?utm_source=chatgpt.com
- Chaloupka, F. J., & Powell, L. M. (2009). Price, availability, and youth obesity: Evidence from bridging the gap. *Preventing Chronic Disease*, 6(3). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70149125302&partnerID=40&md5=cf6556c308d780548eb8150a0dc89e4d>
- Colineau, N., & Paris, C. (2011). Motivating reflection about health within the family: The use of goal setting and tailored feedback. *User Modeling and User-Adapted Interaction*, 21(4–5), 341–376. <https://doi.org/10.1007/s11257-010-9089-x>

- Cutrona, S. L., McDannold, S. E., DeLaughter, K. L., Fix, G. M., Shimada, S. L., Bokhour, B. G., Gordon, H. S., Pope, C., Smith, B. M., Ndiwane, N., Gardner, J., DeFelice, D. C., Bal, E. S., & Long, J. A. (2025). Text Messaging and Video Stories to Support Hypertension Self-Management in Black Veterans: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Network Open*, 8(11), e2541342–e2541342. <https://doi.org/10.1001/JAMANETWORKOPEN.2025.41342>
- Daly, L., Byrne, G., & Keogh, B. (2019). Contemporary considerations relating to health promotion and older people. *British Journal of Nursing (Mark Allen Publishing)*, 28(21), 1414–1419. <https://doi.org/10.12968/BJON.2019.28.21.1414>
- D'Angelo, H., Evenson, K. R., Rose, S. W., Fleischhacker, S., Myers, A. E., & Ribisl, K. M. (2015). Examination of community and consumer nutrition, tobacco and physical activity environments at food and tobacco retail stores in three diverse North Carolina communities. *Preventive Medicine Reports*, 2, 730–736. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2015.08.018>
- De Souza, A. A., Bezerra, O. M. D. P. A., Bonomo, E., & Da Silva, C. A. M. (2017). Actions of nutritionists as the technicians responsible for school food in municipalities in the states of Minas Gerais and Espírito Santo. *Ciencia e Saude Coletiva*, 22(2), 593–606. <https://doi.org/10.1590/1413-81232017222.12272016>
- FDI. (2021). *The Role of Oral Health Practitioners in Tobacco Cessation* / FDI. FDI World Dental Federation. https://www.fdiworldddental.org/role-oral-health-practitioners-tobacco-cessation?utm_source=chatgpt.com
- Garg, R., Agrawal, P., Singh, A. P., Agrawal, M., & Gupta, P. (2022). Glimpse into the Lifestyle of Doctors. *Journal of Mid-Life Health*, 13(2), 115–120. https://doi.org/10.4103/JMH.JMH_201_21
- Ghosh, D. (2023). Evidence-based nutrition communication: opportunities and challenges. In *Nutrition Science, Marketing Nutrition, Health Claims, and Public Policy* (pp. 5–12). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85615-7.00002-1>
- Hasson, R., Stark, A. H., Constantini, N., Polak, R., Verbov, G., Edelstein, N., Lachmi, M., Cohen, R., Maoz, S., Daoud, N., Soltz-Aharony, H., & Stein-Zamir, C. (2018). "Practice What You Teach" Public Health Nurses Promoting Healthy Lifestyles (PHeeL-PHiNe): Program Evaluation. *The Journal of Ambulatory Care Management*, 41(3), 171–180. <https://doi.org/10.1097/JAC.0000000000000243>
- Hsu, W.-C. (2025). Mediation effects of health behavior efficacy on the relationship between individual factors and health literacy among older adult populations. *Educational Gerontology*. <https://doi.org/10.1080/03601277.2025.2605105>

- Joseph, P., Davis, A. D., Miller, R., Hill, K., McCarthy, H., Banerjee, A., Chow, C., Mente, A., & Anand, S. S. (2012). Contextual determinants of health behaviours in an aboriginal community in Canada: Pilot project. *BMC Public Health*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-952>
- Kamal, M. F. H. A., Mariot, M., Rosle, N. H., Muthu, K. T., Dapari, R., Hassan, M. R., Dom, N. C., & Rahim, S. S. S. A. (2024). Factors Associated With Knowledge and Awareness on Smoke-Free Policy at Food Premises: A Systematic Review. *Malaysian Journal of Public Health Medicine*, 24(2), 251–260. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85204677856&partnerID=40&md5=97b79aac43237732b1a6c20cb467a795>
- Kemenkes. (2011). Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). In *Kementerian Kesehatan RI*.
- Kim, M. K., Lee, H. R., Kwon, J. Y., & Oh, H. S. (2013). Influencing and mediating factors in health behaviors among stroke patients. *Korean Journal of Adult Nursing*, 25(6), 610–621. <https://doi.org/10.7475/kjan.2012.24.6.610>
- Koepsell, J. (2019). *Recommendations on digital interventions for health system strengthening*. World Health Organization.
- Kok, G., & de Vries, N. K. (2015). Health Education and Health Promotion. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (pp. 620–627). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.92055-5>
- Kolip, P. (2016). Primary prevention and health promotion: Towards gender-sensitive interventions. In *The Palgrave Handbook of Gender and Healthcare* (pp. 337–354). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230290334_21
- Kromme, N. M. H., Ahaus, K. T. B., Gans, R. O. B., & van de Wiel, H. B. M. (2022). Internists' ambivalence toward their role in health counseling and promotion: A qualitative study on the internists' beliefs and attitudes. *PLOS ONE*, 17(9), e0273848. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273848>
- Linville, D., Savercool, V., Barrera, S., Mintz, B., & Shune, S. (2018). Qualitative perspectives on a family group intervention program for improving physical wellness. *Journal of Family Psychotherapy*, 29(3), 252–273. <https://doi.org/10.1080/08975353.2018.1440098>
- Marcellus, L., Pauly, B., Martin, W., Revai, T., Easton, K., & MacDonald, M. (2022). Navigating conflicting value systems: a grounded theory of the process of public health equity work in the context of mental health promotion and prevention of harms of substance use. *BMC Public Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12627-w>

- Miller, W. R. ., & Rollnick, Stephen. (2023). *Motivational interviewing : helping people change and grow*. The Guilford Press. https://www.guilford.com/books/Motivational-Interviewing/Miller-Rollnick/9781462552795?srsId=AfmBOoqhQAcP23rnCyrfC0hPvkG6jqbrF4aeoIAd5p5RpRC05yEFiT5F&utm_source=chatgpt.com
- Møller, A., & Merrild, C. H. (2020). Exploring targeted preventive health checks in a socially disadvantaged neighborhood in Denmark. *Health Promotion International*, 35(5), 1150–1158. <https://doi.org/10.1093/heapro/daz110>
- NICE. (2014). Behaviour change: individual approaches. In *National Institute Health and Care Excellence*. www.nice.org.uk/guidance/ph49
- Nurwanti, E., Hadi, H., Chang, J.-S., Chao, J. C.-J., Paramashanti, B. A., Gittelsohn, J., & Bai, C.-H. (2019). Rural–urban differences in dietary behavior and obesity: Results of the riskesdas study in 10–18-year-old Indonesian children and adolescents. *Nutrients*, 11(11). <https://doi.org/10.3390/nu11112813>
- Oli, N., Vaidya, A., Rijal, D., Suwal, P. S., & Maharjan, B. (2025). Study of Neighborhood environment for Cardiovascular Health in a Squatter Area in Nepal. *Kathmandu University Medical Journal*, 23(2), 33–39. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105011294034&partnerID=40&md5=081271f5d77af31186c5dabaef7e0a55>
- Pasambo, Y., Tamunu, E. N., Runtulalo, F., Sarimin, D. S., & Desyani, J. (2022). Exclusive Breastfeeding Support Methods for Pregnant and Breastfeeding Mothers Using Technology. *Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(G), 154–159. <https://doi.org/10.3889/OAMJMS.2022.8365>
- Permenkes Nomor 44 Tahun 2018, Pub. L. No. 1297, 2018, Kementerian Kesehatan RI (2018).
- Phourai, P., & Samukkethum, S. (2023). Community Empowerment and Health Promotion: A Case Study of Phongsathue Community in Thailand. *GMSARN International Journal*. <https://www.scopus.com/pages/publications/85145817313?origin=scopusAI>
- Presnell, A. (2025). The Role of the Pharmacist in Clinical Scenarios. In *The Pharmacist's Pocket Guide for Diabetes and Obesity: Practical Strategies, Tips, and Considerations* (pp. 343–353). Springer Science+Business Media. https://doi.org/10.1007/978-3-031-88835-9_16
- Purwaningsih, N. A., & Solikhah, S. (2020). Smoking habits, stress, and physical activity in relation to diabetes mellitus: A nationwide study in Indonesia. *Journal of Kerman University of Medical Sciences*, 27(5), 380–388. <https://doi.org/10.22062/JKMU.2020.91470>

- Rangan, V. (2024). Influence of social factors on health behavior. In *Behavioral Economics and Neuroeconomics of Health and Healthcare* (pp. 153–180). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6055-2.ch008>
- Rice, E. L., & Klein, W. M. P. (2019). Interactions among perceived norms and attitudes about health-related behaviors in U.S. adolescents. *Health Psychology, 38*(3), 268–275. <https://doi.org/10.1037/hea0000722>
- Rifqi, M. A., Puspikawati, S. I., Salisa, W., & Zaman, M. N. U. (2025). Sweet Sweetened Beverages Intake and Sedentary Behavior Drive Overweight Trends: A Study of Urban and Rural Adolescents in East Java, Indonesia. *Amerta Nutrition, 9*(1), 34–44. <https://doi.org/10.20473/amnt.v9i1.2025.34-44>
- Rohmawati, N., Agusfar, A. Z., Amelia, D., Restianingrum, M., Damayanti, R., Mudjiati, I., Milwiyandia, Mangaweang, L. R., Helena, K., Simatupang, M. T., Levina, L., Yudopuspito, T., Karolina, S., Sari, D. M., Bahar, A., Liyanto, E., Syahrizal, B. M., Widowati, K., Hermawan, L. C., ... Adhi, E. K. S. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu* (3rd ed.). Kementerian Kesehatan RI. <https://repository.kemkes.go.id/book/147>
- Rosmiati, R., Haryana, N. R., Firmansyah, H., & Purba, R. (2023). Dietary Patterns, Physical Activity, and Obesity among Indonesian Urban Workers. *Amerta Nutrition, 7*(2SP), 164–170. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i2SP.2023.164-170>
- Sarjiyanto, S., Sarwoto, S., Dio, P. E., Kadir, J. A., & Firdaus, R. B. R. (2026). The Role of Community Empowerment as Mediator on the Relationship Between Psychological, Social, and Financial Capital on Rural Community Well-Being. *Journal of Population and Social Studies, 34*, 99–117. <https://doi.org/10.25133/JPSSv342026.006>
- Scott, C., & Morgan, K. (2023). Motivation; The Self, The Stick, and The Carrot. In *Routledge International Handbook of Positive Health Sciences: Positive Psychology and Lifestyle Medicine Research, Theory and Practice* (pp. 282–295). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003378426-21>
- Selestrin, Z. (2021). Relationship Between Prevention of Mental, Emotional and Behavioral Problems And Promotion of Mental Health. *Kriminologija and Socijalna Integracija, 29*(2), 248–267. <https://doi.org/10.31299/ksi.29.2.3>
- Shcherbina, A., Hershman, S. G., Lazzeroni, L., King, A. C., O'Sullivan, J. W., Hekler, E., Moayedi, Y., Pavlovic, A., Waggott, D., Sharma, A., Yeung, A., Christle, J. W., Wheeler, M. T., McConnell, M. V., Harrington, R. A., & Ashley, E. A. (2019). The effect of digital physical activity interventions on daily step count: a randomised controlled crossover substudy of the MyHeart Counts Cardiovascular Health Study. *The Lancet Digital Health, 1*(7), e344–e352. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(19\)30129-3](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(19)30129-3)

- Soroya, S. H., Rehman, A. U., & Faiola, A. (2024). Exploring the impact of Internet and media sources exposure on self-care behavior: mediating the role of health anxiety, literacy and information-seeking behavior. *Kybernetes*, 53(11), 4797–4817. <https://doi.org/10.1108/K-06-2023-1003>
- Suhito, H. P., Azam, M., & Ningrum, D. N. A. (2025). Clustering Community Risk Behaviors for Non-Communicable Diseases in Indonesia: Based on Indonesian Health Survey Data. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 21(3), 225–235. <https://doi.org/10.30597/mkmi.v21i3.45641>
- Tong, S. W., Chui, P. L., Chong, M. C., Tang, L. Y., & Chan, C. M. H. (2023). Health-promoting behaviours and perceived lifestyle cancer risk factors among nurses. *Collegian*, 30(1), 32–38. <https://doi.org/10.1016/J.COLEGN.2022.06.011>
- Toro-Ramos, T., Michaelides, A., Anton, M., Karim, Z., Kang-Oh, L., Argyrou, C., Loukaidou, E., Charitou, M. M., Sze, W., & Miller, J. D. (2020). Mobile Delivery of the Diabetes Prevention Program in People With Prediabetes: Randomized Controlled Trial. *JMIR MHealth and UHealth*, 8(7). <https://doi.org/10.2196/17842>
- Turzin, P. S., Gurylina, M. V., Aksenova, E. I., Khodyreva, L. A., Bogdan, I. V., & Chistyakova, D. P. (2019). Creating Organizational Conditions for Healthy Lifestyle Formation Among Population. *Problemy Sotsial'noi Gigieny, Zdravookhraneniia i Istorii Meditsiny*, 27(Issue), 704–709. <https://doi.org/10.32687/0869-866X-2019-27-si1-704-709>
- WHO. (2017, October). *WHO community engagement framework for quality, people-centred and resilient health services*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2017.15?utm_source=chatgpt.com
- WHO. (2019, May). *Guiding principles and framework manual for front-of-pack labelling for promoting healthy diets*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/m/item/guidingprinciples-labelling-promoting-healthydiet?utm_source=chatgpt.com
- WHO. (2020a). *WHO Package of Essential Noncommunicable (PEN) Disease Interventions for Primary Health Care*. World Health Organization; World Health Organization. [https://www.who.int/publications/i/item/who-package-of-essential-noncommunicable-\(pen\)-disease-interventions-for-primary-health-care](https://www.who.int/publications/i/item/who-package-of-essential-noncommunicable-(pen)-disease-interventions-for-primary-health-care)
- WHO. (2020b, April). *Healthy diet*. World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet?utm_source=chatgpt.com
- WHO. (2020c, July). *HEARTS: Technical package for cardiovascular disease management in primary health care: Risk-based CVD management*.

- World Health Organization.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240001367?utm_source=chatgpt.com
- WHO. (2020d, November). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. World Health Organization.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128?utm_source=chatgpt.com
- WHO. (2022a). Nutrition Labelling. In *World Health Organization*. World Health Organization.
- WHO. (2022b). *Roadmap for Implementation of Health Promoting Schools in the South-East Asia Region*. World Health Organization.
<https://iris.who.int/handle/10665/361939>
- WHO. (2022c). *WHO recommendations on*. WHO Recommendations on Maternal and Newborn Care for a Positive Postnatal Experience.
- WHO. (2024a). *Global strategy and action plan on oral health 2023–2030*. World Health Organization.
- WHO. (2024b, October). *Determinants of health*. World Health Organization.
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/determinants-of-health?utm_source=chatgpt.com
- WHO. (2025a). *Mental health*. World Health Organization.
https://www.who.int/health-topics/mental-health?utm_source=chatgpt.com#tab=tab_1
- WHO. (2025b). *WHO report on the global tobacco epidemic, 2025*.
<https://iris.who.int/>.
- WHO. (2025c, June). *Tobacco*. World Health Organization.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco?utm_source=chatgpt.com
- WHO. (2025d, October 15). *Guidelines on hand hygiene in community settings*. World Health Organization.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240116559?utm_source=chatgpt.com
- Yau, S. Y. (2023). Exploring Socio-Cultural Influences on Active Transportation Behaviour for Health Improvement. In *Gaps and Actions in Health Improvement from Hong Kong and Beyond: All for Health* (pp. 213–221). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-99-4491-0_14

CHAPTER 4

PERAN KEBIDANAN DALAM PENCEGAHAN MASALAH KESEHATAN IBU DAN ANAK

Dr. Bd. Silvia Nova, SST., M.Kes

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan indikator kualitas pembangunan manusia sekaligus cerminan ketahanan sistem kesehatan. Kesehatan ibu dan anak masih merupakan tantangan yang besar karena berkaitan langsung dengan keselamatan nyawa, kualitas tumbuh kembang anak, serta ketahanan keluarga. Terdapatnya komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan periode neonatal yang sebenarnya dapat dicegah dan ditemukan lebih dini bila pelayanan kesehatan diberikan secara berkesinambungan (*continuum of care*), berbasis bukti dan berpusat pada perempuan serta keluarga. Dalam konteks inilah kebidanan memegang peran strategis asuhan kebidanan bukan hanya sekedar pertolongan persalinan, tetapi merupakan layanan yang komprehensif sejak pra-kehamilan hingga minggu awal kehidupan bayi (Midwives, 2023).

Terdapatnya komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan periode neonatal yang sebenarnya dapat dicegah dan ditemukan lebih dini bila pelayanan kesehatan diberikan secara berkesinambungan (*continuum of care*), berbasis bukti dan berpusat pada perempuan serta keluarga. Dalam konteks inilah kebidanan memegang peran strategis asuhan kebidanan bukan hanya sekedar pertolongan persalinan, tetapi merupakan layanan yang komprehensif sejak pra-kehamilan hingga minggu awal kehidupan bayi. Strategi global juga menekankan sasaran "*survive, thrive, and transform*" bagi perempuan, anak, dan remaja, yang menempatkan kualitas layanan dan pemenuhan hak kesehatan sebagai fondasi pembangunan (World Health Organization 2019).

Peran ini menjadi semakin penting karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa cakupan intervensi kebidanan yang luas berkontribusi besar pada penurunan kematian dan morbiditas. Analisis *Lives Saved Tool* dalam *The Lancet* memperkirakan bahwa perluasan layanan kebidanan yang mencakup keluarga berencana serta intervensi esensial maternal neonatal berpotensi mencegah proporsi besar kematian ibu, kematian neonatal, dan lahir mati. Sejalan dengan laporan *State of the World's Midwifery 2021* (UNFPA-WHO-ICM) menekankan bahwa bidan dapat memberikan sebagian besar intervensi esensial kesehatan

seksual, reproduksi, maternal, neonatal, dan remaja apabila bekerja dalam sistem yang mendukung pendidikan, regulasi, lingkungan kerja, serta jejaring rujukan yang efektif (United Nations Population Fund 2021).

Dengan demikian, kebidanan sangat berperan sebagai tulang punggung masalah KIA melalui layanan komprehensif lintas siklus reproduksi. Dengan pendekatan promotif dan preventif, deteksi dini yang secara sistematis, serta koordinasi rujukan yang efektif. Ketika kualitas pendidikan kebidanan, standar praktik, dan dukungan sistem kesehatan diperkuat dampaknya tidak hanya menurunkan kematian dan kesakitan. Namun dapat meningkatkan pengalaman melahirkan, kesejahteraan keluarga, dan kualitas generasi masa depan (Deni E, Dewi H, Siti Mar'atus S 2021).

B. Kebidanan sebagai pilar *continuum of care* dan layanan primer KIA

Pencegahan masalah kesehatan ibu dan anak (KIA) akan lebih efektif apabila layanan diberikan secara berkesinambungan sejak masa pra-kehamilan, selama kehamilan (antenatal), persalinan (intrapartum), masa nifas (postnatal), hingga perawatan bayi baru lahir dan periode awal kehidupan anak. Dalam rangkaian layanan tersebut, bidan menempati posisi sentral sebagai tenaga kesehatan kunci. Praktik kebidanan tidak hanya berfokus pada pertolongan persalinan, tetapi juga mencakup promosi kesehatan, pencegahan komplikasi, deteksi dini faktor risiko, tatalaksana awal sesuai kewenangan, serta rujukan yang tepat waktu ketika ditemukan kondisi gawat atau membutuhkan penanganan lanjutan. Sejalan dengan itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa penguatan kualitas layanan kebidanan merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan keselamatan ibu dan bayi serta memperbaiki luaran kesehatan maternal dan neonatal (World Health Organization n.d.)

Peran tersebut juga ditegaskan secara profesional melalui definisi dan lingkup praktik bidan yang dirumuskan oleh International Confederation of Midwives (ICM). ICM menempatkan bidan sebagai mitra perempuan dan keluarga, yang memberikan asuhan aman, bermartabat, berbasis bukti, serta berpusat pada kebutuhan perempuan sepanjang siklus reproduksi dan kesehatan maternal neonatal. Di Indonesia, penguatan peran dan praktik kebidanan ditopang oleh kerangka hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Undang-undang ini menegaskan bahwa praktik kebidanan merupakan pelayanan asuhan kebidanan yang diselenggarakan oleh bidan sesuai dengan kompetensi, standar profesi, dan kewenangan yang ditetapkan (Undang Undang Republik Indonesia 2019).

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa kebidanan memiliki dampak strategis terhadap luaran kesehatan ibu dan anak (KIA). Analisis yang dipublikasikan dalam *The Lancet* memperkirakan bahwa perluasan layanan kebidanan termasuk pelayanan keluarga berencana serta berbagai intervensi maternal dan neonatal berpotensi mencegah sebagian besar kematian ibu, kematian neonatal, dan kejadian lahir mati. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan peran bidan bukan semata-mata isu profesi, melainkan investasi sistem kesehatan yang memiliki daya ungkit tinggi untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup ibu serta anak (Nove et al. 2021).

C. Peran bidan pada fase pra-kehamilan dan perencanaan keluarga (pencegahan primer)

Pencegahan masalah kesehatan ibu dan anak (KIA) idealnya dimulai bahkan sebelum terjadinya konsepsi. Pada fase pra-kehamilan, bidan berperan penting dalam menyiapkan perempuan dan keluarga agar memasuki kehamilan dalam kondisi sehat, aman, dan terencana. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa langkah utama (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015). Pertama, bidan memberikan konseling prakonsepsi sekaligus melakukan skrining faktor risiko. Skrining ini mencakup riwayat penyakit kronis, status gizi, anemia, kesehatan mental, pengalaman kekerasan berbasis gender, penggunaan zat, serta berbagai faktor sosial yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin. Dengan penapisan yang tepat, faktor risiko dapat dikenali lebih dini sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan sebelum kehamilan berlangsung. Kedua, bidan mendampingi perencanaan kehamilan melalui pelayanan keluarga berencana. Upaya ini bertujuan mencegah kehamilan berisiko misalnya kehamilan pada usia terlalu muda, jarak kehamilan terlalu dekat, jumlah kehamilan terlalu banyak, atau kehamilan pada usia terlalu tua yang semuanya berkaitan dengan meningkatnya risiko komplikasi maternal dan neonatal. Perencanaan yang baik membantu keluarga mempersiapkan kehamilan secara lebih matang, termasuk aspek kesehatan, psikososial, dan kesiapan ekonomi. Ketiga, bidan berperan dalam mempromosikan perilaku hidup sehat sebagai fondasi kehamilan yang berkualitas. Promosi ini meliputi edukasi gizi seimbang, aktivitas fisik yang sesuai kondisi, dukungan psikososial, serta pengendalian faktor risiko melalui perubahan perilaku dan rujukan bila diperlukan. Pendekatan ini menempatkan pencegahan sebagai inti layanan, bukan sekadar respons saat komplikasi sudah terjadi.

Hal tersebut sejalan dengan laporan *State of the World's Midwifery 2021* yang menegaskan bahwa bidan mampu memberikan sebagian besar intervensi esensial

dalam layanan SRMNAH (*sexual, reproductive, maternal, newborn, and adolescent health*), terutama apabila didukung oleh regulasi yang kuat, pendidikan yang memadai, lingkungan kerja yang aman, serta sistem rujukan yang efektif. Dengan dukungan sistem yang tepat, kontribusi kebidanan pada pencegahan masalah KIA menjadi semakin optimal dan berdampak luas (Nove et al. 2021).

D. Peran bidan pada masa kehamilan (ANC) untuk deteksi dini dan pencegahan komplikasi

Pada masa antenatal, bidan menjalankan fungsi sebagai pencegahan primer dan sekunder melalui asuhan yang berpusat pada perempuan. Asuhan ini tidak hanya berfokus pada pemantauan kondisi kehamilan, tetapi juga menekankan upaya menjaga kesehatan, mengenali risiko sejak dini, serta mencegah terjadinya komplikasi. Pedoman WHO tentang pelayanan antenatal (*antenatal care/ANC*) menegaskan pentingnya paket layanan yang komprehensif, mencakup promosi kesehatan, penapisan dan penilaian faktor risiko, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kualitas pengalaman kehamilan agar ibu merasa aman, dihargai, dan didukung sepanjang prosesnya. Salah satu pembaruan penting dalam pedoman tersebut adalah rekomendasi minimal delapan kali kontak ANC. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peluang deteksi dini masalah, memperkuat kesinambungan asuhan, serta memastikan ibu memperoleh layanan dan informasi yang memadai pada setiap tahap kehamilan. Dengan lebih banyak kesempatan kontak, bidan dapat memberikan edukasi yang lebih terarah, memantau perubahan kondisi secara lebih cermat, dan mengambil keputusan rujukan secara lebih tepat waktu bila diperlukan (Devie Ismayanty 2024).

Ruang lingkup peran bidan dalam pelayanan antenatal (ANC) untuk mencegah masalah kesehatan ibu dan anak (KIA) mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan dilakukan secara berkelanjutan. Pertama, bidan melakukan skrining dan pemantauan rutin untuk mendeteksi risiko sedini mungkin. Kegiatan ini meliputi pengukuran tekanan darah dan penilaian tanda-tanda yang mengarah pada preeklamsia, pemantauan status gizi dan anemia, skrining infeksi sesuai kebijakan setempat, serta pemantauan kondisi ibu dan janin sesuai standar pelayanan. Kedua, bidan memberikan konseling dan edukasi berkesinambungan sebagai bagian penting dari pencegahan. Edukasi meliputi pengenalan tanda bahaya kehamilan, kesiapsiagaan persalinan dan kemungkinan komplikasi, penyusunan rencana rujukan, serta penguatan dukungan psikososial agar ibu dan keluarga lebih siap mengambil keputusan ketika menghadapi kondisi darurat. Ketiga, bidan berperan dalam pencegahan masalah gizi dan anemia melalui edukasi

pola makan yang sesuai, penguatan kepatuhan terhadap suplementasi berdasarkan protokol yang berlaku, serta pemantauan berkala untuk memastikan intervensi berjalan efektif. Keempat, bidan melakukan penilaian faktor risiko sosial yang kerap menjadi akar keterlambatan dalam mencari pertolongan. Penilaian ini mencakup akses transportasi, dukungan keluarga, potensi kekerasan, serta hambatan biaya dan aspek lain yang dapat menghambat ibu memperoleh layanan tepat waktu. Melalui pendekatan tersebut, bidan berfungsi sebagai *penjaga gerbang (gatekeeper)* keselamatan maternal dan janin: bukan hanya mengidentifikasi risiko, tetapi juga memastikan keputusan klinis, tindak lanjut, dan proses rujukan berlangsung cepat, tepat, serta terkoordinasi dengan baik (Siti F, Mustika P 2022).

E. Peran bidan saat persalinan (inpartu) pencegahan kegawatdaruratan dan asuhan bermartabat

Fase intrapartum merupakan periode yang paling kritis bagi keselamatan ibu dan bayi. Pada tahap inilah perubahan fisiologis berlangsung cepat, dan komplikasi dapat muncul secara mendadak sehingga membutuhkan kewaspadaan serta respons yang tepat. WHO menerbitkan pedoman *Intrapartum care for a positive childbirth experience* yang menekankan pentingnya asuhan berbasis bukti, pengurangan intervensi yang tidak perlu, serta penghormatan terhadap martabat dan preferensi perempuan selama proses persalinan. Dalam pedoman tersebut, bidan memegang peran penting dalam pencegahan masalah kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui praktik asuhan yang aman, terstandar, dan berpusat pada perempuan (World Health Organization 2018).

Pertama, bidan melakukan pemantauan kemajuan persalinan serta deteksi dini komplikasi. Pemantauan ini mencakup penilaian kondisi ibu dan janin secara berkala, termasuk kewaspadaan terhadap risiko perdarahan, tanda infeksi, gawat janin (*fetal distress*), serta indikasi obstruksi persalinan. Deteksi dini memungkinkan tindakan klinis awal dan pengambilan keputusan rujukan dilakukan tanpa keterlambatan. Kedua, bidan berperan dalam pencegahan perdarahan pascapersalinan melalui penerapan praktik berbasis bukti. Upaya ini antara lain dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen kala III yang tepat dan pemberian uterotonika sesuai pedoman. Pedoman WHO mengenai pencegahan dan tatalaksana perdarahan pascapersalinan menegaskan bahwa intervensi pencegahan oleh tenaga kesehatan terampil merupakan komponen kunci untuk menurunkan risiko kematian dan morbiditas maternal. Ketiga, bidan membantu mencegah trauma serta mengurangi intervensi yang tidak diperlukan melalui dukungan persalinan yang tepat. Dukungan ini mencakup komunikasi yang efektif,

pendampingan yang menenangkan, serta pengambilan keputusan klinis yang rasional berdasarkan kondisi ibu dan janin. Dengan demikian, asuhan dapat berlangsung aman tanpa menambah risiko akibat tindakan yang tidak sesuai indikasi.

Keempat, bidan memastikan terlaksananya asuhan persalinan yang menghormati (*respectful maternity care*). Praktik ini mencakup pemberian informasi yang jelas dan *informed consent*, penghormatan terhadap privasi, dukungan pendamping persalinan sesuai kebutuhan, serta penciptaan pengalaman persalinan yang positif. Asuhan yang menghormati tidak hanya meningkatkan kepuasan dan kepercayaan ibu, tetapi juga berkontribusi pada kepatuhan terhadap asuhan lanjutan pada masa nifas dan perawatan bayi baru lahir (Tutik I, Ika E 2024).

F. Peran bidan pada masa nifas dan bayi baru lahir (postnatal neonatal) mencegah kematian dan masalah jangka panjang

Periode setelah persalinan merupakan fase yang rentan bagi ibu dan bayi. Pada masa ini, berbagai komplikasi pada ibu seperti perdarahan, infeksi, maupun gangguan kesehatan mental sering muncul dalam beberapa hari pertama. Demikian pula pada bayi baru lahir, masalah seperti hipotermia, infeksi, kesulitan menyusui, dan asfiksia dapat terjadi dan berkembang cepat apabila tidak dikenali serta ditangani sejak dini. Karena itu, WHO menekankan pentingnya layanan postnatal esensial untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi sekaligus membangun “pengalaman postnatal yang positif”, yaitu masa pemulihan yang aman, didukung, dan bermartabat bagi ibu serta keluarga.

Pada bayi baru lahir, WHO merangkum konsep *essential newborn care* yang mencakup tindakan-tindakan dasar tetapi sangat menentukan kelangsungan hidup. Komponen utamanya meliputi pengeringan segera dan penilaian napas, kontak kulit ke kulit, inisiasi menyusui dini, perawatan termal untuk mencegah hipotermia, pencegahan infeksi, serta rujukan segera apabila ditemukan tanda bahaya. Salah satu praktik yang sangat ditekankan adalah inisiasi menyusui dini dalam satu jam pertama. WHO merekomendasikannya karena praktik ini terbukti melindungi bayi dari infeksi dan menurunkan risiko kematian neonatal, sekaligus memperkuat keberlanjutan pemberian ASI, termasuk peluang keberhasilan ASI eksklusif.

Selain itu, bidan juga berperan dalam penerapan praktik berbasis bukti lainnya, seperti penundaan penjepitan tali pusat (*delayed cord clamping*). WHO merekomendasikan penjepitan tali pusat dilakukan tidak lebih awal dari satu menit setelah bayi lahir, karena berkaitan dengan luaran kesehatan yang lebih baik bagi bayi, serta mendukung transisi fisiologis yang lebih stabil pada awal kehidupan. Bagi

bayi prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), WHO merekomendasikan *Kangaroo Mother Care* (KMC) sebagai perawatan rutin. Pedoman terbaru menekankan bahwa KMC sebaiknya dilakukan selama mungkin, yakni sekitar 8 hingga 24 jam per hari, sesuai kondisi ibu dan bayi serta ketersediaan dukungan. Panduan praktik klinis WHO juga menegaskan pentingnya peran tenaga kesehatan, termasuk bidan, dalam memastikan KMC dapat diimplementasikan dengan baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di rumah melalui edukasi, pendampingan, dan pemantauan berkelanjutan (World Health Organization Special Programme of Research 2022).

Pada masa nifas, fokus pencegahan yang dilakukan bidan diarahkan untuk memastikan proses pemulihan ibu berlangsung aman, mendeteksi dini tanda bahaya, serta mencegah komplikasi yang dapat muncul pada hari-hari awal setelah persalinan. Upaya tersebut meliputi beberapa aspek utama. Pertama, bidan melakukan pemantauan kondisi fisik ibu secara teratur, termasuk jumlah dan karakter perdarahan, proses involusi uterus, tanda-tanda infeksi, serta kondisi umum ibu (misalnya suhu tubuh, keluhan nyeri, dan tanda dehidrasi atau anemia). Pemantauan ini penting untuk mengenali komplikasi lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan segera.

Kedua, bidan memberikan dukungan menyusui dan pendampingan perawatan diri. Dukungan ini mencakup teknik menyusui yang benar, penanganan masalah menyusui, perawatan luka atau perineum (bila ada), serta edukasi kebersihan diri untuk mencegah infeksi. Pada periode ini, bidan juga melakukan konseling keluarga berencana (KB) pascapersalinan agar pasangan dapat memilih metode yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan, serta rencana reproduksi. Ketiga, bidan melakukan skrining kesehatan mental pascapersalinan dan memperkuat dukungan keluarga. Perubahan hormon, kelelahan, tekanan pengasuhan, serta faktor sosial dapat meningkatkan risiko gangguan mental postpartum. Karena itu, bidan berperan mengenali gejala awal, memberikan dukungan psikososial, serta mendorong keterlibatan keluarga sebagai sistem pendukung utama. Keempat, bidan memastikan adanya kunjungan ulang dan rujukan apabila ditemukan tanda bahaya. Edukasi tentang tanda bahaya nifas dan mekanisme rujukan yang jelas membantu ibu dan keluarga mengambil keputusan cepat, sehingga keterlambatan pertolongan dapat dicegah dan keselamatan ibu lebih terjamin (Sulistyawati 2017).

G. Model layanan: *continuity of midwifery care* untuk meningkatkan mutu pencegahan

Pencegahan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai “daftar intervensi”, melainkan juga sebagai persoalan model layanan yang digunakan untuk menyelenggarakan asuhan. Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, kualitas pencegahan sangat ditentukan oleh ada tidaknya kesinambungan hubungan antara perempuan dan tenaga kesehatan yang merawatnya. Tinjauan sistematis Cochrane (2024) menunjukkan bahwa model kontinuitas asuhan oleh bidan (*midwife-led continuity of care*) cenderung meningkatkan pengalaman perempuan, meningkatkan peluang persalinan spontan, serta pada beberapa konteks berkaitan dengan penurunan tindakan seksio sesarea. Tinjauan tersebut juga mengindikasikan adanya potensi penghematan biaya, terutama pada periode antenatal dan intrapartum (Turienzo, Lv, and Ah 2024).

Implikasinya bagi naskah buku ini adalah bahwa penguatan peran bidan perlu diarahkan pada desain layanan yang memungkinkan terbangunnya hubungan terapeutik antara bidan, perempuan, dan keluarga. Pemantauan yang dilakukan secara longitudinal serta edukasi yang diberikan berulang dan dipertegas pada setiap tahap pelayanan. Selain itu, bidan perlu dibekali kapasitas untuk membantu perempuan dan keluarga menavigasi sistem rujukan secara tepat, sehingga keputusan klinis dan akses terhadap layanan lanjutan dapat berlangsung tanpa keterlambatan (Junengsih et al. 2024). Dengan demikian, peningkatan kualitas pencegahan tidak cukup dicapai hanya dengan menambah jumlah kunjungan. Yang jauh lebih menentukan adalah kesinambungan asuhan, mutu interaksi dalam setiap pertemuan, serta ketepatan tindak lanjut pada setiap episode pelayanan, mulai dari deteksi dini hingga penanganan awal dan rujukan.

H. Peran bidan di komunitas literasi kesehatan, pencegahan keterlambatan rujukan, dan pemberdayaan keluarga

Di banyak wilayah, determinan sosial seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, jarak ke fasilitas layanan, serta norma dan kebiasaan setempat sering berkontribusi terhadap terjadinya “tiga keterlambatan”, yaitu terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat mengambil keputusan untuk mencari pertolongan, dan terlambat mencapai fasilitas kesehatan. Keterlambatan-keterlambatan ini pada akhirnya dapat memperburuk kondisi ibu maupun bayi, bahkan meningkatkan risiko kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Pada titik inilah bidan tidak hanya berperan sebagai tenaga layanan klinis, tetapi juga sebagai agen komunitas yang menjembatani keluarga dengan sistem kesehatan (Town et al. 2024).

Peran tersebut diwujudkan melalui upaya meningkatkan literasi kesehatan ibu dan anak (KIA), terutama mengenai tanda bahaya, rencana persalinan, dan kesiapan transportasi atau rujukan. Bidan juga memfasilitasi penguatan dukungan keluarga, termasuk keterlibatan suami dan keluarga besar dalam pengambilan keputusan serta pendampingan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Selain itu, bidan dapat memperkuat pemantauan berbasis keluarga melalui pemanfaatan buku KIA sebagai media edukasi sekaligus pencatatan berkelanjutan. Dengan cara ini, keluarga memiliki rujukan yang mudah dipahami untuk memantau kondisi ibu dan anak, mengikuti jadwal kunjungan, serta mengenali tanda bahaya secara lebih dini. Pendekatan berbasis keluarga dan komunitas ini membantu mencegah keterlambatan, sekaligus memperkuat kesinambungan asuhan KIA dari rumah hingga fasilitas layanan kesehatan (BPPD Banten 2019).

I. Tantangan dan penguatan sistem: pendidikan, regulasi, mutu, dan jejaring rujukan

Keberhasilan pencegahan masalah kesehatan ibu dan anak (KIA) melalui layanan kebidanan sangat dipengaruhi oleh ekosistem yang mendukungnya. WHO menerbitkan *Framework for Action* (2019) untuk memperkuat pendidikan kebidanan yang berkualitas menuju cakupan kesehatan semesta (*universal health coverage/UHC*) 2030. Kerangka ini menekankan langkah-langkah sistematis untuk meningkatkan standar pendidikan pra-jabatan dan dalam-jabatan, memperkuat kepemimpinan kebidanan, serta mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Ketika pendidikan yang bermutu, regulasi yang jelas, dukungan sarana dan prasarana, supervisi klinis yang konsisten, serta sistem rujukan yang efektif dapat berjalan selaras, bidan akan lebih mampu menjalankan peran pencegahan secara optimal. Peran tersebut mencakup promosi kesehatan dan pemberdayaan keluarga, deteksi dini risiko, tatalaksana awal sesuai kewenangan, hingga rujukan yang cepat dan tepat pada situasi kegawatdaruratan. Dengan dukungan ekosistem yang kuat, kontribusi kebidanan tidak hanya memperbaiki mutu layanan, tetapi juga memperkuat keselamatan ibu dan bayi secara berkelanjutan (Junengsih et al. 2024).

J. Simpulan

Pencegahan masalah kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan upaya yang perlu dilakukan secara berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan, mulai dari masa pra-kehamilan, kehamilan (antenatal), persalinan (intrapartum), nifas (postnatal), hingga perawatan bayi baru lahir dan periode awal kehidupan anak. Dalam seluruh rangkaian layanan tersebut, bidan memegang peran kunci karena

praktik kebidanan mencakup promosi kesehatan, pencegahan komplikasi, deteksi dini faktor risiko, tatalaksana awal sesuai kewenangan, serta rujukan yang cepat dan tepat ketika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lanjutan.

Pada fase pra-kehamilan, bidan berperan menyiapkan kesehatan perempuan dan keluarga melalui konseling prakonsepsi, skrining risiko, perencanaan kehamilan dan keluarga berencana, serta penguatan perilaku hidup sehat. Pada masa antenatal, bidan menjalankan pencegahan primer dan sekunder melalui pemantauan rutin, edukasi berkelanjutan, pencegahan masalah gizi dan anemia, serta penilaian faktor risiko sosial yang kerap menjadi akar keterlambatan dalam mencari pertolongan. Pada fase intrapartum, bidan memastikan keselamatan persalinan melalui pemantauan kemajuan persalinan, deteksi dini komplikasi, pencegahan perdarahan pascapersalinan, serta upaya mengurangi intervensi yang tidak diperlukan dengan pengambilan keputusan klinis yang rasional dan komunikasi yang efektif. Sementara itu, pada periode postnatal, bidan mendampingi pemulihan ibu dan adaptasi bayi baru lahir melalui pemantauan tanda bahaya, dukungan menyusui, perawatan esensial bayi baru lahir, serta penerapan praktik berbasis bukti, seperti inisiasi menyusui dini, penundaan penjepitan tali pusat, dan dukungan *Kangaroo Mother Care* pada bayi prematur atau bayi berat badan lahir rendah.

Meski demikian, efektivitas peran bidan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga oleh desain layanan dan ekosistem sistem kesehatan yang mendukung. Model layanan yang menekankan kesinambungan asuhan, hubungan terapeutik, pemantauan longitudinal, edukasi berulang, serta navigasi rujukan yang jelas dan responsif terbukti lebih bermakna dibandingkan peningkatan jumlah kunjungan semata. Oleh karena itu, penguatan kebidanan perlu berjalan seiring dengan peningkatan mutu pendidikan, regulasi yang tegas, ketersediaan sarana-prasarana, supervisi klinis yang konsisten, serta sistem rujukan yang efektif. Dengan ekosistem yang kuat, bidan dapat menjalankan peran pencegahan secara optimal dan menjadi investasi sistem kesehatan yang berdaya ungkit tinggi untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup ibu, bayi, serta keluarga.

K. Referensi

BPPD Banten. 2019. "Strategi Penurunan Kematian Ibu Dan Anak." *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten* 53(9): 1–7. [https://bappeda.bantenprov.go.id/lama/upload/PPID/KAJIAN/2019/STRATEGI PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN ANAK .pdf](https://bappeda.bantenprov.go.id/lama/upload/PPID/KAJIAN/2019/STRATEGI%20PENURUNAN%20KEMATIAN%20IBU%20DAN%20ANAK.pdf).

Deni E, Dewi H, Siti Mar'atus S, Rikhly Faradisy. 2021. 32 *Asuhan Konprehensif Pada*

- Kehamilan*. Jakarta Barat: PT Nuansa Fajar Cemerlang (OPTIMAL).
- Devie Ismayanty, Busyra Hanim. 2024. 32 *Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan*. ed. MN Ns. Heriviyatno Julika Siagian, S.Kep. Jawa Tengah: PT MEDIA PUSTAKA INDO.
- Junengsih, Junengsih et al. 2024. "The Effect of Continuity of Midwifery Care (CoMC) Based on EDUGARLIN Application and Booklet on Postpartum Fitness Quality." *Amerta Nutrition* 8(2SP): 41–48.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Departemen Kesehatan Republik Indonesia *Buku Ajar Kesehatan Ibu Dan Anak*.
- Midwives, International Confederation of. 2023. *International Definition and Scope of Practice of the Midwife (Revised and Adopted at Bali Council Meeting, 2023)*. https://internationalmidwives.org/wp-content/uploads/EN_Definition-Scope-of-the-Practice-of-Midwife_Aproved-1.pdf.
- Nove, Andrea et al. 2021. "The State of the World's Midwifery 2021 Report: Findings to Drive Global Policy and Practice." *Human Resources for Health* 19(1): 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12960-021-00694-w>.
- Siti F, Mustika P, Ety Dkk. 2022. *Ilmu Kesehatan Ibu Dan Anak*. ed. M.Kep Ns. Arif Munandar, S.Kep. Jawa Barat: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Sulistiyawati, Nurun Ayati Khasanah & Wiwit. 2017. *Asuhan Nifas Dan Menyusui*. Surakarta: CV Kekata Group.
- Town, Cape, South Africa May, Elizabeth Thompson, and Joan Caroline. 2024. "Proceedings of the 2023 International Maternal Newborn Health Conference." *BMC Proceedings* 18(S5): 1–156.
- Turienzo, Fernandez, Jones Lv, and Shennan Ah. 2024. "Midwife Continuity of Care Models versus Other Models of Care for Childbearing Women (Review)." : 153.
- Tutik I, Ika E, Nila T Dkk. 2024. *Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang.
- Undang Undang Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan*.
- United Nations Population Fund. 2021. "State of the World's Midwifery 2021." *Building a health workforce to meet the needs of women, newborns and adolescents everywhere*. 1–80. <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/21-038-UNFPA-SoWMy2021-Report-ENv4302.pdf>.
- World Health Organization. 2018. *Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience*.

<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260178/1/9789241550215-eng.pdf?ua=1%0Ahttp://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/>.

World Health Organization. 2019. "Strengthening Quality Midwifery Education for Universal Health Coverage 2030." https://www.who.int/activities/strengthening-quality-midwifery-for-all-mothers-and-newborns?utm_source=chatgpt.com (February 10, 2026).

World Health Organization. "Essential Newborn Care." <https://www.who.int/teams/maternal-newborn-child-adolescent-health-and-ageing/newborn-health/essential-newborn-care> (February 10, 2026).

World Health Organization Special Programme of Research, Development. 2022. World Health Organization *WHO Recommendations on Maternal and Newborn Care for a Positive Postnatal Experience*. World Health Organization.

CHAPTER 5

***EVIDENCE-BASED PRACTICE* DALAM PENYELESAIAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI WANITA USIA SUBUR**

Hega Valentine, SKM., MKM.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi pada wanita usia subur (WUS) dalam rentang usia 15-49 tahun sangat penting untuk diperhatikan karena memiliki berbagai permasalahan (Wati et al., 2023). Beragam permasalahan kesehatan yang dialami oleh perempuan meliputi pengaturan kesuburan (kontrasepsi), penyakit menular seksual, kekerasan berbasis seks dan gender, kehamilan dan persalinan, serta ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan (Ardianti, 2019; Gagnon et al., 2002). Berbagai permasalahan kesehatan reproduksi perempuan tersebut akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap status demografi negara, karena kesehatan reproduksi yang baik akan mempengaruhi kualitas demografi manusia (Meo & Nahak, 2020).

Berdasarkan penelitian bahwa 80.2% responden pertama kali mempunyai anak pada usia remaja akhir, 53.1% tidak menggunakan KB, 56.4% mempunyai anak lebih dari dua orang, 55% responden memiliki riwayat tidak aktif mengikuti Antenatal Care (ANC) dan 59% memiliki riwayat tidak memberikan ASI eksklusif (Meo & Nahak, 2020). Temuan utama dalam penelitian ini adalah primimuda dan rendahnya penggunaan kontrasepsi, sehingga kedua masalah ini berdampak pada tingginya angka fertilisasi dan mortalitas perempuan. Hasil penelitian lainnya membuktikan bahwa perempuan imigran secara paksa dapat meningkatkan fertilisasi, karena adanya dorongan dari pengungsi untuk 'repopulasi', atau mengisi kembali dan menggantikan jumlahnya yang hilang atau berkurang. Peningkatan jumlah penduduk pengungsi semakin diperburuk dengan ketetidakterediaan kontrasepsi dan kurangnya pengetahuan terkait pemanfaatan kontrasepsi (Gagnon et al., 2002; Palareti et al., 2016) Temuan lainnya adalah rendahnya pemanfaatan pelayanan ANC. Masalah kesehatan selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan juga menjadi permasalahan yang dialami perempuan pengungsi, hal tersebut dikaitkan dengan kemiskinan yang berdampak pada status nutrisi dan hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang adekuat akibat perbedaan bahasa dan budaya antara perempuan pengungsi dan petugas kesehatan (Barnes & Harrison, 2004; Gagnon et al., 2002).

Masalah-masalah yang dialami oleh WUS ini mungkin dikarenakan kurangnya informasi dari petugas kesehatan, masih minimnya upaya pemerintah dalam memberikan informasi dan sosialisasi serta kurangnya upaya-upaya promotif dan preventif dalam mencegah masalah kesehatan reproduksi wanita. Selain itu kurangnya kesadaran dari WUS dan keluarga untuk berupaya mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi wanita, khususnya pada WUS. Faktor sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, psikologis, dan biologis yang mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita (Ardianti, 2019). Faktor sosial ekonomi terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi disebut paling berpengaruh terhadap terjadinya masalah reproduksi pada wanita. Adapun faktor budaya dan lingkungan seperti praktek tradisional yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi dari masyarakat dan keluarga yang diyakini dari generasi ke generasi yang berlawanan dengan informasi medis akan membingungkan. Anggapan bahwasanya masalah kesehatan reproduksi adalah urusan perempuan, dan tidak berhubungan dengan suami ataupun anggota keluarga yang lain.

B. WUS dengan Kehamilan Usia Remaja

Masa remaja (10 hingga 19 tahun) adalah masa unik yang tidak hanya ditandai oleh meningkatnya kapasitas fisik untuk aktif secara seksual dan mengandung anak, tetapi juga oleh kapasitas kognitif dan psikososial yang belum sepenuhnya berkembang untuk menilai konsekuensi yang tidak diinginkan dari aktivitas seksual dan menegosiasikan seks yang aman dan konsensual (Gray et al., 2013). Pengaruh perkembangan pada pengambilan keputusan seksual, bagi banyak remaja sangatlah rumit, karena dipengaruhi oleh tantangan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, pernikahan dini, pencapaian pendidikan yang rendah, terbatasnya kesempatan kerja, dan hambatan sosial budaya dan peraturan untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Kombinasi faktor-faktor ini meningkatkan kehamilan remaja sekaligus menciptakan hambatan terhadap perilaku mencari perawatan. Kehamilan remaja meningkat di kalangan remaja perempuan dengan penyebab utama yaitu kehamilan diluar nikah dan keputusan untuk menikah di usia muda (Meo & Nahak, 2020).

Walaupun seks pranikah dan kehamilan di luar nikah tidak disetujui dan tidak ditoleransi oleh masyarakat di lingkungan pengungsi namun kontrol yang rendah dari orangtua menyebabkan banyak remaja jatuh dalam pergaulan bebas yang berdampak pada kehamilan di luar nikah. Risiko yang terkait dengan kehamilan

yang tidak diinginkan mencakup aborsi yang tidak aman, perilaku ibu yang buruk dalam mencari layanan kesehatan, kesehatan mental yang buruk, dan kemungkinan kematian ibu dan bayi, berisiko lebih tinggi terkena eklampsia, persalinan prematur, dan peningkatan morbiditas dan mortalitas neonatal (Mohamed et al., 2023).

Penyebab kedua tingginya angka kehamilan remaja adalah keputusan untuk menikah di usia muda. Remaja memilih untuk menikah di usia remaja karena menjadi ibu rumah tangga adalah pilihan karir satu-satunya setelah kemungkinan untuk sekolah sudah tertutup sebagai dampak dari kemiskinan. Anggapan melalui pernikahan seluruh kebutuhan perempuan akan menjadi tanggungjawab suaminya setelah pernikahan akan tetapi perempuan yang telah menikah tetap ikut andil dalam membantu perekonomian keluarga.

Terlepas dari alasan apapun, kehamilan remaja tetap memberikan dampak negatif bagi remaja. Reproduksi sehat untuk hamil dan melahirkan berkisar antara usia 20-30 tahun. Jika terjadi kehamilan di bawah atau di atas usia tersebut akan berisiko terjadinya kematian 2 hingga 4 kali lebih tinggi dari reproduksi sehat. Kematian ini kemungkinan besar disebabkan oleh kombinasi faktor biologis, akses yang lebih buruk terhadap perawatan antenatal, persalinan, dan pascanatal, serta lebih seringnya melakukan aborsi yang tidak aman. Bayi yang lahir dari perempuan usia remaja juga berisiko mengalami kematian neonatal 50% lebih tinggi pada minggu pertama dan 50% hingga 100% lebih tinggi selama bulan pertama kehidupan dibandingkan bayi yang dilahirkan perempuan usia 20-30 tahun. Angka kelahiran prematur yang lebih tinggi, persalinan yang rumit, dan berat badan lahir rendah, serta akses yang lebih rendah terhadap kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran, perawatan terampil saat melahirkan, dan perawatan pascanatal kemungkinan merupakan faktor yang berkontribusi. Kehamilan remaja membawa kerugian bagi kesehatan, kesejahteraan mental dan psikologi remaja, menghambat peluang karir dan peningkatan ekonomi, meningkatkan kemiskinan serta menghambat prospek masa depan remaja, remaja tersebut akan mengalami anemia, hipertensi gestasional, preeklamsia, prematuritas dan berat badan lahir rendah (Gray et al., 2013)

Kehamilan dini juga menambah beban sosial ekonomi bagi remaja itu sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat karena remaja akan diminta untuk meninggalkan sekolah saat hamil, atau mereka meninggalkan sekolah untuk menikah dan hamil. Capaian pendidikan yang lebih rendah dikaitkan dengan hasil kesehatan yang lebih buruk bagi anak perempuan dan anak-anak mereka, meningkatkan ketergantungan perempuan pada suami dan keluarga mereka, dan memperburuk ketidakadilan gender di komunitas mereka. Meninggalkan sekolah juga membatasi peluang mata

pencabutan anak perempuan, yang memperkuat siklus kemiskinannya sendiri dan mengurangi produktivitas komunitasnya.

Intervensi yang diperlukan untuk menurunkan kehamilan usia remaja yaitu dengan memberikan akses terhadap keluarga berencana, perawatan antenatal dan postnatal yang berkualitas, perawatan terampil saat melahirkan, dan aborsi yang aman serta perawatan pasca aborsi. Namun, remaja mengalami hambatan unik dalam mengakses informasi dan perawatan kesehatan reproduksi dan tidak mungkin mendapat manfaat dari intervensi kesehatan reproduksi yang ditujukan pada keseluruhan populasi.

Menilik tingginya angka kehamilan remaja, perlu perhatian khusus pemerintah untuk mencegah kehamilan remaja dan mencegah kehamilan berulang pada ibu remaja. Selain itu, model pelayanan kesehatan yang diperlukan adalah konsep *youth friendly*. Konsep ini merujuk pada sikap petugas yang ramah, penuh perhatian dan tidak menggurui dalam memberikan pelayanan sehingga dapat mengatasi hambatan pemanfaatan pelayanan kesehatan remaja. Intervensi psikososial (KIE terkait kesehatan reproduksi), kunjungan rumah dan pendampingan keluarga muda, serta penguatan program keluarga berencana juga perlu untuk mencegah kehamilan berulang pada ibu remaja (Aslam et al., 2017; Yani et al., 2014).

Pedoman WHO, *mencegah kehamilan dini dan hasil reproduksi yang buruk di kalangan remaja di negara-negara berkembang*, memberikan seruan untuk bertindak dan memberikan arahan untuk penelitian di masa depan mengenai (WHO, 2011):

1. mencegah kehamilan dini: dengan mencegah perkawinan sebelum usia 18 tahun; dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya pencegahan kehamilan; dengan meningkatkan penggunaan kontrasepsi; dan dengan mencegah seks yang dipaksakan;
2. mencegah hasil reproduksi yang buruk: dengan mengurangi aborsi yang tidak aman; dan dengan meningkatkan penggunaan layanan antenatal, persalinan dan pasca melahirkan yang terampil.

Beberapa intervensi yang ditujukan untuk mencegah kehamilan usia dini terbagi menjadi dua kategori besar yaitu intervensi psikososial multi-elemen dan program kontrasepsi.

1. Intervensi Psikososial

Program psikososial menawarkan berbagai layanan, seperti manajemen kasus dan rujukan; edukasi tentang kehamilan, persalinan dan melahirkan, kontrasepsi dan kesehatan bayi; pelatihan perkembangan anak; fasilitasi kontak dengan sistem perawatan kesehatan; dan konseling individual. Sebagian besar

program ini melibatkan kunjungan rumah, berbasis komunitas dan melibatkan konseling telepon dengan periode tindak lanjut juga berkisar antara 12 bulan hingga 24 bulan.

a. Intervensi berbasis rumah Intervensi berdasarkan kunjungan rumah melibatkan konselor, mentor, bidan, perawat atau pengunjung rumah terlatih yang direkomendasikan dari pemerintahan, atau yang direkrut dari masyarakat atau dari kelompok etnis yang sama memberikan intervensi kepada ibu muda di rumah mereka. Beberapa penelitian tentang intervensi psikososial berbasis rumah melaporkan efektivitas intervensi dalam mengurangi proporsi kehamilan remaja berulang. Program kunjungan rumah berulang memfasilitasi akses ke layanan, mengatasi kesenjangan dalam jaringan dukungan sosial, mempertahankan perubahan perilaku melalui kontak berulang dengan ibu muda, sehingga menurunkan resiko dari kehamilan berulang, dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan kebutuhan individu mereka. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memberikan intervensi ini adalah petugas kesehatan harus memiliki pengetahuan yang terus ditingkatkan dan lebih spesifik terkait permasalahan yang dialami pada kehamilan usia dini sehingga maksimal dalam memberikan saran tentang kontrasepsi untuk remaja muda dan perlu adanya pelatihan keterampilan hidup bagi ibu muda sehingga lebih tidak rentan untuk hamil lagi.

b. Intervensi berbasis komunitas

Intervensi berbasis komunitas yang terbukti efektif dalam mengurangi kehamilan usia dini berulang adalah program perawatan prenatal yang berpusat pada teman sebaya dan partisipasi kelompok yang mendapatkan dukungan dari kader kesehatan (Aslam et al., 2017). Faktor penunjang lainnya diperlukan oleh tenaga kesehatan adalah memerlukan transportasi ke dan dari lokasi dan ketersediaan makanan, minuman, dan fasilitas penitipan anak semuanya dapat meningkatkan keterlibatan dan meningkatkan tingkat kehadiran kader dan peer group dalam pelaksanaan pelatihan. Program 'sistem teman' atau kelompok dukungan sebaya dapat menawarkan pilihan yang memberdayakan wanita muda dan memberi mereka kepercayaan diri, serta memberi mereka kesempatan untuk menyatakan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Bagi kader atau peer group merasa beruntung dan dihargai untuk menjadi bagian dari kelompok sebaya.

c. Intervensi berbasis telepon Satu studi melaporkan intervensi pendampingan berbasis telepon yang disampaikan oleh konselor wanita muda dengan latar belakang etnis yang sama dengan wanita muda yang terlibat.

Kehamilan remaja dapat dicegah dengan mendorong remaja untuk menunda debut seksual mereka, menentang praktik pernikahan anak, meningkatkan konsistensi penggunaan kontrasepsi dan mendidik anak perempuan dan laki-laki tentang risiko kehamilan yang tidak diinginkan (Oringanje et al., 2016). Masyarakat yang cenderung berhasil menerapkan pendekatan multifaset, yaitu menerapkan program pencegahan yang dilakukan pada tingkat primer, sekunder, dan tersier (Mohamed et al., 2023). Program-program ini berupaya untuk tidak hanya berfokus pada seks dan potensi konsekuensi dari melakukan hubungan seks yang tidak aman, namun juga mengatasi faktor-faktor kontekstual seperti norma-norma sosial, pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan pribadi. Selain itu, kelompok sasarannya tidak hanya terbatas pada remaja perempuan tetapi juga mencakup remaja laki-laki, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat (Oringanje et al., 2016). Berdasarkan penelitian tentang pedoman berbasis bukti untuk mencegah kehamilan remaja, berhasil diidentifikasi beberapa strategi pencegahan kehamilan (Mohamed et al., 2023; D. Taylor & James, 2011), yaitu

1) Strategi Pencegahan Primer

Mencakup strategi yang mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Contohnya adalah lingkungan keluarga yang mendukung, pendidikan seksualitas yang komprehensif, kontrasepsi, serta pencegahan dan deteksi kekerasan seksual dan berbasis gender.

Pencegahan primer terdiri dari upaya yang ditujukan untuk mencegah timbulnya suatu kondisi tertentu salah satunya mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Tujuan dari pencegahan primer kehamilan yang tidak diinginkan adalah untuk membantu individu dalam mencapai niat kehamilannya dan meningkatkan outcome ibu, anak dan keluarga dengan meningkatkan kemungkinan bahwa setiap kehamilan adalah kehamilan yang diinginkan dan direncanakan (D. Taylor et al., 2010).

Banyak rekomendasi untuk kesehatan prakonsepsi yang sudah diketahui secara luas. Pengujian yang tepat untuk infeksi menular seksual untuk melindungi kesuburan di masa depan, dorongan suplementasi asam folat sebelum konsepsi untuk mencegah cacat tabung saraf, dan pentingnya perubahan gaya hidup sehat seperti berhenti merokok dan alkohol, olahraga teratur dan pola makan sehat adalah contohnya.

Evaluasi terhadap kesehatan prakonsepsi dan risiko kehamilan yang tidak diinginkan juga merupakan peluang untuk mengatasi pilihan gaya hidup yang mempengaruhi bidang penting lainnya dalam kesehatan reproduksi. Beresiko tinggi mengalami kehamilan yang tidak diinginkan terkait dengan

masalah kesehatan penting lainnya termasuk obesitas, merokok, dan pesta minuman keras, terutama pada perempuan minoritas dan berpenghasilan rendah. Konseling prakonsepsi tidak boleh terbatas hanya pada diskusi tentang cara mengoptimalkan hasil kehamilan dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, namun juga memberikan cara untuk mengatasi masalah kesehatan preventif lainnya.

Pengetahuan tentang penggunaan kontrasepsi pasien merupakan komponen penting dalam pencegahan primer. Evaluasi rutin terhadap penggunaan kontrasepsi pasien mempunyai potensi untuk meningkatkan pelayanan pasien dan menormalkan pencegahan utama kehamilan yang tidak diinginkan dalam setiap kunjungan layanan kesehatan. Pencegahan primer kehamilan yang tidak diinginkan juga mencakup evaluasi kepuasan pasien terhadap metode kontrasepsinya pada kunjungan berikutnya. Strategi pencegahan primer untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan akan kurang efektif jika ditujukan hanya pada perempuan. Perempuan yang pasangan prianya sangat mendukung penggunaan kontrasepsi cenderung menggunakan kontrasepsi mereka secara efektif.

Kekerasan pasangan intim dikaitkan dengan peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan dan hasil perinatal yang buruk. Bukti terbaru menunjukkan bahwa hubungan antara kekerasan pasangan intim dan kehamilan yang tidak diinginkan mungkin terkait tidak hanya dengan menurunnya kemampuan perempuan yang berada dalam hubungan yang penuh kekerasan untuk menegosiasikan praktik seks yang lebih aman, namun juga dengan pengendalian reproduksi langsung oleh pasangannya seperti sabotase kontrasepsi.

Strategi dan layanan pencegahan primer yang penting antara lain:

a) Strategi konseling

Metode konseling dipilih untuk melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan kontrasepsi serta pedoman bagi profesional kesehatan untuk membantu individu mencapai tujuan kontrasepsi mereka. Teknik lain untuk membantu penyedia layanan dalam memperkenalkan pencegahan prakonsepsi ke dalam kunjungan layanan primer. Teknik seperti ini memungkinkan penyedia layanan dan pasien mengembangkan rencana untuk mengoptimalkan potensi kesehatan setiap klien secara keseluruhan, berkontribusi terhadap pencegahan penyakit dan promosi kesehatan.

b) Strategi kegagalan kontrasepsi

Pencegahan primer harus mencakup rencana untuk mencegah kegagalan metode kontrasepsi. Strategi pencegahan utama yang dapat membantu keberhasilan penggunaan metode kontrasepsi yaitu memberikan paket kontrasepsi oral dalam jumlah lebih banyak kepada pasien dikaitkan dengan tingkat kelanjutan yang lebih tinggi dan penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi. Penggunaan kontrasepsi jangka panjang yang dapat dibalik seperti kontrasepsi implan atau kontrasepsi intrauterin menggabungkan kemudahan penggunaan dan tingkat kemanjuran yang sangat tinggi untuk menciptakan tingkat kelanjutan yang lebih baik dibandingkan kontrasepsi oral. Metode-metode ini juga merupakan pilihan bagi perempuan yang mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan metode penghalang atau kontrasepsi oral secara konsisten. Dengan mendiskusikan rencana reproduksi pasien dan mengevaluasi metode yang tersedia, dokter mungkin akan lebih efektif dalam memberikan pencegahan primer terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Pencegahan primer kehamilan yang tidak diinginkan berpotensi bermanfaat sebagai metode penghematan biaya selain meningkatkan hasil perinatal.

Strategi pencegahan primer salah satunya adalah program berbasis sekolah yang disampaikan melalui platform sekolah terutama berfokus pada risiko psikososial dan faktor perlindungan yang melibatkan seksualitas (Mohamed et al., 2023). Strategi pencegahan primer ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja perempuan dan laki-laki tentang kesehatan reproduksi seksual mereka dan mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan (M. Taylor et al., 2014). Memanfaatkan platform sekolah untuk melakukan intervensi membantu memastikan bahwa siswa memiliki ruang yang aman untuk belajar tentang seksualitas mereka, pencegahan kehamilan dan penularan penyakit menular seksual, dan di mana mengakses layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Selain itu, program berbasis sekolah memungkinkan remaja untuk terlibat dengan topik-topik ini dalam forum yang dapat diterima secara sosial. Penyampaian pendidikan seks melalui sekolah memastikan lebih banyak remaja yang dijangkau sebelum debut seksual mereka (Mantell et al., 2006)

Selain itu pembelajaran berbasis klinik dan komunitas (yaitu, mendirikan klub kesehatan untuk mendidik tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas dan memfasilitasi rujukan ke klinik, klinik kesehatan keliling

untuk remaja dan layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas di pusat remaja) cenderung memasukkan unsur-unsur program pendidikan, tidak seperti intervensi berbasis sekolah, sesi-sesi ini juga dapat diberikan secara terpisah sebagai intervensi yang berdiri sendiri baik di dalam klinik maupun di luar komunitas yang lebih luas, untuk mencakup remaja putus sekolah. Intervensi ini juga meningkatkan akses terhadap layanan keluarga berencana bagi remaja, meningkatkan pengetahuan remaja tentang metode dan menghilangkan kesalahpahaman. Kegiatan yang mempromosikan kontrasepsi di masyarakat juga dapat berupaya untuk mengubah norma-norma sosial dalam masyarakat yang menghambat penggunaan metode kontrasepsi, yang juga memfasilitasi penerimaan program pendidikan seks di sekolah, penciptaan layanan ramah remaja dan promosi serta distribusi metode kontrasepsi (Ross et al., 2007)

Intervensi pembangunan remaja tidak hanya fokus pada kebutuhan kesehatan seksual dari populasi sasaran tetapi juga memenuhi kebutuhan ini dalam sebuah program yang mencoba mengatasi isu-isu lintas sektoral lainnya melalui pengembangan keterampilan dan pendampingan. Keberhasilan program-program ini bergantung pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti sekolah, kelompok agama, masyarakat, petugas kesehatan dan remaja. Selain itu, pelaksana harus memastikan intervensi tersebut bersifat praktis, sesuai dengan budaya dan berbasis bukti (Oringanje et al., 2016).

Intervensi pencegahan kehamilan remaja yang mencakup pendidikan seks dengan pendekatan sebagai berikut:

- a) Membangun keterampilan; *Intervensi yang memberikan instruksi, praktik atau kegiatan lain yang dirancang untuk membantu kelompok sasaran membangun dan meningkatkan keterampilan mereka, misalnya guru memberikan kelas SRH atau bimbingan akademis yang lebih baik untuk remaja.*
- b) Interaktif; *Intervensi didasarkan pada prinsip keterlibatan siswa, yang memerlukan keseimbangan antara suara siswa dan guru. Siswa dan guru sama-sama terlibat dalam pembelajaran.*
- c) Dipimpin oleh rekan sejawat; *Intervensi yang menggunakan metode pengajaran atau fasilitasi promosi kesehatan yang meminta masyarakat untuk menyampaikan pesan kesehatan tertentu kepada anggota komunitasnya.*

- d) Menunda debut seksual; *Intervensi bertujuan untuk mempengaruhi waktu atau membantu remaja dalam menunda inisiasi seksual.*
- e) Pantang; *Intervensi yang secara aktif menghambat seks sebelum menikah.*
- f) Penyuluhan; *Intervensi yang menggunakan terapi bicara dengan tenaga profesional terlatih untuk membantu klien mengatasi kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksinya.*
- g) Paparan tanggung jawab orang tua; *Intervensi yang memaparkan remaja pada realitas menjadi orang tua, yaitu mengasuh anak.*
- h) Pemberian informasi; *Intervensi yang terfokus pada pemberian informasi saja*
- i) Durasi, frekuensi dan intensitas intervensi pencegahan kehamilan remaja

2) Strategi Penatalaksanaan Sekunder

Pencegahan sekunder ditujukan untuk mendeteksi penyakit sebelum pasien menunjukkan gejala, melibatkan tes skrining, diagnosis kehamilan dini dan konseling mengenai pilihan kehamilan, termasuk akses terhadap layanan aborsi yang aman, mencakup intervensi untuk memungkinkan deteksi dini kehamilan dan membantu penyediaan layanan sedini mungkin pada kehamilan yang tidak diinginkan, intervensi untuk menghindari terulangnya kondisi medis yang didiagnosis, perawatan juga akan diarahkan pada pencegahan terulangnya kehamilan yang tidak diinginkan. Selain pencegahan penyakit, pencegahan sekunder juga penting dalam meningkatkan kesehatan melalui konseling dan koordinasi perawatan yang memadai mengenai pilihan kehamilan yang tidak diinginkan.

Strategi dan layanan pencegahan sekunder yang penting yaitu:

- a) Strategi deteksi kehamilan dini. Pencegahan sekunder dengan tujuan deteksi dini kehamilan yang tidak diinginkan adalah penting bagi perempuan, apa pun pilihan hasil kehamilannya. Jika seorang perempuan tidak yakin dengan keputusannya, deteksi dini kehamilan akan memberinya waktu untuk mempertimbangkan informasi penting yang diberikan selama konseling pilihan. Deteksi dini kehamilan yang tidak diinginkan dan konseling pilihan yang menyeluruh dan cepat memberikan setiap perempuan kesempatan untuk mempertimbangkan dan memilih hasil (misalnya melanjutkan kehamilan, adopsi, atau penghentian kehamilan) yang terbaik bagi dirinya dan keluarga atau situasinya. Deteksi dini terhadap kehamilan yang tidak diinginkan memungkinkan seorang perempuan untuk menerima skrining dini yang tepat untuk mengetahui risiko atau paparan prakonsepsi atau

memungkinkan seorang perempuan untuk mengakses aborsi, sebuah prosedur umum yang aman dan memiliki risiko yang lebih kecil jika dilakukan pada awal kehamilan. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap keterlambatan dalam melakukan upaya terminasi kehamilan adalah perempuan sering kali harus mengoordinasikan pembayaran untuk prosedur aborsi mereka, ketakutan akan prosedur aborsi, kesulitan menemukan penyedia aborsi, dan kurangnya kesadaran akan perlunya tes kehamilan (Kiley et al., 2010).

b) Meningkatkan strategi interval kehamilan berulang.

Pencegahan sekunder yang efektif terhadap kehamilan yang tidak diinginkan tidak terbatas pada diagnosis, pilihan konseling, dan koordinasi perawatan. Kesadaran akan perlunya skrining kehamilan, terlepas dari apakah hasil tesnya positif atau negatif, memberikan kesempatan kepada penyedia layanan kesehatan primer untuk memberikan edukasi guna mendiskusikan faktor risiko kehamilan yang tidak diinginkan, rencana kehidupan reproduksi, dan pilihan kontrasepsi.

3) Strategi Penatalaksanaan Tersier

Pencegahan efek samping yang berhubungan dengan kehamilan yang tidak diinginkan, misalnya pengobatan aborsi tidak lengkap; akses terhadap layanan untuk trauma psikososial; dan pelayanan antenatal dan pelayanan bersalin untuk mencegah kesakitan dan kematian ibu. Pencegahan tersier secara umum didefinisikan sebagai intervensi untuk meringankan gejala suatu penyakit klinis dan tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan gejala sisa dari suatu penyakit atau penyakit (D. Taylor et al., 2010; D. Taylor & James, 2011). Ketika diterapkan pada kehamilan yang tidak diinginkan, pencegahan tersier mencakup diagnosis dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kehamilan yang tidak diinginkan dan bukan hanya terjadi pada waktu yang tidak tepat diketahui memiliki risiko lebih besar terhadap hasil perinatal yang buruk seperti depresi ibu dan penelantaran bayi. Wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan pada usia lanjut kemungkinan besar memerlukan penilaian psikososial, konseling krisis dan/atau koordinasi perawatan untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan hingga cukup bulan. Bagi perempuan yang tidak ingin melanjutkan kehamilannya, rujukan dan pilihan mengenai terminasi kehamilan harus diberikan tepat waktu karena keterlambatan dalam mendapatkan perawatan dikaitkan dengan peningkatan risiko pada ibu.

Pencegahan tersier terhadap kehamilan yang tidak diinginkan adalah bidang di mana asuhan keperawatan dapat memberikan perbedaan penting pada hasil akhir pasien. Karena perawat mahir dalam pendidikan kesehatan, perawatan psikososial, dan koordinasi perawatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tersier tidak akan selesai jika seorang perempuan telah memilih hasil dari kehamilan yang tidak diinginkan. Mengoordinasikan dan memastikan perawatan dan/atau rujukan yang tepat sangatlah penting seperti kebutuhan kontrasepsi segera setelah melahirkan atau aborsi merupakan tanggung jawab spesialis kesehatan reproduksi dan penyedia layanan kesehatan primer. Pemasangan segera alat kontrasepsi intrauterin dan diskusi mengenai pilihan kontrasepsi dengan penyedia layanan pada periode pasca operasi atau pasca melahirkan meningkatkan kemungkinan seorang wanita akan memilih alat kontrasepsi yang sangat efektif dan menggunakannya dengan benar

C. Program Kontrasepsi

Pernikahan usia remaja menyebabkan masa reproduksi seorang perempuan menjadi lebih panjang. Apabila tidak di kontrol maka akan berdampak pada tingginya angka kelahiran. Hal ini merupakan mata rantai yang harus diputuskan untuk mencegah lonjakan penduduk. Berdasarkan temuan kuantitatif sebagian besar WUS (53.1%) tidak mengikuti program keluarga berencana. Beberapa alasan mengapa perempuan muda gagal mempertahankan penggunaan kontrasepsi yang efektif adalah:

1. Mengalami efek samping dari salah satu metode kontrasepsi sehingga umumnya berhenti menggunakan satu metode sebelum beralih ke metode lain, yang membuat mereka rentan terhadap kehamilan yang tidak diinginkan untuk sementara waktu.
2. Perempuan ini tidak memiliki pengetahuan dasar tentang metode kontrasepsi
3. Ada kesalahpahaman umum, khususnya tentang kesuburan segera setelah melahirkan atau saat menyusui dan tentang efek samping beberapa jenis kontrasepsi.
4. Perempuan juga menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses kontrasepsi, termasuk jam klinik yang terbatas, penyediaan layanan yang tidak merata, dan kegagalan sistem lainnya, seperti kurangnya pelatihan penyedia layanan
5. Perempuan mempunyai kewajiban menjaga kelangsungan keturunan.

6. Keluarga biasanya melarang menggunakan kontrasepsi karena dianggap membatasi keturunan.
7. Perempuan membutuhkan persetujuan suami dan mertua untuk menggunakan kontrasepsi
8. Pemahaman WUS tentang kontrasepsi masih rendah, masih takut akan efek samping kontrasepsi terhadap kesehatan dan kontrasepsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti keganasan, peningkatan berat badan, gangguan siklus menstruasi.

Program kontrasepsi menawarkan pendidikan dan penyediaan kontrasepsi darurat oleh tenaga kesehatan berlisensi. Penyediaan kontrasepsi darurat ditujukan untuk mengurangi kehamilan berulang dengan mengatasi penghentian atau penggantian metode kontrasepsi yang sering. Disisi lain kerugian dalam menggunakan kontrasepsi darurat sebagai satu-satunya metode kontrasepsi adalah:

1. alat kontrasepsi reversibel jangka panjang tidak mudah diakses melalui dokter umum, janji temu berulang harus dilakukan, yang meningkatkan kerentanan untuk mengulangi kehamilan. Terkait efektivitas 72 jam untuk kontrasepsi darurat, dengan akhir pekan hari libur bank atau liburan Natal yang berkepanjangan menjadi penyebab kekhawatiran.
2. Kelompok pengguna alat kontrasepsi darurat menyatakan bahwa wanita juga ragu-ragu meminta kontrasepsi darurat karena takut dihakimi.

Keberhasilan penggunaan kontrasepsi juga melalui dukungan teman sebaya atau mentor dapat membantu remaja dalam pengambilan keputusan dan kontrol aktif. Merasa diperhatikan dan didukung dapat membantu remaja merasa bahwa pilihan hidupnya didorong dan bahwa dia didengarkan. Mekanisme penyesuaian harus didukung dalam memberikan intervensi, dengan mempertimbangkan pengalaman hidup remaja, tahap perkembangan, budaya dan pengalaman (termasuk kehamilan). Pendekatan perawatan individual dan holistik mungkin lebih berhasil daripada mengadopsi model medis murni untuk memberikan informasi dan kemudian mendorong penggunaan metode hormonal atau metode non-hormonal yang bekerja lama. Pertimbangan lainnya adalah menilai pengetahuan remaja tentang metode kontrasepsi serta kebutuhan individualnya, termasuk tantangan transportasi dan kesulitan mengakses layanan, memerlukan pertimbangan dan pendekatan yang disesuaikan seperti kunjungan rumah dan layanan berbasis sekolah dapat meminimalkan perjalanan dan meningkatkan akses. Mekanisme yang

terungkap dapat meningkatkan kemungkinan intervensi yang efektif dalam mencegah kehamilan berulang yang cepat pada remaja.

Faktor risiko untuk kehamilan berulang yang tidak diinginkan tampak beragam dan meliputi:

1. Faktor kontekstual, seperti kurangnya dukungan keluarga atau teman sebaya, kesempatan pendidikan atau kejuruan, dan gaya hidup yang kacau. Rendahnya angka pengguna kontrasepsi pada WUS disebabkan oleh pengaruh keluarga, budaya atau agama, dan pengalaman dengan berbagai metode hormonal. Keluarga dirujuk sebagai elemen yang mempengaruhi dalam keputusan tentang kesehatan reproduksi. Keluarga disini merujuk pada suami dan atau mertua. Budaya patriarkhi menyebabkan kontrol dan pusat kekuasaan ada pada suami karena memiliki wewenang untuk memutuskan kapan, dan berapa banyak anak yang akan dimiliki.
2. Faktor emosional, terutama untuk mengisi kekosongan emosional setelah aborsi atau adopsi
3. Faktor praktis, seperti keinginan untuk melengkapi keluarga seseorang saat masih muda
4. Faktor motivasi, seperti tujuan dan aspirasi pribadi mendorong wanita muda untuk mencoba menghindari kehamilan berulang, tetapi mereka sering tidak diberi dukungan yang tepat untuk mencapai tujuan mereka

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah kehamilan tidak diinginkan dengan adanya program Keluarga Berencana (KB), yaitu berupa penggunaan kontrasepsi modern, terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Indraswari et al., 2021). KB modern terbukti efektif dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah kematian ibu dan anak (World Health Organisation, 2005). Sedangkan MKJP merupakan metode kontrasepsi yang efektif untuk waktu yang lama (Shegaw et al., 2014). Faktor yang dapat memengaruhi Pasangan Usia Subur (PUS) tidak menggunakan kontrasepsi modern atau MKJP adalah sumber informasi karena kurangnya informasi masih menjadi penghambat naiknya cakupan penggunaan kontrasepsi (Fitriana Putri et al., 2020; Indraswari et al., 2021). Dengan demikian, peran Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sangat strategis dalam mengkampanyekan program KB. KIE perlu dilakukan dengan berbagai media agar dapat diterima oleh banyak sasaran.

D. Hambatan dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa riwayat kunjungan ANC masih rendah yang diikuti dengan rendahnya kunjungan posyandu dengan alasan ibu menghadiri kegiatan posyandu jika ada pembagian makanan tambahan berupa biskuit atau susu formula dari pihak puskesmas, perempuan selalu digambarkan dengan “susah diatur”, “malas” dan “mempunyai tingkat pemahaman rendah”, masih merasakan perlakuan yang berbeda dalam pelayanan yang diterima sehingga menjadikan mereka enggan untuk mengikuti kegiatan tersebut, mengabaikan kesehatan fisik dan mental mereka, karena disibukkan oleh kekhawatiran tentang status tempat tinggal, posisi yang tidak jelas dan rasa tidak aman dalam masyarakat, ditambah pengalaman terhadap stigma warga local terhadap pengungsi sehingga memicu rasa tidak percaya pada orang lain (Meo & Nahak, 2020). Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika praktisi kesehatan tidak diberikan pelatihan dan pemahaman untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para pengungsi yang memiliki pengalaman, harapan dan kebutuhan yang berbeda dengan warga local, praktisi kesehatan juga tidak siap untuk memberikan layanan kepada kelompok populasi pengungsi dengan kebutuhan yang sedemikian kompleks akibatnya pelayanan kesehatan reproduksi yang tersedia belum secara khusus menjangkau perempuan pengungsi (Drummond et al., 2011; Janssens et al., 2006)

E. Simpulan

Permasalahan kesehatan reproduksi pada perempuan usia subur meliputi tingginya WUS usia remaja, rendahnya tingkat partisipasi penggunaan KB sehingga meningkatnya fertilisasi. Kehamilan remaja masih menjadi permasalahan utama di kalangan remaja pengungsi. Seks bebas dan keputusan menikah di usia muda menjadi alasan utama tingginya kehamilan remaja. Hal ini diperburuk dengan benturan budaya dan kesadaran menggunakan kontrasepsi yang masih rendah. Kompleksitas permasalahan kesehatan reproduksi yang disajikan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi yang efektif terkait penyediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif bagi komunitas perempuan. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Mengembangkan dan menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan kongruen secara budaya termasuk perawatan prenatal dan keluarga berencana; 2) Mengadvokasi lingkungan yang toleran untuk mengurangi stigmatisasi di komunitas pengungsi.

F. Referensi

- Ardianti, I. (2019). Pemberian Edukasi Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur Di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Humanis*, 3(1), 25–29.
- Aslam, R. W., Hendry, M., Booth, A., Carter, B., Charles, J. M., Craine, N., Edwards, R. T., Noyes, J., Ntambwe, L. I., Pasterfield, D., Rycroft-Malone, J., Williams, N., & Whitaker, R. (2017). Intervention Now to Eliminate Repeat Unintended Pregnancy in Teenagers (INTERUPT): A systematic review of intervention effectiveness and cost-effectiveness, and qualitative and realist synthesis of implementation factors and user engagement. *BMC Medicine*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12916-017-0904-7>
- Barnes, D. M., & Harrison, C. L. (2004). Refugee women's reproductive health in early resettlement. *JOGNN - Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing*, 33(6), 723–728. <https://doi.org/10.1177/0884217504270668>
- Biswas, K. K., Hossain, A., Chowdhury, R., Andersen, K., Sultana, S., Shahidullah, S. M., & Pearson, E. (2017). Using mHealth to support postabortion contraceptive use: Results from a feasibility study in urban Bangladesh. *JMIR Formative Research*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.2196/FORMATIVE.5151>
- Chen, H. H., Lee, C., Huang, J., Chi, L., & Hsiung, Y. (2021). Effect of an mHealth-Based Intervention on Excessive Gestational Weight Gain Prevention among Overweight and Obese Women : A Randomized Controlled Trial Table of Contents. *JMIR Preprints*.
- Drummond, P. D., Mizan, A., Brocx, K., & Wright, B. (2011). Barriers to accessing health care services for West African refugee women living in Western Australia. *Health Care for Women International*, 32(3), 206–224. <https://doi.org/10.1080/07399332.2010.529216>
- Fitriana Putri, U., Ratu, M., & Sri, S. (2020). Akses Pasangan Usia Subur (PUS) Miskin terhadap Informasi Keluarga Berencana (KB) di Kota Yogyakarta. *Populasi*, 28(1), 63. <https://doi.org/10.22146/jp.59620>
- Gagnon, A. J., Merry, L., & Robinson, C. (2002). A Systematic Review of Refugee Women's Reproductive Health. *Refugee*, 21(1), 6–17. <https://doi.org/10.25071/1920-7336.21279>
- Gray, N., Azzopardi, P., Kennedy, E., Willersdorf, E., & Creati, M. (2013). Improving adolescent reproductive health in Asia and the Pacific: Do we have the data? A review of DHS and MICS surveys in nine countries. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 25(2), 134–144. <https://doi.org/10.1177/1010539511417423>
- Harrington, E. K., Drake, A. L., Matemo, D., Ronen, K., Osoti, A. O., John-Stewart, G.,

- Kinuthia, J., & Unger, J. A. (2019). An mHealth SMS intervention on Postpartum Contraceptive Use among Women and Couples in Kenya: A randomized controlled trial. *American Journal of Public Health, 109*(6), 934–941. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305051>
- Indraswari, N., Sari, A. N., & Susanti, A. I. (2021). Gambaran Penggunaan Kontrasepsi Modern di Jawa Barat Berdasarkan Karakteristik Sosiodemografi dan Sumber Informasi. *Jurnal Menara Medika, 3*(1), 176–186. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menaramedika/article/view/2199&ved=2ahUKEwja66i_paDtAhU263MBHdUiAsUQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw0bUdEhasRIBe0InxidIHJo
- Janssens, K., Bosmans, M., Leye, E., & Temmerman, M. (2006). Sexual and reproductive health of asylum-seeking and refugee women in europe: Entitlements and access to health services. *Journal of Global Ethics, 2*(2), 183–196. <https://doi.org/10.1080/17449620600948002>
- Johnson, D., Juras, R., Riley, P., Chatterji, M., Sloane, P., Choi, S. K., & Johns, B. (2017). A randomized controlled trial of the impact of a family planning mHealth service on knowledge and use of contraception. *Contraception, 95*(1), 90–97. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2016.07.009>
- Kiley, J. W., Yee, L. M., Niemi, C. M., Feinglass, J. M., & Simon, M. A. (2010). Delays in request for pregnancy termination: comparison of patients in the first and second trimesters. *Contraception, 81*(5), 446–451. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2009.12.021>
- Mantell, J. E., Harrison, A., Hoffman, S., Smit, J. A., Stein, Z. A., & Exner, T. M. (2006). The Mpondombili Project: Preventing HIV/AIDS and Unintended Pregnancy among Rural South African School-Going Adolescents. *Reproductive Health Matters, 14*(28), 113–122. [https://doi.org/10.1016/S0968-8080\(06\)28269-7](https://doi.org/10.1016/S0968-8080(06)28269-7)
- Maslowsky, J., Frost, S., Hendrick, C. E., Trujillo Cruz, F. O., & Merajver, S. D. (2016). Effects of postpartum mobile phone-based education on maternal and infant health in Ecuador. *International Journal of Gynecology and Obstetrics, 134*(1), 93–98. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2015.12.008>
- McCarthy, O. L., Zghayyer, H., Stavridis, A., Adada, S., Ahamed, I., Leurent, B., Edwards, P., Palmer, M., & Free, C. (2019). An intervention delivered by mobile phone instant messaging to increase acceptability and use of effective contraception among Young Women in Bolivia: Randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research, 20*(228), 1–13. <https://doi.org/10.2196/14073>
- McCarthy, O., Ahamed, I., Kulaeva, F., Tokhirov, R., Saibov, S., Vandewiele, M., Standaert, S., Leurent, B., Edwards, P., Palmer, M., & Free, C. (2018).

Erratum: Correction to: A randomized controlled trial of an intervention delivered by mobile phone app instant messaging to increase the acceptability of effective contraception among young people in Tajikistan (Reproductive health (2018) 15 1 (28)). *Reproductive Health*, 15(1), 52. <https://doi.org/10.1186/s12978-018-0496-5>

Meo, M. L. N., & Nahak, M. P. M. (2020). Problem Kesehatan Reproduksi Perempuan Usia Subur Eks Pengungsi Timor Timur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkr.47128>

Mohamed, S., Chipeta, M. G., Kamninga, T., Nthakomwa, L., Chifungo, C., Mzembe, T., Vellemu, R., Chikwapulo, V., Peterson, M., Abdullahi, L., Musau, K., Wazny, K., Zulu, E., & Madise, N. (2023). Interventions to prevent unintended pregnancies among adolescents: a rapid overview of systematic reviews. *Systematic Reviews*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s13643-023-02361-8>

Oles, W., Alexander, M., Negron, R., Nelson, J., Iriarte, E., Aioldi, E. M., Christakis, N. A., & Forastiere, L. (2024). Maternal and child health intervention to promote behaviour change: a population-level cluster-randomised controlled trial in Honduras. In *BMJ Open* (Vol. 14, Issue 6). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-060784>

Oringanje, C., Meremikwu, M. M., Eko, H., Esu, E., Meremikwu, A., Ehiri, J. E., & 1GIDP. (2016). Interventions for preventing unintended pregnancies among adolescents. *Cochrane Library*, 1–106. <https://doi.org/10.7196/SAMJ.2020.v110i1.14281>

Palareti, G., Legnani, C., Cosmi, B., Antonucci, E., Erba, N., Poli, D., Testa, S., & Tositto, A. (2016). Comparison between different D-Dimer cutoff values to assess the individual risk of recurrent venous thromboembolism: Analysis of results obtained in the DULCIS study. *International Journal of Laboratory Hematology*, 38(1), 42–49. <https://doi.org/10.1111/ijlh.12426>

Ross, D. A., Chagalucha, J., Obasi, A. I. N., Todd, J., Plummer, M. L., Cleophas-Mazige, B., Anemona, A., Everett, D., Weiss, H. A., Mabey, D. C., Grosskurth, H., & Hayes, R. J. (2007). Biological and behavioural impact of an adolescent sexual health intervention in Tanzania: A community-randomized trial. *Aids*, 21(14), 1943–1955. <https://doi.org/10.1097/QAD.0b013e3282ed3cf5>

Shegaw, G., Mohammed, A. A., Nadew, K., Tamrat, K., Zeru, G., Desta, H., & Yinager, W. (2014). Long Acting Contraceptive Method Utilization and Associated Factors among Reproductive Age Women in Arba Minch Town, Ethiopia. *Greener Journal of Epidemiology and Public Health*, 2(1), 023–031. <https://doi.org/10.15580/gjeph.2014.1.070514294>

Smith, C., Ngo, T. D., Gold, J., Edwards, P., Vannak, U., Sokhey, L., Machiyama, K.,

- Slaymaker, E., Warnock, R., McCarthy, O., & Free, C. (2015). Effet d'une intervention par téléphone portable sur la contraception après avortement: Essai contrôlé randomisé au Cambodge. *Bulletin of the World Health Organization*, 93(12), 842–850. <https://doi.org/10.2471/BLT.15.160267>
- Smith, H. J., Portela, A. G., & Marston, C. (2017). Improving implementation of health promotion interventions for maternal and newborn health. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 17(1), 2–7. <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1450-1>
- Taylor, D., & James, E. A. (2011). An Evidence-Based Guideline for Unintended Pregnancy Prevention. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*, 40(6), 782–793. <https://doi.org/doi:10.1111/j.1552-6909.2011.01296.x>
- Taylor, D., Levi, A., & Simmonds, K. (2010). Reframing unintended pregnancy prevention: a public health model. *Contraception*, 81(5), 363–366. <https://doi.org/10.1016/j.contraception.2010.01.023>
- Taylor, M., Jinabhai, C., Dlamini, S., Sathiparsad, R., Eggers, M. S., & De Vries, H. (2014). Effects of a Teenage Pregnancy Prevention Program in KwaZulu-Natal, South Africa. *Health Care for Women International*, 35(7–9), 845–858. <https://doi.org/10.1080/07399332.2014.910216>
- Unger, J. A., Ronen, K., Perrier, T., DeRenzi, B., Slyker, J., Drake, A. L., Mogaka, D., Kinuthia, J., & John-Stewart, G. (2018). Short message service communication improves exclusive breastfeeding and early postpartum contraception in a low- to middle-income country setting: a randomised trial. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 125(12), 1620–1629. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.15337>
- Wati, M., Mariati, N., Rahmah, A., & Prabawati, S. A. (2023). Edukasi Kesehatan Reproduksi Sebagai Upaya Peningkatan Kepedulian Terhadap Kesehatan Wanita Usia Subur. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 41–53. <https://doi.org/10.30651/hm.v4i1.16121>
- WHO. (2011). WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes. *World Health Organization*, 192. http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241502214_eng.pdf?ua=1
- World Health Organisation. (2005). Report of a WHO technical consultation on birth spacing. *Report of a WHO Technical Consultation on Birth Spacing*, 13(6), 1–44. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/birth_spacing
- Yani, V. D., Emilia, O., & Kusnanto, H. (2014). Persepsi Remaja Terhadap Faktor Penghambat Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Di

Puskesmas Gambok Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 1(1), 34–45. <https://doi.org/10.22146/jkr.4913>

G. Glosarium

WUS = Wanita Usia Subur

CHAPTER 6

KONTRIBUSI FARMASI DALAM PENCEGAHAN KESALAHAN PENGGUNAAN OBAT

apt. Afifah Fauziyyah, S.Farm., M.Farm.

A. Pendahuluan

Kesalahan penggunaan obat (*medication error*) merupakan salah satu masalah utama dalam pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Kesalahan ini dapat terjadi pada setiap tahap proses penggunaan obat, mulai dari peresepan, penyiapan, pendistribusian, hingga penggunaan oleh pasien. Dampaknya tidak hanya menurunkan mutu pelayanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan morbiditas, mortalitas, serta beban biaya kesehatan (*Medication Without Harm*, 2024).

Farmasi sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kesalahan penggunaan obat. Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian tidak hanya bertanggung jawab pada pengelolaan obat, tetapi juga berperan aktif dalam menjamin keamanan, efektivitas, dan rasionalitas penggunaan obat.

B. Konsep dan Jenis Kesalahan Penggunaan Obat

1. Definisi Medication Error

Medication error didefinisikan sebagai setiap kejadian yang dapat dicegah yang berpotensi menyebabkan penggunaan obat yang tidak tepat atau membahayakan pasien. Definisi ini mencakup keseluruhan proses penggunaan obat mulai dari perencanaan, peresepan (*prescribing*), komunikasi, penyiapan, distribusi, sampai pemberian dan pemantauan obat, baik ketika berada dalam kendali tenaga kesehatan maupun pasien / konsumen (Tchijevitch et al., 2025)

2. Tahapan Terjadinya *Medication Error*

Kesalahan penggunaan obat dapat terjadi pada beberapa tahap, antara lain:

- a. Tahap peresepan (*prescribing error*)
- b. Tahap penyiapan dan peracikan (*dispensing error*)
- c. Tahap distribusi dan penyimpanan
- d. Tahap pemberian obat (*administration error*)
- e. Tahap pemantauan terapi obat (*monitoring error*) (Aronson, 2009).

3. Faktor Penyebab *Medication Error*

Beberapa faktor penyebab antara lain:

- a. Faktor manusia (kelelahan, kurang pengetahuan, kurang komunikasi)
- b. Faktor sistem (prosedur tidak baku, beban kerja tinggi)
- c. Faktor obat (kemasan mirip, nama obat mirip / LASA)
- d. Faktor lingkungan kerja (Kohn et al., 2000).

C. Peran Farmasi dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Secara umum peran farmasi yaitu memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan/atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, 2009). Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga vokasi farmasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, 2014).

1. Peran Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian

Dalam praktik kefarmasian kontemporer, peran apoteker tidak lagi sekadar berfokus pada pengelolaan dan penyediaan obat (*drug-oriented*), tetapi telah berkembang menjadi pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien (*patient-oriented*). Paradigma ini dikenal sebagai *pharmaceutical care* di mana apoteker bertanggung jawab langsung terhadap hasil terapi obat pasien, memastikan terapi yang diterima aman, efektif, rasional, dan sesuai kebutuhan pasien (Fares et al., 2025).

2. Pergeseran Orientasi Praktik Kefarmasian

Beberapa penelitian dan ulasan sistematik terbaru menegaskan bahwa praktik kefarmasian saat ini telah berubah dari fokus produk menjadi fokus pasien. Ini mencakup keterlibatan apoteker dalam pengelolaan terapi obat yang komprehensif dan peran aktif dalam tim kesehatan (Fares et al., 2025).

- a. Apoteker kini secara sistematis melibatkan diri dalam penilaian kebutuhan pasien, identifikasi masalah terapi obat, serta perencanaan dan monitoring hasil terapi.
- b. Secara global menunjukkan bahwa layanan *pharmaceutical care* yang dipimpin apoteker berkaitan dengan hasil klinis, perilaku, dan ekonomi yang lebih baik bagi pasien (Fares et al., 2025).

Apoteker modern berkontribusi lebih jauh dalam aspek klinis pelayanan kesehatan, misalnya:

- a. Menilai kesesuaian terapi dan potensi masalah terkait obat
- b. Mengoptimalkan penggunaan obat melalui rekomendasi terapi
- c. Memantau hasil terapi dan efek samping
- d. Memberikan edukasi serta konseling yang terarah kepada pasien

Penekanan ini tercermin dalam banyak ulasan ilmiah yang menyatakan bahwa peran apoteker telah meluas ke area manajemen terapi pasien yang kompleks (Owaidhah et al., 2022).

Efektivitas *patient-centered pharmacy practice* telah terbukti berdasarkan literatur terbaru yang menunjukkan bahwa *pharmaceutical care* yang dipimpin apoteker berpengaruh positif terhadap dampak pada pasien:

- a. Meningkatkan kepatuhan obat, kontrol penyakit kronis, **dan** kepuasan pasien (Khan et al., 2025).
- b. Mengurangi kejadian *medication error* dan *drug-related problems* melalui intervensi terstruktur (Owaidhah et al., 2022).
- c. Peran apoteker dalam klinik terintegrasi menunjukkan peningkatan akses layanan kesehatan berkualitas sekaligus meningkatkan keselamatan pasien (Thorakkattil et al., 2024).

Patient-oriented care dalam konteks farmasi berarti Praktik kefarmasian yang dirancang untuk mencapai hasil terapeutik spesifik pada pasien. Selain itu pendekatan yang berfokus pada pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian terapi sesuai kondisi individu. Komunikasi klinis yang aktif antara apoteker, pasien, dan tim kesehatan lainnya untuk membuat keputusan terapi yang terinformasi (Fares et al., 2025).

Definisi ini sejalan dengan filosofi *pharmaceutical care* dalam literatur ilmiah terbaru, yang menekankan peran apoteker sebagai manajer terapi obat yang mendukung keseluruhan perjalanan terapi pasien (Fares et al., 2025).

3. Peran Tenaga Vokasi Farmasi dalam Pelayanan Kefarmasian

Peran tenaga vokasi farmasi dijalankan di bawah supervisi dan tanggung jawab apoteker, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit, 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas, 2016).

4. Peran dalam Pelayanan Farmasi Klinik

Dalam pelayanan farmasi klinik, tenaga vokasi farmasi memiliki peran pendukung, antara lain:

- a. Menyiapkan obat sesuai resep yang telah diverifikasi apoteker
- b. Melakukan pelabelan dan pengemasan obat
- c. Membantu proses penyerahan obat kepada pasien
- d. Mendukung dokumentasi pelayanan kefarmasian

Tenaga vokasi farmasi tidak memiliki kewenangan klinis mandiri, seperti pengambilan keputusan terapi atau konseling klinis mendalam, namun berkontribusi dalam memastikan proses pelayanan berjalan akurat dan aman (Permenkes RI No. 73 Tahun 2016; Cipolle et al., 2012).

Tenaga vokasi farmasi berperan strategis dalam pencegahan *medication error*, terutama pada tahap:

- a. Penyiapan dan peracikan obat
- b. Pelabelan dan etiket obat
- c. Penerapan prinsip “5 benar”
- d. Pelaporan kejadian *near miss* kepada apoteker

Keterlibatan tenaga vokasi farmasi dalam sistem keselamatan pasien mendukung upaya pencegahan kesalahan sistemik, khususnya pada tahap dispensing dan distribusi obat (NCC MERP, 2020; ISMP, 2023).

5. Batasan Kewenangan Tenaga Vokasi Farmasi

Sesuai regulasi, tenaga vokasi farmasi:

- a. Wajib bekerja di bawah pengawasan apoteker
- b. Tidak berwenang melakukan penilaian klinis mandiri
- c. Tidak berwenang mengganti terapi tanpa persetujuan apoteker/dokter

Pembatasan kewenangan ini bertujuan menjaga keselamatan pasien serta menjamin pelayanan kefarmasian tetap sesuai standar profesi dan hukum yang berlaku (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit, 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas, 2016).

D. Kontribusi Farmasi dalam Pencegahan Kesalahan Penggunaan Obat

1. Pencegahan pada Tahap Peresepan

Apoteker berperan dalam:

- a. Melakukan skrining resep (administratif, farmasetika, klinis)
- b. Mengidentifikasi potensi interaksi obat, duplikasi terapi, dosis tidak tepat

- c. Berkomunikasi dengan dokter untuk klarifikasi resep (Cipolle et al., 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit, 2016)
- 2. Pencegahan pada Tahap Penyiapan dan Penyerahan Obat
Upaya yang dilakukan antara lain:
 - a. Penerapan prinsip 5 benar (benar pasien, obat, dosis, cara, waktu)
 - b. Penerapan *double check system*
 - c. Penataan obat LASA dengan sistem khusus
 - d. Pemberian etiket dan informasi yang jelas (*Medication Without Harm*, 2024)
- 3. Pencegahan pada Tahap Penggunaan oleh Pasien
Apoteker berperan melalui:
 - a. Konseling dan edukasi pasien
 - b. Pemberian informasi obat (PIO)
 - c. Penggunaan media bantu seperti leaflet dan *medication chart* (Cipolle et al., 2012)
- 4. Pemantauan dan Pelaporan Medication Error
Apoteker juga berperan dalam:
 - a. Monitoring efek samping obat dan kesalahan penggunaan obat
 - b. Pelaporan *incident* dan *near miss*
 - c. Berperan aktif dalam program keselamatan pasien (Cipolle et al., 2012)

E. Pendekatan Sistem untuk Meningkatkan Keamanan Penggunaan Obat

1. Penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO)

Penerapan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang jelas, baku, dan konsisten merupakan salah satu strategi penting dalam sistem pelayanan kefarmasian untuk mengurangi variasi praktik yang dapat menjadi penyebab *medication error*, kesalahan yang terjadi akibat perbedaan cara kerja antar individu atau tim. SOP mendefinisikan langkah kerja yang harus diikuti setiap petugas, mulai dari penerimaan resep sampai penyerahan obat kepada pasien, termasuk langkah-langkah kritis seperti verifikasi resep, penyiapan obat, pelabelan, dan pencatatan dokumentasi (Cipolle et al., 2012).

SPO berperan sebagai alat sistemik untuk standarisasi proses, sehingga meskipun dilakukan oleh orang atau tim yang berbeda, hasil praktik kefarmasian tetap konsisten, akurat, dan sesuai standar mutu pelayanan. Kepatuhan terhadap SPO juga mempermudah identifikasi *deviation* (penyimpangan prosedur) yang menjadi faktor risiko utama terjadinya kesalahan pemberian, serta

memungkinkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelayanan kefarmasian (Da Ate & Lani, 2025).

Sebuah studi kasus pada pemberian obat intravena di unit pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa ketika prosedur operasional standar diterapkan dengan benar, kejadian *medication error* dapat dicegah secara efektif, meskipun riset di area farmasi klinik masih berkembang, indikator awal ini menekankan pentingnya SOP yang diikuti secara disiplin (Da Ate & Lani, 2025).

Selain itu, panduan operasional seperti yang disusun dalam SOP pengendalian dan pelaporan kesalahan medikasi menjelaskan bahwa prosedur tertulis harus mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menangani, dan melaporkan kejadian kesalahan obat, sehingga membantu fasilitas kesehatan dalam menyusun *feedback loop* untuk peningkatan keselamatan pasien (Da Ate & Lani, 2025).

Oleh karena itu, penerapan SPO di instalasi farmasi harus dipandang sebagai bagian dari strategi *quality assurance* dan *risk management* yang terintegrasi, bukan hanya sebagai dokumen administratif. Kepatuhan terhadap SPO selaras dengan prinsip *patient safety* dan *good pharmacy practice* yang menjadi dasar standar pelayanan kefarmasian modern.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan:

- a. Resep elektronik (*e-prescribing*)
- b. Sistem komputerisasi farmasi
- c. Barcode medication system Terbukti dapat menurunkan angka medication error (World Health Organization, 2024).

3. Budaya Keselamatan Pasien

Pencegahan medication error tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga pada sistem dan budaya organisasi yang mendukung pelaporan tanpa menyalahkan (*no blame culture*) (Kohn et al., 2000).

F. Tantangan dan Peluang Peran Farmasi di Indonesia

Beberapa tantangan antara lain keterbatasan SDM, beban kerja tinggi, dan belum optimalnya implementasi pelayanan farmasi klinik di semua fasilitas kesehatan. Namun, peluang penguatan peran farmasi sangat besar seiring dengan tuntutan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit, 2016).

G. Penutup

Farmasi memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pencegahan kesalahan penggunaan obat melalui peran apoteker dalam setiap tahapan proses penggunaan obat. Pendekatan sistem, peningkatan kompetensi SDM, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama dalam mewujudkan penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional.

H. Referensi

- Aronson, J. K. (2009). Medication errors : definitions and classification. *British Journal of Clinical Pharmacology*, 67(6), 599–604. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2009.03415.x>
- Bates, D. W., Leape, L. L., Cullen, D. J., Laird, N., Petersen, L. A., Teich, J. M., Burdick, E., Hickey, M., Kleeefield, S., Shea, B., Vliet, M. Vander, & Seger, D. L. (1998). Effect of Computerized Physician Order Entry and a Team Intervention on Prevention of Serious Medication Errors. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 280(15), 1311–1316.
- Cipolle, R. J., Strand, L. M., & Morley, P. C. (2012). *Pharmaceutical Care Practice : The Patient- Centered Approach to Medication Management Services*.
- Da Ate, Y. F., & Lani, M. F. N. (2025). Implementasi Standar Prosedur Operasional (SPO) Pemberian Obat Intravena Melalui Selang Infus di Ruang Dahlia BLUD RSUD dr. T.C. Hillers Maumure. *Jurnal Keperawatan Duta Medika*, 5(1), 23–32.
- Fares, R., Marjorie, B., Chaballe, C., & Crunenber, R. (2025). The outcomes of pharmacist-led pharmaceutical care within community pharmacies: An overview of systematic reviews. *Research in Social & Administrative Pharmacy*, 21(5), 332–339. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2025.01.015>
- Khan, R., Mubarak, N., & Waqar, M. A. (2025). A comprehensive global review on pharmacist-led strategies to support medication therapy in hypertensive patients. *Journal of Human Hypertension*, 39, 1–27.
- Kohn, L. T., Corrigan, J. M., & Donaldson, M. S. (2000). *To Err Is Human: Building a Safer Health System*. <https://doi.org/10.17226/9728>
- Medication Without Harm (2024).
- Owaidhah, T. N., Alahmadi, Y. M., Almoutairi, M. H., Marwan, F., Hazazi, A. Y., Rezq, R. H., Albedaiwi, Y. Y., & Ghazi, G. (2022). The Expanding Clinical Role of Pharmacists in Modern Healthcare : A Comprehensive Review of Patient-Centered Interventions. *Vascular & Endovascular Review Journal*, 8(11), 240–247.

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit, 63 (2016).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas, 48 (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, 41 (2009).
- Tchijevitch, O., Hansen, S. M., Hallas, J., Bogh, S. B., Mulac, A., Walløe, S., Clausen, M. K., & Birkeland, S. (2025). Methodological Approaches for Analyzing Medication Error Reports in Patient Safety Reporting Systems: A. *The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety*, 51(1), 46–73. <https://doi.org/10.1016/j.jcjq.2024.10.005>
- Thorakkattil, S. A., Parakkal, S. A., Salim, K. T. M., Arain, S., Krishnan, G., Madathil, H., Kuzhiyil, A. K., Aslam, A., Abdulsalim, S., Karuppannan, M., Sridhar, S. B., Shareef, J., & Unnikrishnan, M. K. (2024). Improving patient safety and access to healthcare: The role of pharmacist-managed clinics in optimizing therapeutic outcomes. *Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy*, 16(July), 13. <https://doi.org/10.1016/j.rcsop.2024.100527>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, 78 (2014).

CHAPTER 7

PERAN GIZI DALAM PENCEGAHAN MASA GIZI DAN PENYAKIT TERKAIT

Salman, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Gizi memainkan peran sentral dalam pencegahan masalah gizi seperti stunting dan obesitas, serta penyakit terkait seperti diabetes dan hipertensi. Saat ini Indonesia menghadapi beban gizi ganda yang kompleks, ditandai dengan tingginya prevalensi stunting pada balita sekaligus peningkatan obesitas pada dewasa. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, melaporkan bahwa prevalensi stunting turun dari 21,6% menjadi 19,8%. Meskipun ada penurunan, angka ini masih jauh di atas target Renstra Kemenkes 2025-2029 yaitu sebesar 14,2%. Secara bersamaan, obesitas pada orang dewasa terus meningkat akibat pola makan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), serta gaya hidup sedenter perkotaan, mencapai prevalensi overweight 23,4% pada anak usia sekolah di kota besar, menurut SKI 2023.

Dampak dari krisis gizi ganda, terjadi beban ekonomi gizi ganda yang mencapai Rp 300 triliun per tahun. Ini setara dengan 2-3% PDB nasional, yang timbul dari hilangnya produktivitas akibat stunting (IQ rendah, prestasi belajar buruk). Selain itu biaya pengobatan Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti diabetes tipe 2 (prevalensi 11,7%) serta hipertensi (34%). Krisis ini bersifat lifecourse: stunting masa kanak-kanak berujung pada metabolic syndrome dewasa, menciptakan siklus antargenerasi yang merusak demographic bonus Indonesia.

Relevansi permasalahan ini selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 2 "Zero Hunger" yang menargetkan eliminasi stunting multidimensional, serta visi Indonesia Emas 2045 yang mensyaratkan generasi human capital unggul dengan status gizi optimal. Pencegahan melalui 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) menjadi strategi kunci, sebagaimana ditegaskan dalam UU Kesehatan No. 17/2023 Pasal 68 tentang upaya promotif-preventif gizi terintegrasi.

Bab ini membahas tentang: 1). Strategi gizi dalam pencegahan dan penatalaksanaan stunting melalui 1000 HPK, 2). Pentingnya penerapan pedoman gizi seimbang, 3). Gizi buruk; gejala, mencegah dan mengobati, 4). Strategi penanggulangan masalah gizi ganda. Pembahasan topik ini bertujuan menguraikan peran strategis gizi dalam pencegahan masalah gizi (stunting, wasting, obesitas)

melalui pendekatan promotif,-preventif yang berbasis bukti. Secara spesifik, materi ini diharapkan dapat: (1) menyediakan konsep dasar dan strategi pencegahan masalah gizi yang dapat diimplemetasikan oleh ahli gizi; (2) mengintegrasikan kebijakan nasional seperti 11 program intervensi stunting 1000 HPK dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); serta (3) memberikan rekomendasi praktis untuk penguatan kompetensi profesi sesuai Standar Profesi Nutrisionis Indonesia (KMK No. HK.01.07/MENKES/342/2020).

Target pembaca adalah ahli gizi klinik, ahli gizi masyarakat, dosen program studi D3/S1 Gizi, mahasiswa gizi serta praktisi kesehatan di UPKDK/Posyandu yang bertanggung jawab atas perbaikan, pengendalian dan penanggulangan masalah gizi.

B. Strategi Gizi dalam Pencegahan dan Penatalaksanaan Stunting Melalui 1000 HPK

Strategi pencegahan stunting nasional berpusat pada 11 intervensi prioritas 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sesuai Renstra Kemenkes 2025-2029, dengan coverage target $\geq 90\%$ untuk mencapai stunting menjadi 14,2% pada tahun 2029. Program pencegahan dan penatalaksaan stunting ini focus pada ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 0-23 bulan yang merupakan masa kritis bagi pertumbuhan optimal yang dikenal sebagai periode 1000 HPK. Intervensi meliputi pemeriksaan kehamilan berkualitas, suplementasi mikronutrien seperti zat besi, asam folat, vitamin A, dan Zinc, serta pemantauan pertumbuhan bayi secara rutin. Intervensi ini mampu mengurangi resiko stunting secara signifikan apabila dilaksanakan secara menyeluruh.

Program Intervensi Gizi Spesifik Stunting

1. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Terpadu dan Berkualitas

Pemeriksaan Antenatal Care pada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan fokus pada pengecekan status gizi ibu, tekanan darah dan resiko anemia. ANC juga menjadi momen edukasi tentang pentingnya asupan gizi seimbang, konsumsi tablet tambah darah (TTD), asam folat serta persiapan kelahiran.

2. Suplementasi tablet Tambah Darah (TTD) dan Asam Folat

Anemia pada ibu hamil meningkatkan resiko bayi lahir premature dan stunting. Oleh karena itu Kemenkes menetapkan bahwa setiap bumil wajib mendapatkan suplementasi zat besi (TTD) 90 tablet dan 400 μg asam folat perhari selama minimal 90-120 hari. Kedua suplemen ini efektif mencegah anemia dan mendorong pembentukan sel darah dan jaringan janin.

3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu Hamil KEK

Ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat PMT berupa makanan tambahan tinggi energi, protein dan zat besi. Misalnya campuran kacang hijau, telur, ikan dan sayuran. Ini bertujuan mendukung kenaikan berat badan ibu dan pertumbuhan janin yang optimal

4. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) segera setelah Lahir

Proses IMD dengan meletakkan bayi di dada ibu dalam 1 jam pertama bermanfaat besar untuk ikatan ibu dan anak, memacu keluarnya hormon oksitosin, serta meningkatkan kolostrum kaya nutrisi dan antibodi, sangat penting untuk imunitas pasca kelahiran.

5. Promosi dan Dukungan ASI Eksklusif selama 6 bulan pertama

WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan untuk mendukung pertumbuhan dan menurunkan risiko infeksi. Data Riskesdas 2021 menunjukkan cakupan ASI eksklusif di Indonesia baru 52,5%, turun drastis pasca Covid-19. Konseling laktasi dan dukungan lingkungan sangat dibutuhkan untuk mendorong praktik pemberian ASI eksklusif.

6. Suplementasi Vitamin A untuk Ibu Nifas

Setelah persalinan, ibu nifas mendapat vitamin A dosis tinggi (200.000 IU). Ini ditujukan untuk memperkuat daya tahan tubuh, mencegah infeksi dan meningkatkan kualitas ASI. Vitamin A juga berperan dalam mempertahankan epitel dan sistem imun ibu dan bayi.

7. Pemberian MP-ASI yang Berkualitas, Adekuat, Aman dan Tepat Waktu

Usia 6 bulan, bayi mulai dikenalkan MP-ASI adekuat yang kaya energi, protein (khususnya protein hewani seperti telur, daging, ikan), dan mikronutrien. MP-ASI diberikan secukupnya sesuai tekstur serta tahapan usia.

8. Suplementasi Vitamin A untuk Balita

Vitamin A juga rutin diberikan pada anak balita (6-59 bulan), setiap 6 bulan sekali (100.000 IU untuk anak <12 bulan, 200.000 IU untuk anak 12-59 bulan). Suplementasi ini mencegah kemungkinan infeksi berat dan komplikasi mata.

9. Suplementasi Zinc untuk Penanganan Diare

Zinc sangat efektif untuk membantu menyembuhkan diare dan mencegah kekambuhan. WHO merekomendasikan dosis 20 mg per hari selama 10-14 hari (10 mg/hari untuk usia kurang dari 6 bulan pada anak dengan diare. Suplementasi Zinc bukan hanya memperpendek durasi diare, tapi juga memperkuat imunitas usus.

10. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan secara Rutin di Posyandu/Faskes

Pemantauan berat badan dan tinggi badan secara rutin (setiap 1-3 bulan) di Posyandu atau fasilitas kesehatan (faskes) sangat penting. Deteksi dini

memungkinkan intervensi cepat (konseling gizi, rujukan medis) jika terjadi penurunan berat badan atau lambatnya pertumbuhan tinggi badan.

11. Tata Laksana Anak dengan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Anak dengan malnutrisi ringan hingga sedang mendapat edukasi dan makanan tambahan seimbang. Sedangkan anak gizi buruk (severe acute malnutrition/SAM) ditangani dengan terapi khusus, seperti pemberian susu formula WHO (F-75 dan F-100) di fasilitas kesehatan, dan pemantauan ketat hingga kenaikan berat badan memadai.

C. Pentingnya Penerapan Pedoman Gizi Seimbang

Konsep gizi seimbang sudah muncul sejak tahun 1992 pada kongres gizi internasional di Roma. Pada tahun 1995 semua negara direkomendasikan untuk mengembangkan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS). Negara Malaysia (2011), mengembangkan Malaysian Food Pyramid yang mencakup pedoman porsi konsumsi setiap kelompok jenis makanan. Amerika Serikat (2020), mengeluarkan *Dietary Guidelines for Americans* yang menganjurkan berbagai jenis makanan yang harus dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi serta anjuran untuk meningkatkan kesehatan/pencegahan penyakit. Di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan Pedoman Gizi Seimbang sejak tahun 2014, yang berisi tentang pedoman konsumsi makanan serta pola hidup yang sehat untuk mencapai status gizi dan kesehatan yang optimal, termasuk pesan khusus bagi kelompok ibu hamil-menyusui, anak dan kelompok lansia.

Pedoman gizi seimbang merupakan panduan konsumsi makanan sehari-hari berdasarkan empat pilar utama, sepuluh pesan umum, dan beberapa pesan khusus. Empat pilar utama dalam Pedoman Gizi Seimbang yaitu:

1. Mengonsumsi Aneka Ragam Pangan.

Pilar ini menjelaskan bahwa kita harus mengonsumsi berbagai kelompok dan jenis bahan makanan, karena tidak ada satupun bahan makanan yang nilai gizinya sempurna untuk memenuhi kebutuhan harian (kecuali ASI bagi bayi <6 bulan). Selain macam dan jenisnya yang beragam, kita juga harus memperhatikan proporsi makanan yang seimbang tidak kurang ataupun berlebih dari kebutuhan.

2. Membiasakan Perilaku Hidup Bersih.

Budaya perilaku hidup bersih akan menurunkan risiko terkena penyakit infeksi. Penyakit infeksi berkaitan langsung dengan status gizi kurang karena akan mengurangi asupan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Budaya hidup bersih ini diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, menjaga kebersihan lingkungan, dll.

3. Melakukan Aktivitas Fisik.

Aktivitas fisik meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga. Aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan yang masuk ke dalam tubuh.

4. Memantau Berat Badan Secara Teratur untuk Mempertahankan Berat Badan Normal

Pemantauan berat badan bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan berat badan (baik kurang maupun lebih) sehingga tetap pada berat badan normal. Apabila terdapat penyimpangan dapat segera dilakukan intervensi untuk mencapai berat badan normal.

Dalam pedoman gizi seimbang terdapat sepuluh pesan umum yang berlaku untuk kelompok masyarakat usia dewasa dan dalam kondisi sehat.

1. Syukuri dan nikmati anekaragam makanan Cara konkret menerapkan pesan ini adalah dengan mengonsumsi lima kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan, seperti panduan "Isi Piringku".
2. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Dianjurkan konsumsi 3-4 porsi sayur serta 2-3 porsi buah setiap hari (rerata kebutuhan gizi kelompok dewasa)
3. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi Dapat diperoleh dari lauk hewani maupun lauk nabati, dikonsumsi sesuai kebutuhan.
4. Biasakan mengonsumsi anekaragam makanan pokok.

Mayoritas masyarakat Indonesia mengenal nasi sebagai makanan pokok. Makanan pokok dapat diperoleh dari beragam bahan makanan seperti jagung, ubi, singkong, kentang, dan lain sebagainya.

5. Batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak.

Batasi konsumsi gula maksimal 4 sendok makan per hari, garam maksimal 1 sendok teh per hari, dan minyak maksimal 5 sendok makan per hari.

6. Biasakan sarapan.

Sarapan akan memberikan energi bagi kita untuk beraktivitas hingga siang hari, menurunkan risiko konsumsi jajan tidak sehat serta mengontrol asupan makan siang sehingga dapat mencegah berat badan berlebih.

7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman.

Air sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Cukupi kebutuhan air putih anda rerata 8 gelas setiap hari bagi orang dewasa.

8. Biasakan membaca label pada kemasan pangan.

Label pada makanan akan membantu dalam mengetahui bahan-bahan yang terkandung, informasi nilai gizi, serta tanggal kadaluwarsa produk.

9. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir.

Pentingnya mencuci tangan secara baik dan benar untuk menjaga kebersihan dan mencegah risiko penyakit infeksi maupun penyakit menular.

10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal

Aktivitas fisik dikatakan cukup apabila melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 kali dalam seminggu (@30 menit)

Isi Piringku, Panduan Kebutuhan Gizi Seimbang Harian

Isi piringku adalah panduan kebutuhan gizi harian seimbang, yang lahir dari perkembangan ilmu dan penyempurnaan para ahli gizi, dan disusun oleh Kementerian Kesehatan RI.

Dalam Isi Piringku setiap kali makan, 50 persen piring diisi dengan sayur dan buah, sedangkan 50 persen lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk.

Makanan Pokok

Merupakan sumber karbohidrat dan tenaga utama, didapat dari beragam bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok di Indonesia beraneka ragam, seperti beras, jagung, sagu dan umbi-umbian (ubi, talas, singkong), kentang, gandum dan produk olahannya, seperti mie, roti dan pasta. Konsumsinya disesuaikan dengan kondisi, kebiasaan, dan budaya setempat. Meski beragam, bahan makanan pokok harus memenuhi syarat-syarat:

1. Mengandung karbohidrat (HA)
2. Bersifat menyenangkan
3. Rasanya netral
4. Harganya murah
5. Mudah didapat, ditanam dan diolah
6. Bisa disimpan lama

Lauk Pauk

Merupakan sumber protein hewani dan nabati yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lauk hewani kandungan kolesterol dan lemaknya lebih tinggi, namun memiliki kandungan asam amino yang lebih lengkap dan mudah diserap tubuh. Sedangkan lauk nabati kandungan lemak tak jenuh dan isoflavonnya lebih tinggi, namun berisiko kurang higienis dalam proses pengolahannya dari kacang-kacangan.

Contoh lauk hewani adalah daging merah (sapi, kambing, dll), unggas (ayam, bebek), ikan dan hasil laut, telur, susu dan produk olahannya. Sedangkan lauk nabati

antara lain tahu, tempe, kacang-kacangan (kacang tolo, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau)

Buah-buahan

Merupakan sumber serat, vitamin dan mineral yang memiliki berbagai manfaat berikut ini:

1. Mengandung air dan sumber gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh.
2. Sumber antioksidan alami terbesar yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
3. Mencegah berbagai penyakit kronis, seperti stroke, jantung, hipertensi, kanker, dan kerusakan hati.
4. Kaya vitamin, mineral dan zat penting lainnya yang dapat menjaga kebugaran tubuh.

Konsumsi rutin buah-buahan, seperti pisang, melon, semangka, pepaya, belimbing, apel, jambu air dan lain sebagainya untuk mendapatkan manfaat optimalnya.

Sayur-sayuran

Merupakan sumber berbagai nutrisi penting, seperti asam folat, potassium, karoten, zat besi, vitamin A, vitamin C dan vitamin E, dengan kandungan air yang tinggi. Manfaat sayur-sayuran antara lain

1. Mengurangi dan mencegah stress
2. Membuat BAB lebih lancar
3. Mencegah penyakit kronis, seperti jantung, stroke dan kanker
4. Menjaga berat badan seimbang
5. Membersihkan racun dalam tubuh (detoksifikasi)
6. Mencegah cacat pada bayi
7. Menjaga kesehatan mata dan kulit
8. Memperkuat tulang

Contoh sayur-sayuran antara lain terong, timun, bayam, kangkung, buncis, brokoli, wortel, tomat, kol dan lain sebagainya.

D. Gizi Buruk; Gejala, Mencegah dan Mengobati

Mengenal Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan kondisi tubuh seorang individu tidak memperoleh nutrisi yang memadai dari makanan yang dikonsumsi, sehingga tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang sesuai kebutuhan. Gizi buruk dapat mengacu pada kelebihan gizi maupun kekurangan gizi, tetapi ada kecenderungan umum bahwa gizi buruk terkait dengan kekurangan gizi.

Kekurangan gizi bisa terjadi karena berbagai macam faktor, seperti faktor finansial ataupun masalah kesehatan yang membuat seorang individu tak bisa mendapatkan nutrisi sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), kekurangan gizi memiliki empat bentuk, yakni:

1. *Wasting*: berat badan dibanding tinggi badan sangat rendah atau di bawah ambang batas normal
2. *Stunting*: tinggi badan di bawah standar untuk usianya
3. *Underweight*: berat badan kurang untuk usianya
4. *Micronutrient deficiencies*: tubuh kekurangan mikronutrien berupa vitamin dan mineral

Ketika seseorang mengalami gizi buruk, proses tumbuh kembangnya akan terganggu. Kondisi ini juga akan mempengaruhi perkembangan otak anak yang dampaknya akan tampak dari tingkat kecerdasan dan kemampuan belajar. Kondisi kesehatan individu yang mengalami gizi buruk juga cenderung lebih rentan daripada seseorang yang mendapatkan gizi yang cukup.

Gizi buruk juga menjadi salah satu penyebab kematian tidak langsung pada anak. Karena itu, penting untuk mencegah dan menanggulangi gizi buruk terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan, yakni dari saat kehamilan hingga anak usia dua tahun.

Gejala Gizi Buruk

Gejala gizi buruk muncul secara bertahap dan bisa berbeda-beda antara satu individu dan yang lain. Tanda dan gejala yang mungkin dapat terjadi meliputi:

1. Pertumbuhan terhambat atau tak sesuai dengan kurva pertumbuhan normal
2. Mudah lelah
3. Kulit kering
4. Rambut kusam
5. Masalah pada sistem pencernaan seperti diare dan konstipasi
6. Daya tahan tubuh melemah sehingga lebih mudah terkena infeksi dan sembuh lebih lama

7. Tidak terlalu berselera makan
8. Gangguan fungsi kognitif
9. Pembengkakan pada bagian perut dan kaki

Penyebab Gizi Buruk

Penyebab gizi buruk bisa bermacam-macam dan bisa bersumber dari internal orang itu sendiri ataupun dari faktor eksternal. Penyebab yang umum antara lain:

1. Kurangnya asupan makanan dengan kandungan nutrisi yang cukup
2. Penyakit kronis yang menghambat penyerapan nutrisi, antara lain tuberkulosis dan infeksi usus
3. Masalah kesehatan yang mempengaruhi pencernaan, seperti penyakit *crohn*, penyakit *celiac*, dan gangguan pada usus
4. Kebiasaan makan yang tidak sehat, seperti pola makan kurang variatif, praktik makan dengan gizi tidak seimbang, dan banyak konsumsi makanan cepat saji atau kurang sehat yang rendah gizi
5. Kebutuhan energi dan zat gizi yang meningkat, misalnya baru menjalani pemulihan dari cedera serius atau luka bakar atau sedang dalam masa kehamilan dan menyusui

Cara Mengatasi Gizi Buruk

Bila sudah mendiagnosis seseorang mengalami gizi buruk, dokter atau ahli gizi akan membuat rencana perawatan yang disesuaikan dengan kondisi gizi orang tersebut. Penanganan gizi buruk umumnya dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan tim perawatan yang mencakup ahli gizi dan dokter lain, terutama jika ada kondisi kesehatan yang melatar belakangi ataupun komplikasi.

Metode yang dapat digunakan antara lain:

1. Pemantauan dan tes *screening* secara berkelanjutan
2. Penyusunan rencana diet yang tepat, termasuk konsumsi suplemen bila dibutuhkan
3. Penanganan gejala secara spesifik
4. Perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat
5. Penanganan masalah kesehatan yang melatari
6. Dalam kasus yang parah, dokter bisa memberikan nutrisi melalui jalur intravena/infus

Komplikasi Gizi Buruk

Ada sederet komplikasi serius yang bisa terjadi akibat gizi buruk, seperti:

1. Pertumbuhan terhambat yang bisa mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar
2. Masalah kesehatan kulit
3. Kehilangan massa otot dan kelemahan otot sehingga sulit melakukan aktivitas sehari-hari
4. Mudah sakit dan sulit sembuh ketika sakit
5. Anemia yang bisa menurunkan daya tahan tubuh
6. Kerusakan organ, terutama ginjal, hati, dan jantung
7. Gangguan kesehatan mental
8. Risiko kematian, khususnya di kalangan anak-anak

Pencegahan Gizi Buruk

Langkah pencegahan gizi buruk yang utama adalah memastikan tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan. Caranya antara lain menerapkan pola makan gizi seimbang dengan memastikan terdapat berbagai jenis makanan yang mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan untuk dikonsumsi setiap hari.

Bagi anak-anak ataupun lansia yang memiliki kondisi kesehatan kronis atau parah, mungkin dibutuhkan suplemen untuk mencukupi kebutuhan mereka. Seorang ibu juga memiliki peran besar dalam mencegah gizi buruk dengan memastikan kecukupan nutrisi selama masa kehamilan dan mengutamakan pemberian air susu ibu kepada bayi yang baru lahir hingga setidaknya berusia 6 bulan.

E. Strategi Penanggulangan Masalah Gizi Ganda

Hasil Survei Status Gizi Indonesi (SSGI) 2024 menunjukkan adanya penurunan signifikan prevalensi *stunting* secara nasional menjadi 19,8%. Ini melampaui proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar 20,1%. Penurunan prevalensi *stunting* menjadi 19,8% ini merupakan sebuah pencapaian positif, namun demikian, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tentunya belum boleh lengah. Tantangan ke depan adalah bagaimana upaya mempertahankan tren positif ini serta mempercepat penurunan *stunting* agar target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2045 dapat tercapai.

Menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan gizi merupakan salah satu prioritas utama bagi berbagai negara di dunia sebagaimana tercantum dalam SDGs 2. Permasalahan gizi bisa terjadi karena kekurangan atau kelebihan gizi. Kelebihan

gizi (kelebihan berat badan dan obesitas) dan kekurangan gizi (stunting, wasting, underweight, dan kekurangan zat gizi mikro) sering kali terjadi secara bersamaan pada individu, rumah tangga, dan populasi yang sama, yang disebut dengan Masalah Gizi Ganda (MGG). MGG berpengaruh pada semua negara, baik negara kaya maupun miskin. Berdasarkan Global Nutrition Report (2022), dari 141 negara yang dianalisis, 88% (124 negara) mengalami lebih dari satu bentuk permasalahan gizi, dan 29% (41 negara) mengalami ketiga bentuk permasalahan gizi serius. Kelompok rentan, terutama anak-anak mengalami berbagai bentuk permasalahan gizi: 3,62% anak balita di dunia (15,95 juta anak) mengalami stunting dan wasting, sementara 1,87% balita lainnya (8,23 juta anak) mengalami stunting dan kelebihan berat badan. Pada kelompok dewasa, perempuan adalah kelompok yang paling banyak terkena dampak MGG. Prevalensi MGG di tingkat rumah tangga, dimana anak-anak yang mengalami stunting hidup berdampingan dengan perempuan yang kelebihan berat badan/obesitas. Pada tingkat individu, bentuk MGG yang paling umum tampak adalah kelebihan gizi dan kekurangan zat besi, kombinasi yang sering ditemukan. Diprediksi bahwa sampai dengan tahun 2050 dan tahun 2100 permasalahan gizi ganda tetap akan terjadi, dengan laju prevalensi yang berbeda, dimana prevalensi underweight akan menurun, sedangkan prevalensi overweight dan obese akan terus meningkat (Bodirsky et al.2020).

Di Indonesia permasalahan gizi ganda ditunjukkan dengan adanya permasalahan gizi kurang dan gizi lebih pada satu populasi. Hal ini terjadi, dimana permasalahan gizi stunting terkategori tinggi diiringi dengan permasalahan gizi lebih pada dewasa yang terus meningkat.

Prevalensi gizi lebih pada penduduk dewasa terus meningkat baik diperdesaan maupun diperkotaan. Secara nasional terjadi prevalensi gizi lebih pada penduduk dewasa, meningkat hampir dua kali lipat lebih tinggi pada tahun 2018 (35,4%) dibandingkan dengan tahun 2013 (19,1%). Prevalensi gizi lebih pada penduduk dewasa juga menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat tinggi. Dengan memperhatikan kriteria permasalahan gizi ganda (30% balita stunting dan 30% kelebihan berat badan/overweight), maka Indonesia mengalami pergeseran permasalahan gizi yang dihadapi sebagian besar provinsi. Pada tahun 2013, sebagian besar provinsi mengalami masalah gizi kurang (stunting). Sementara itu pada tahun 2018, separuh provinsi di Indonesia mengalami MGG. Hal ini terjadi karena meningkatnya masalah kegemukan yang signifikan dalam lima tahun. Seiring dengan meningkatnya prevalensi obesitas, prevalensi penyakit tidak menular (PTM) terkait pola makan seperti hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan stroke juga memiliki tren yang meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus

berupaya untuk menguatkan program penyelesaian permasalahan gizi ganda (*double duty action*).

Tidak ada solusi tunggal dalam menangani MGG, namun diperlukan portofolio kebijakan, investasi dan perundang-undangan yang koheren. Tindakan di seluruh sistem pertanian, pangan, kesehatan, dan lingkungan diperlukan untuk menurunkan biaya makanan bergizi dan meningkatkan keterjangkauan pola makan sehat, namun juga memastikan harga yang adil bagi produsen. Dengan demikian perlu dilakukan transformasi sistem pangan untuk perbaikan gizi dan kesehatan. Transformasi sistem pangan diperlukan untuk menghasilkan pola makan yang aman, berkelanjutan, dan sehat, terjangkau, serta membangun dan menghormati budaya, dan pengetahuan lokal. Terdapat 10 prioritas aksi untuk menangani MGG di Indonesia yang dikategorikan menjadi 4 bidang yaitu bidang Pelayanan Kesehatan (no 1-5), bidang Jaminan Pengaman Sosial (No 6), bidang Peningkatan Gizi di Sekolah (No 7), dan bidang Pertanian, Sistem Pangan, dan Lingkungan Pangan (No 8-10) (Hawkes et al 2019).

1. Pelayanan gizi dan kesehatan untuk ibu hamil dan anak.

Pelayanan ini fokus pada konseling gizi seimbang, peningkatan kuantitas dan kualitas gizi ibu hamil, gaya hidup sehat, peningkatan berat badan hamil ideal, suplementasi, penurunan kematian ibu dan anak, penurunan risiko berat bayi lahir rendah.

2. ASI Eksklusif.

Promosi dan mendukung inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif sampai 6 bulan, ASI dilanjutkan sampai 24 bulan, mengurangi atau menghilangkan promosi susu formula.

3. Pemberian Makan Bayi dan Anak.

Promosi dan praktik pemberian makan bayi dan anak yang baik. Konsumsi makanan yang beragam dan sehat, konsumsi sayur dan buah setiap hari, menghindari pemberian makanan dan minuman tinggi energi, garam, gula, dan lemak (GGL), memilih makanan ringan yang sehat, mengevaluasi densitas energi dan densitas gizi makanan pendamping ASI, adanya kurikulum konseling gizi untuk kader dan petugas kesehatan.

4. Program Monitoring Pertumbuhan Anak.

Pengukuran berat dan tinggi badan anak harus dijadikan pengukuran dasar dalam pelayanan kesehatan dan gizi anak. Monitoring pertumbuhan anak dengan indeks berat badan menurut tinggi badan atau indeks massa tubuh menurut umur. Konseling mengenai gizi seimbang untuk mengatasi semua jenis masalah gizi.

5. Mencegah Efek Samping dari Pangan Densitas Energi Tinggi dan Fortifikasi Zat Gizi Mikro, serta Suplemen Siap Dikonsumsi.

Mempromosikan gizi seimbang untuk mencegah terjadinya MGG. Adanya monitoring pendistribusian pangan densitas energi tinggi, pangan fortifikasi zat gizi mikro, dan suplemen pada sasaran khusus yaitu ibu hamil, menyusui, dan anak usia baduta. Konseling gizi terkait gizi seimbang penting diberikan pada saat pemberian suplemen. Memastikan dan mempertimbangkan dengan baik pemberian pangan tinggi energi, pangan fortifikasi mikronutrien, dan suplemen untuk mengatasi gizi kurang dan gizi buruk atau mencegah stunting dan wasting.

6. Jaminan Pengaman Sosial.

Pemberian bantuan sosial baik berupa uang tunai, pangan, subsidi, voucher, atau lainnya. Pemberian bantuan perlu diberikan bersamaan dengan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendidikan yang fokus pada gizi seimbang, aktifitas fisik, dan promosi kesehatan. Pemeriksaan kesehatan dan status gizi rutin untuk mencegah penyakit tidak menular.

7. Program Pemberian Makan Anak Sekolah.

Adanya panduan program pemberian makan anak sekolah dimaksudkan agar memenuhi energi dan zat gizi yang dibutuhkan anak, dan membatasi atau menghindari makanan dan minuman tinggi energi dan GGL.

8. Program Sensitif Gizi.

Promosi penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan. Peningkatan pemberdayaan wanita. Mendesain pertanian perkotaan dengan teliti untuk mendukung akses pangan sehat.

9. Mendesain Kebijakan Sistem Pangan dan Pertanian yang Mendukung

Pola Konsumsi Sehat. Refocus pertanian pada ketersediaan sayur, buah, kacang-kacang, polongan-polongan, dan meningkatkan akses pangan terhadap makanan tersebut.

10. Implementasi Kebijakan untuk Membangun Lingkungan Pangan yang dapat Mencegah MGG.

Menghilangkan promosi susu formula, mengurangi pemasaran makanan dan minuman tinggi energi dan GGL. Monitoring klaim produk pangan. Menerapkan pajak makanan dan minuman tinggi energi dan GGL.

F. Simpulan

1. Strategi pencegahan stunting nasional berpusat pada 11 intervensi prioritas pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sesuai Renstra Kemenkes 2025-2029.

Intervensi gizi spesifik pada periode 1000 HPK diarahkan pada bumil, busui, bayi baru lahir dan balita untuk mencegah stunting.

2. Pedoman Gizi Seimbang (PGS) Indonesia sejak 2014 merupakan adaptasi global dari kongres gizi 1992 di Roma, melampaui konsep lama "4 Sehat 5 Sempurna" dengan empat pilar utama: aneka ragam pangan, hidup bersih, aktivitas fisik, dan pemantauan berat badan, serta 10 pesan praktis seperti "Isi Piringku" (50% sayur-buah, 50% pokok-lauk) untuk mencegah gizi kurang maupun lebih
3. Gizi buruk merupakan kondisi tubuh seseorang tidak memperoleh nutrisi yang memadai dari makanan yang dikonsumsi, sehingga tubuh tidak mendapatkan asupan gizi sesuai kebutuhan. Gizi buruk berpengaruh pada perkembangan otak anak yang dampaknya akan tampak pada tingkat kecerdasan dan kemampuan belajar
4. Permasalahan gizi dapat terjadi akibat kekurangan atau kelebihan gizi. gizi (stunting, wasting, underweight, dan kekurangan zat gizi mikro) sering terjadi secara bersamaan pada individu, rumah tangga, dan populasi yang sama, disebut dengan Masalah Gizi Ganda (MGG).

G. Referensi

(No date a) *Gizi Seimbang Atasi Masalah Gizi Ganda – sehat negeriku*. Available at: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20130226/127341/gizi-seimbang-atasi-masalah-gizi-ganda/> (Accessed: 10 February 2026).

(No date b) *Peranan gizi dalam upaya pencegahan penyakit tidak menular / UGM press - Badan Penerbit Dan publikasi Universitas Gadjah Mada*. Available at: <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/kedokteran-umum/peranan-gizi-dalam-upaya-pencegahan-penyakit-tidak-menular> (Accessed: 10 February 2026).

11 *intervensi Gizi Spesifik stunting: Apa Saja & Targetnya?* (no date) *KPoin*. Available at: <https://www.kpoin.com/blog/kesehatan-anak/intervensi-gizi-spesifik-stunting> (Accessed: 10 February 2026).

11 *intervensi Spesifik Atasi stunting Telah Dilaksanakan di Daerah, 2 di antaranya melebihi target* (no date a) *11 Intervensi Spesifik Atasi Stunting Telah Dilaksanakan di Daerah, 2 Di Antaranya Melebihi Target*. Available at: <https://kemkes.go.id/id/%2011-intervensi-spesifik-atasi-stunting-telah-dilaksanakan-di-daerah-2-di-antaranya-melebihi-target> (Accessed: 10 February 2026).

11 *intervensi Spesifik Atasi stunting Telah Dilaksanakan di Daerah, 2 di antaranya melebihi target* (no date b) *TP2S*. Available at: <https://stunting.go.id/11->

intervensi-spesifik-atasi-stunting-telah-dilaksanakan-di-daerah-2-di-
antaranya-melebihi-target/ (Accessed: 10 February 2026).

- Achmad, M. and Togubu, D.M. (2023) 'Pentingnya gizi Seimbang Dan Stimulasi 1000 Hari Pertama Kehidupan Untuk Mengurangi Gizi kurang balita', *Abdimas Polsaka*, pp. 25–31. doi:10.35816/abdimaspolsaka.v2i1.28.
- Admin (2025) *Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi): Konsep, Indikator, Dan Strategi mewujudkannya*, *gizi.poltekkes*. Available at: <https://gizi.poltekkes-mks.ac.id/keluarga-sadar-gizi-kadarzi-konsep-indikator-dan-strategi-mewujudkannya/> (Accessed: 10 February 2026).
- Anggi Rona, Tambunan, C.Y. and Sinaga, H.T. (2025) 'Pengaruh Edukasi gizi 1000 HPK TERHADAP Pengetahuan Dan Sikap Ibu hamil', *Al GIZZAI: Public Health Nutrition Journal*, 5(2), pp. 163–171. doi:10.24252/algizzai.v5i2.58762.
- Aryani, A. *et al.* (2025) 'Optimalisasi Peran Kader Dalam Pencegahan stunting pada anak melalui edukasi deteksi dini Tumbuh Kembang Dan Gizi Seimbang', *Jurnal Abdi Insani*, 12(3), pp. 1311–1318. doi:10.29303/abdiinsani.v12i3.2389.
- Assabila, S.Y. and Kurniasari, R. (2022) 'Pengaruh Penggunaan media podcast dan media video Terhadap Peningkatan Pengetahuan Pedoman Gizi Seimbang Pada remaja', *JURNAL Riset GIZI*, 10(1). doi:10.31983/jrg.v10i1.6931.
- Azizah, W.L. (2024) 'Wangi Gambira: Sosialisasi Isi Piringku sebagai program EDUKASI Orang Tua Dalam MENCEGAH gizi Buruk Pada Balita', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), p. 2216. doi:10.31764/jmm.v8i2.22035.
- BKPK, H. (2025) *Fornas gizi 2025: Perkuat Sinergi untuk PERBAIKAN status gizi Masyarakat Indonesia - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan: BPKP Kemenkes, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan / BPKP Kemenkes*. Available at: <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/forum-nasional-gizi-2025-perkuat-sinergi-untuk-perbaikan-status-gizi-masyarakat-indonesia/> (Accessed: 10 February 2026).
- Emylisa, D.A. *et al.* (2023) 'Edukasi gizi Seimbang Dan Kesehatan Reproduksi melalui media whatsapp Terhadap Pengetahuan remaja Dalam Upaya Pencegahan stunting', *Jurnal Ilmu Gizi dan Dietetik*, 2(4), pp. 293–300. doi:10.25182/jigd.2023.2.4.293-300.
- Fadjar Ramadhan (2024) 'Peranan gizi Dalam Pencegahan Penyakit', *Vitamin: Jurnal ilmu Kesehatan Umum*, 2(3), pp. 35–46. doi:10.61132/vitamin.v2i3.431.
- Hasanah, A.N. (2022) *Masalah gizi Buruk Dan upaya Pencegahannya Berdasarkan five level of prevention* [Preprint]. doi:10.31219/osf.io/79tjw.

- Indah Yun Diniaty R and Arisna Kadir (2022) 'Gerakan pencegahan stunting melalui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung program 1000 HPK', *Abdimas Polsaka*, 1(1), pp. 35–38. doi:10.35816/abdimaspolsaka.v1i1.13.
- Kurniati Akhfar *et al.* (2023) 'Peran intervensi gizi Spesifik Dalam penanggulangan Masalah Gizi Pada Balita di Kabupaten Bulukumba', *Journal of Educational Innovation and Public Health*, 1(3), pp. 139–148. doi:10.55606/innovation.v1i3.1517.
- Laswati, D.T. (2019) 'Masalah Gizi Dan Peran Gizi Seimbang', *AGROTECH: JURNAL ILMIAH TEKNOLOGI PERTANIAN*, 2(1), pp. 69–73. doi:10.37631/agrotech.v2i1.12.
- Lestari, dr. M.A. (no date) *Gizi Buruk - Penyebab, Gejala, Dan Pengobatannya*, *KlikDokter*. Available at: <https://www.klikdokter.com/penyakit/masalah-metabolik/gizi-buruk> (Accessed: 10 February 2026).
- Malnutrition: Symptoms, causes, diagnosis, and treatment* (no date) *Medical News Today*. Available at: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/179316> (Accessed: 10 February 2026).
- Mawartika, Y.E. *et al.* (2023) 'Implementasi case based reasoning untuk Mendeteksi Gejala Penyakit gizi Buruk Pada Balita', *Jurnal Pustaka Data (Pusat Akses Kajian Database, Analisa Teknologi, dan Arsitektur Komputer)*, 3(1), pp. 1–6. doi:10.55382/jurnalpustakadata.v3i1.526.
- Peraturan menteri Kesehatan republik Indonesia nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian kesehatan tahun 2025-2029* (no date) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029*. Available at: <https://kemkes.go.id/id/permenkes-ri-no-12-tahun-2025-tentang-rencana-strategis-kementerian-kesehatan-tahun-2025-2029> (Accessed: 10 February 2026).
- Permana, R.W. (2024) *Stunting Pada Anak Dan obesitas di Orang Dewasa Beri Beban Ganda Masalah gizi di Indonesia*, *merdeka.com*. Available at: <https://www.merdeka.com/sehat/stunting-pada-anak-dan-obesitas-di-orang-dewasa-beri-beban-ganda-masalah-gizi-di-indonesia-179961-mvk.html> (Accessed: 10 February 2026).
- Regiska Falensya (2025) 'Pentingnya gizi Seimbang Dalam Mencegah stunting pada anak usia Dini', *Journal Innovation In Education*, 3(4), pp. 08–21. doi:10.59841/inoved.v3i4.3549.
- Rindu Inayatullah, K., Djokosujono, K. and Prayogo Ramadhan, R. (2022) 'Karakteristik Kabupaten Dan Kota di Indonesia dengan masalah Gizi Ganda Pada penduduk Dewasa tahun 2018', *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(5), pp. 519–529. doi:10.56338/mppki.v5i5.2266.

- Sari, D., Mayangsari, R. and Dwirizky Abdullah, A. (2025) 'Optimizing the role of Posyandu cadres through growth monitoring training and nutrition education for the 1000 HPK Day as an efforts to prevent stunting', *Jukeshum: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), pp. 318–325. doi:10.51771/jukeshum.v5i2.1275.
- Saunders, J. and Smith, T. (2010) *Malnutrition: Causes and consequences, Clinical medicine* (London, England). Available at: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4951875/> (Accessed: 10 February 2026).
- SpA, dr. E. (2025) *Stunting - gejala, Penyebab, Pencegahan & Pengobatan, halodoc*. Available at: <https://www.halodoc.com/kesehatan/stunting> (Accessed: 10 February 2026).
- SSGI 2024: *Prevalensi stunting Nasional Turun Jadi 19,8%, Capai Angka di Bawah proyeksi bappenas* (no date) *TP25*. Available at: <https://stunting.go.id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-jadi-198-capai-angka-di-bawah-proyeksi-bappenas/> (Accessed: 10 February 2026).
- Syafitri, A.A. *et al.* (2025) 'Analisis Dampak Masalah Gizi Ganda Terhadap pertumbuhan ekonomi di benua asia: Tinjauan Pustaka', *CALVARIA MEDICAL JOURNAL*, 3(1), pp. 59–73. doi:10.30742/cmj.v3i1.194.
- Tanziha, I. and Diana, R. (2024a) 'Strategi Penanggulangan Masalah Gizi Ganda (double duty action)', *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 6(1), pp. 807–812. doi:10.29244/agro-maritim.0601.807-812.

H. Glosarium

Human capital = modal manusia
 Overweight = kelebihan berat badan
 Stunting = pendek
 Wasting = kurus
 HPK = Hari Pertama Kehidupan
 MGG = Masalah Gizi Ganda
 SSGI = Survei Status Gizi Indonesia
 GGL = Gula Garam Lemak
 UPKDK = Unit Pelayanan dan Penanggulangan Krisis Kesehatan
 ANC = Antenatal Care
 TTD = Tablet Tambah darah
 PMT = Pemberian Makanan Tambahan
 KEK = Kurang Energi Kronis
 IMD = Inisiasi Menyusui Dini
 PUGS = Pedoman Umum Gizi Seimbang

CHAPTER 8

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

Dr. Rahima, S.SiT., M.Kes., AIFO

A. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan pada abad ke-21 menghadapi tantangan yang semakin kompleks, hal ini ditandai dengan meningkatnya beban penyakit tidak menular, munculnya kembali penyakit menular, adanya perubahan demografi, serta ketimpangan akses layanan kesehatan. Transisi demografi dan epidemiologi menyebabkan pergeseran pola penyakit dari dominasi penyakit yang diakibatkan oleh infeksi, menuju penyakit kronis degeneratif seperti diabetes melitus, hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan kanker. Di sisi lain, masalah kesehatan ibu dan anak, stunting, serta penyakit yang berbasis lingkungan masih menjadi isu prioritas di berbagai wilayah, khususnya di negara berkembang.

Pendekatan pelayanan kesehatan yang selama ini berfokus pada kuratif terbukti belum mampu menjawab seluruh permasalahan kesehatan secara komprehensif dan berkelanjutan. Biaya pelayanan yang terus meningkat, keterbatasan dari sumber daya tenaga kesehatan, serta ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan formal menunjukkan perlu adanya perubahan dalam paradigma. Upaya promotif dan preventif menjadi strategi yang utama untuk menekan angka kesakitan dan kematian, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat muncul sebagai pendekatan strategis yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek pembangunan kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan komunitas untuk mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan, serta melakukan tindakan kolektif yang mendukung derajat kesehatan yang optimal. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Primary Health Care (PHC) yang menekankan partisipasi aktif dari masyarakat, pemerataan akses, keadilan sosial, dan kolaborasi antar lintas sektor.

Di Indonesia, berbagai kebijakan kesehatan telah mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat, seperti penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Posyandu, dan berbagai program promotif-preventif lainnya. Namun demikian,

implementasi pemberdayaan masyarakat masih menghadapi tantangan, antara lain rendahnya literasi kesehatan, keterbatasan sumber daya, ketimpangan sosial ekonomi, serta belum optimalnya kolaborasi lintas sektor. Lebih lanjut, agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-3 tentang kesehatan dan kesejahteraan, menegaskan pentingnya pendekatan promotif dan preventif berbasis masyarakat untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage).

Tanpa keterlibatan yang aktif dari masyarakat, upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan ini tidak akan mencapai dampak yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, strategi, serta implikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan menjadi sangat penting, khususnya bagi mahasiswa dan praktisi keperawatan. Bab ini akan membahas landasan teoritik, pendekatan implementatif, peran tenaga kesehatan, serta tantangan dan peluang dalam mengembangkan praktik pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek intervensi. Dalam konteks kesehatan, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan komunitas dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat, serta berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan diwujudkan melalui penguatan literasi kesehatan. Literasi kesehatan menjadi fondasi penting agar masyarakat mampu mengakses, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan secara benar. Melalui peningkatan literasi kesehatan, masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga memiliki kemampuan kritis dalam menilai kebenaran informasi, termasuk menyaring hoaks kesehatan yang berkembang di era digital. Kondisi ini mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri dalam pengambilan keputusan terkait perilaku hidup sehat dan pemanfaatan layanan kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat juga erat kaitannya dengan upaya peningkatan kesehatan lingkungan. Lingkungan yang sehat merupakan determinan utama kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan sanitasi, pengendalian vektor penyakit, dan pengelolaan sampah menjadi sangat relevan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat tidak hanya berdampak pada penurunan risiko penyakit, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain aspek fisik dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan mental dan psikososial semakin memperoleh perhatian. Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan mental, memberikan dukungan sosial, serta mengurangi stigma terhadap individu dengan masalah kesehatan jiwa. Melalui pembentukan kelompok dukungan sebaya dan pelibatan kader kesehatan jiwa, komunitas dapat menjadi ruang aman yang mendukung kesejahteraan mental anggotanya. Pendekatan ini menekankan bahwa kesehatan mental merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata persoalan individu.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam upaya kesehatan. Nilai budaya, norma sosial, dan praktik tradisional yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat memiliki potensi besar untuk mendukung perilaku hidup sehat. Pemanfaatan obat tradisional yang aman, peran tokoh adat dan agama sebagai agen perubahan, serta harmonisasi antara praktik kesehatan modern dan tradisional menjadi bentuk nyata pemberdayaan berbasis budaya. Pendekatan ini memungkinkan program kesehatan lebih diterima dan berkelanjutan karena selaras dengan identitas dan kepercayaan masyarakat setempat.

Upaya pemberdayaan masyarakat juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, memerlukan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada perubahan perilaku. Melalui kegiatan berbasis komunitas, seperti pos pembinaan terpadu, aktivitas fisik kelompok, dan edukasi gizi, masyarakat didorong untuk menjadi agen perubahan dalam menerapkan gaya hidup sehat. Pendekatan partisipatif ini menekankan bahwa keberhasilan pengendalian penyakit tidak menular sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat.

Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Ketahanan kesehatan keluarga menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Pemberdayaan keluarga mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam pencegahan penyakit, perawatan anggota keluarga yang sakit, serta pengambilan keputusan terkait kesehatan. Dengan keluarga yang berdaya, beban sistem pelayanan kesehatan dapat ditekan, dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan pendekatan holistik yang mencakup aspek individu, keluarga, komunitas, lingkungan, budaya, teknologi, dan sistem sosial. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, dukungan lintas sektor, serta keberlanjutan program yang dilaksanakan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan kesehatan, diharapkan tercipta masyarakat yang mandiri, berdaya, dan mampu menjaga kesehatannya secara berkelanjutan.

2. Prinsip

Pemberdayaan masyarakat didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain:

a. Partisipasi Aktif Masyarakat

Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan.

b. Kemandirian Dan Keberlanjutan

Upaya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mempertahankan perilaku hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan.

c. Kesenjangan Dan Kemitraan

Hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat bersifat sejajar, saling menghargai, dan berbasis kepercayaan.

d. Berbasis Kebutuhan dan Potensi Lokal

Intervensi disesuaikan dengan kebutuhan nyata serta potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat.

e. Pendekatan holistik dan Kontekstual

Pemberdayaan mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan.

3. Determinan Kesehatan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai determinan kesehatan, antara lain:

a. Faktor Individu

Meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan motivasi masyarakat terhadap kesehatan.

b. Faktor Sosial dan Ekonomi

Tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, serta dukungan sosial berperan penting dalam menentukan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat.

c. Faktor Lingkungan

Kondisi perumahan, sanitasi, ketersediaan air bersih, dan lingkungan kerja memengaruhi status kesehatan komunitas.

d. Akses terhadap Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta informasi kesehatan.

e. Kebijakan dan sistem Kesehatan

Regulasi, program pemerintah, dan dukungan lintas sektor turut menentukan efektivitas pemberdayaan masyarakat.

4. Peran Komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat

Komunitas memiliki peran sentral dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut antara lain:

a. Identifikasi Masalah Kesehatan Lokal

Masyarakat berkontribusi dalam mengenali masalah kesehatan yang paling relevan dengan kondisi lingkungan mereka.

b. Pengambilan Keputusan Bersama

Komunitas berperan dalam menentukan prioritas dan solusi terhadap masalah kesehatan yang dihadapi.

c. Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan

Keterlibatan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan kelompok sosial dalam menjalankan program kesehatan.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Masyarakat berperan dalam memantau keberlangsungan dan dampak program kesehatan.

e. Penguatan Norma dan Perilaku Sehat

Komunitas berfungsi sebagai agen perubahan dalam membentuk budaya dan perilaku hidup sehat.

Dengan keterlibatan aktif komunitas, peran tenaga kesehatan menjadi lebih efektif sebagai pendamping dan penggerak perubahan kesehatan masyarakat. Dalam praktik keperawatan komunitas, pemberdayaan merupakan bagian dari proses keperawatan yang meliputi pengkajian komunitas, penetapan diagnosis keperawatan komunitas, perencanaan/intervensi, implementasi, dan evaluasi. Perawat maupun tenaga kesehatan lainnya berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu masyarakat mengenali masalah-masalah kesehatan, kemudian mengidentifikasi sumber daya yang tersedia, dan merancang solusi yang sesuai dengan konteks nilai sosial budaya setempat.

Pemberdayaan juga berkaitan erat dengan konsep self-care dan self-management, terutama pada pengelolaan penyakit kronis. Tenaga kesehatan mendukung klien dan keluarganya agar mampu melakukan perawatan secara mandiri dan optimal, sehingga ketergantungan terhadap fasilitas kesehatan dapat diminimalkan.

C. Model dan Pendekatan Teoritis Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Landasan teoritis pemberdayaan masyarakat mencakup teori-teori komunitas, teori perubahan perilaku, dan pendekatan sosial-ekologis. Oleh karena itu, tenaga kesehatan juga perlu memahami dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan di masyarakat. Berikut adalah rangkuman teoritis mengenai pemberdayaan melalui sudut pandang teori-teori perilaku kesehatan yang dominan.

1. Pemberdayaan melalui Health Belief Model (HBM)

HBM berfokus pada persepsi subjektif pasien terhadap penyakit. Pemberdayaan dalam model ini dilakukan dengan mengubah cara pandang pasien terhadap ancaman-ancaman kesehatan dengan memberikan data akurat tentang risiko penyakit. Pasien yang sadar akan bahaya komplikasi cenderung merasa "berdaya" untuk mengambil langkah preventif, membantu pasien menimbang keuntungan dari pengobatan (misalnya, kualitas hidup membaik) dibandingkan hambatannya (misalnya, biaya atau efek samping), dan memberikan pengingat atau alat bantu yang memudahkan pasien bertindak secara mandiri.

2. Pemberdayaan melalui Social Cognitive Theory (SCT)

SCT menekankan pada Determinisme Timbal Balik antara lingkungan, individu, dan perilaku. Fokus utama pemberdayaan di sini adalah pengembangan Self-Efficacy. Tenaga kesehatan memberikan contoh (role modeling) atau mempertemukan pasien dengan survivor yang berhasil pulih. Melihat keberhasilan orang lain membe rdayakan pasien untuk mencoba hal yang sama. Tenaga kesehatan memberikan tugas-tugas kecil yang mudah dicapai (small wins) untuk membangun kepercayaan diri pasien secara bertahap, serta memberikan penguatan positif saat pasien berhasil melakukan manajemen mandiri, sehingga perilaku tersebut menetap.

Pemberdayaan dipandang sebagai hasil dari hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan komunitas. Hubungan ini dibangun melalui komunikasi yang efektif, kepercayaan, dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal.

3. Pemberdayaan melalui Social Ecological Model

Social Ecological Model (SEM) merupakan kerangka teoritik yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh interaksi kompleks antara individu dengan lingkungan sosial, organisasi, komunitas, dan kebijakan publik. Model ini dikembangkan berdasarkan teori ekologi sosial Bronfenbrenner dan banyak digunakan dalam kesehatan masyarakat. SEM menekankan bahwa perubahan perilaku yang berkelanjutan memerlukan intervensi pada berbagai level secara simultan.

4. Community-Based Participatory Research (CBPR)

CBPR adalah pendekatan penelitian dan intervensi yang menempatkan masyarakat sebagai mitra setara dalam seluruh proses, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini bertujuan mengurangi kesenjangan kesehatan (health disparities) melalui kolaborasi yang adil dan berkelanjutan.

5. Health Promotion Model (HPM)

Health Promotion Model (HPM) dikembangkan oleh Nola J. Pender untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku promosi kesehatan. Model ini menekankan bahwa individu secara aktif berupaya mencapai kondisi kesehatan optimal melalui pilihan perilaku tertentu. HPM berfokus pada determinan kognitif dan motivasional dalam perilaku kesehatan

6. *Health Impact Pyramid*

Health Impact Pyramid dikembangkan oleh Thomas R. Frieden untuk menggambarkan tingkat intervensi kesehatan masyarakat berdasarkan

dampaknya terhadap populasi. Semakin kedasar piramida, intervensi memiliki dampak populasi lebih luas dan berkelanjutan.

D. Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan Masalah Kesehatan

1. Pengertian

Pencegahan masalah kesehatan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya penyakit, menurunkan risiko kesehatan, serta mencegah perburukan kondisi kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks keperawatan, pencegahan masalah kesehatan menekankan pendekatan promotif dan preventif yang terintegrasi dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Pencegahan tidak hanya berfokus pada penyakit, tetapi juga pada faktor risiko, perilaku tidak sehat, serta kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi risiko kesehatan sejak dini dan mengedukasi masyarakat agar mampu menerapkan perilaku hidup sehat secara berkelanjutan.

2. Tujuan Pencegahan Masalah Kesehatan

Tujuan utama pencegahan masalah kesehatan meliputi:

- a. Mencegah timbulnya penyakit dan gangguan kesehatan pada individu dan masyarakat.
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian melalui deteksi dini dan intervensi tepat waktu.
- c. Mengurangi dampak komplikasi dan kecacatan akibat penyakit.
- d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.
- e. Menekan beban biaya kesehatan baik bagi individu maupun sistem pelayanan kesehatan.

3. Tingkatan Pencegahan Masalah Kesehatan

Pencegahan masalah kesehatan diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan, yaitu:

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer bertujuan mencegah terjadinya penyakit sebelum muncul gejala. Upaya ini dilakukan melalui promosi kesehatan dan perlindungan khusus, seperti edukasi kesehatan, imunisasi, perbaikan gizi, sanitasi lingkungan, dan peningkatan aktivitas fisik.

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder bertujuan mendeteksi penyakit pada tahap awal sehingga dapat segera ditangani dan mencegah komplikasi. Contoh upaya pencegahan sekunder antara lain skrining kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, dan deteksi dini faktor risiko.

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier berfokus pada upaya membatasi dampak penyakit yang telah terjadi agar tidak menimbulkan kecacatan lebih lanjut. Upaya ini meliputi pengobatan optimal, rehabilitasi, dan dukungan psikososial.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Keberhasilan upaya pencegahan masalah kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan.
- b. Perilaku kesehatan individu dan kelompok.
- c. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- d. Lingkungan fisik dan sosial.
- e. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam merancang intervensi pencegahan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat.

5. Pencegahan Masalah Kesehatan Berbasis Masyarakat

Pencegahan masalah kesehatan berbasis masyarakat menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam menjaga kesehatan. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat, pemanfaatan sumber daya lokal, serta keberlanjutan program kesehatan. Dalam praktik keperawatan komunitas, pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan faktor risiko dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

E. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit

1. Pengertian

Pengendalian penyakit adalah serangkaian upaya terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian, prevalensi, dan dampak penyakit, serta mencegah penularan, komplikasi, dan kematian pada individu, keluarga, dan masyarakat. Pengendalian penyakit mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara komprehensif. Dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat dan keperawatan komunitas, pengendalian penyakit menempatkan masyarakat

sebagai mitra aktif, sementara tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan koordinator pelayanan.

2. Tujuan Pengendalian Penyakit

Tujuan pengendalian penyakit meliputi:

- a. Menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit.
- b. Membatasi penyebaran penyakit menular dan mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular.
- c. Mencegah terjadinya komplikasi dan kekambuhan penyakit.
- d. Meningkatkan kualitas hidup penderita dan keluarganya.
- e. Menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup Pengendalian Penyakit

Pengendalian penyakit mencakup dua kelompok utama, yaitu:

a. Pengendalian Penyakit Menular

Meliputi kegiatan surveilans epidemiologi, penemuan dan penatalaksanaan kasus, imunisasi, pengendalian faktor lingkungan, serta edukasi pencegahan penularan.

b. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Meliputi pengendalian faktor risiko (merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, stres), skrining kesehatan, manajemen penyakit kronis, dan edukasi gaya hidup sehat.

4. Strategi Pengendalian Penyakit

Strategi pengendalian penyakit dapat dilakukan melalui:

a. Surveilans dan Pemantauan Penyakit

Pengumpulan dan analisis data penyakit sebagai dasar perencanaan program.

b. Deteksi dini dan Pengobatan Tepat

Penemuan kasus sedini mungkin untuk mencegah komplikasi.

c. Manajemen Kasus Berkelanjutan

Pendampingan pasien untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan dan perawatan.

d. Edukasi Kesehatan dan Perubahan Perilaku

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian penyakit.

e. Kolaborasi Lintas Sektor

Kerja sama dengan sektor pendidikan, lingkungan, dan sosial.

5. Prinsip Pengendalian Penyakit

Pelaksanaan pengendalian penyakit didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain:

- a. Berbasis bukti (evidence-based practice)
- b. Berorientasi pada masyarakat (community-oriented)
- c. Kesenambungan pelayanan (continuity of care)
- d. Partisipasi aktif masyarakat
- e. Keadilan dan pemerataan pelayanan kesehatan

F. Implementasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Dasar

Pemberdayaan dalam masyarakat merupakan proses sistematis yang dilakukan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan, serta bertindak secara mandiri dan berkelanjutan dalam menjaga kesehatannya. Implementasi pemberdayaan tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku individu, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial, struktural, dan lingkungan komunitas.

2. Prinsip-Prinsip Implementasi Pemberdayaan Masyarakat

Implementasi pemberdayaan harus berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

a. Partisipasi Aktif Masyarakat

Masyarakat dilibatkan sejak tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kesehatan.

b. Kesetaraan dan Kemitraan

Tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator dan mitra, bukan sebagai pihak yang dominan atau pengambil keputusan tunggal.

c. Berbasis Kebutuhan dan Potensi Lokal

Program pemberdayaan disesuaikan dengan masalah kesehatan, nilai budaya, sumber daya, dan kearifan lokal masyarakat.

d. Keberlanjutan

Pemberdayaan diarahkan agar kegiatan dapat terus berjalan meskipun pendampingan perawat telah berkurang.

e. Penguatan Kapasitas

Fokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam pengelolaan kesehatan.

3. Tahapan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengkajian (Community Assessment)

Melakukan pengkajian menyeluruh terhadap:

- 1) Masalah kesehatan utama komunitas
- 2) Faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan

- 3) Tingkat pengetahuan dan perilaku kesehatan
- 4) Sumber daya dan potensi masyarakat (kader, tokoh lokal, fasilitas)
- b. Perencanaan Program Pemberdayaan

Perencanaan dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat, meliputi:

 - 1) Penetapan prioritas masalah kesehatan
 - 2) Penentuan tujuan dan indikator keberhasilan
 - 3) Penyusunan kegiatan berbasis kebutuhan dan potensi lokal
- c. Pelaksanaan Intervensi Pemberdayaan

Bentuk implementasi dapat berupa:

 - 1) Pendidikan kesehatan berbasis kelompok
 - 2) Pelatihan kader kesehatan masyarakat
 - 3) Pendampingan keluarga berisiko
 - 4) Pembentukan kelompok swadaya (lansia, ibu hamil, penyakit kronis)
 - 5) Pengembangan media promosi kesehatan lokal
- d. Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai:

 - 1) Perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat
 - 2) Tingkat partisipasi dan kemandirian komunitas
 - 3) Keberlanjutan program setelah intervensi perawat
4. Strategi Implementasi Pemberdayaan Pada Berbagai Tatanan
 - a. Pemberdayaan Individu dan Keluarga

Fokus pada peningkatan kemampuan self-care, manajemen penyakit kronis, dan pengambilan keputusan kesehatan keluarga.
 - b. Pemberdayaan Kelompok Rentan

Meliputi lansia, ibu hamil, balita, dan penderita penyakit kronis melalui pendekatan suportif dan edukatif.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat

Dilakukan melalui penguatan peran kader, organisasi masyarakat, dan jejaring sosial lokal.

G. Tantangan dan Peluang Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi kesehatan, dan perbedaan sosial budaya. Selain itu, beban kerja perawat yang tinggi seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan secara optimal. Namun demikian, terdapat peluang yang besar untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pelayanan kesehatan.

Perkembangan teknologi informasi turut membuka peluang baru dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi kesehatan digital, seperti aplikasi kesehatan, telekonsultasi, dan media sosial, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan kesehatan. Melalui pemberdayaan digital, masyarakat didorong untuk memanfaatkan teknologi secara bijak sebagai sarana promosi kesehatan, pemantauan kondisi kesehatan, serta komunikasi dengan tenaga kesehatan. Pendekatan ini sangat relevan dalam menjawab tantangan kesenjangan akses layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.

Media digital melalui platform-platform seperti aplikasi dan website dapat digunakan sebagai sarana edukasi dan komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dengan masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan juga melakukan pendekatan komunikasi yang sensitif budaya, penguatan kepemimpinan lokal, melakukan kolaborasi lintas sektor, dan pengembangan kader kesehatan sebagai agen perubahan.

H. Simpulan

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan fundamental dalam pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan. Pergeseran paradigma dari pelayanan yang berorientasi kuratif menuju promotif dan preventif menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan kesehatan. Melalui proses pemberdayaan, individu dan komunitas didorong untuk meningkatkan kapasitas, literasi kesehatan, serta kemampuan mengambil keputusan yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan.

Masalah kesehatan dipengaruhi oleh berbagai determinan yang saling berkaitan, mulai dari faktor individu hingga kebijakan publik. Oleh karena itu, intervensi pemberdayaan perlu dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai level pengaruh. Model teoritik seperti Social Ecological Model, Community-Based Participatory Research (CBPR), Health Promotion Model, dan Health Impact Pyramid memberikan landasan konseptual dalam mengembangkan strategi yang efektif, partisipatif, dan berdampak luas.

Dalam praktik keperawatan komunitas, perawat memiliki peran strategis sebagai edukator, fasilitator, advokat, dan agen perubahan sosial. Perawat tidak hanya memberikan asuhan langsung, tetapi juga berkontribusi dalam pengorganisasian masyarakat, penguatan kemitraan, serta advokasi kebijakan

kesehatan. Peran ini sejalan dengan prinsip Primary Health Care dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar pendekatan program, melainkan strategi transformasional untuk membangun sistem kesehatan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Keberhasilan upaya ini memerlukan komitmen bersama antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat kapasitas komunitas secara berkesinambungan.

I. Referensi

- Bonita, R., Beaglehole, R., & Kjellström, T. (2017). *Basic epidemiology* (2nd ed.). World Health Organization.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2019a). *Principles of prevention and public health*. CDC.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2019b). *Principles of epidemiology in public health practice* (4th ed.). CDC.
- Chen, H. H., Lee, C., Huang, J., Chi, L., & Hsiung, Y. (2021). Effect of an mHealth-based intervention on excessive gestational weight gain prevention among overweight and obese women: A randomized controlled trial. *JMIR Preprints*.
- Clark, H., Coll-Seck, A. M., Banerjee, A., Peterson, S., Dalglish, S. L., Ameratunga, S., Balabanova, D., Bhan, M. K., Bhutta, Z. A., Borrazzo, J., Claeson, M., Doherty, T., El-Jardali, F., George, A. S., Gichaga, A., Gram, L., Hipgrave, D. B., Kwamie, A., Meng, Q., ... Costello, A. (2024). A future for the world's children? A WHO–UNICEF–Lancet Commission. *BMC Public Health*, 24(1), Article 18443. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18443-8>
- Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2015). *Health behavior: Theory, research, and practice* (5th ed.). Jossey-Bass.
- Goodman, R. M., & Sanders Thompson, V. L. (2017). The science of stakeholder engagement in research. *Translational Behavioral Medicine*, 7(3), 555–559. <https://doi.org/10.1007/s13142-017-0495-6>
- Harliani, & Rahmatia. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian hipertensi melalui edukasi dan pendampingan kader kesehatan. *Media Riset Kesehatan*, 14(1), 45–53.
- Harrington, E. K., Drake, A. L., Mateo, D., Ronen, K., Osoti, A. O., John-Stewart, G., Kinuthia, J., & Unger, J. A. (2019). An mHealth SMS intervention on postpartum contraceptive use among women and couples in Kenya:

- A randomized controlled trial. *American Journal of Public Health*, 109(6), 934–941. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2019.305051>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019a). Pedoman pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019b). Pedoman promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pengendalian penyakit terpadu berbasis masyarakat. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Rencana aksi nasional pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Profil kesehatan Indonesia 2022. Kemenkes RI.
- Laverack, G. (2017). *Health promotion practice: Building empowered communities*. McGraw-Hill Education.
- Maslowsky, J., Frost, S., Hendrick, C. E., Trujillo Cruz, F. O., & Merajver, S. D. (2016). Effects of postpartum mobile phone-based education on maternal and infant health in Ecuador. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 134(1), 93–98. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2015.12.008>
- McCarthy, O. L., Zghayyer, H., Stavridis, A., Adada, S., Ahamed, I., Leurent, B., Edwards, P., Palmer, M., & Free, C. (2019). An intervention delivered by mobile phone instant messaging to increase acceptability and use of effective contraception among young women in Bolivia: Randomized controlled trial. *Journal of Medical Internet Research*, 20, e14073. <https://doi.org/10.2196/14073>
- Minanga, A., & Kristamuliana. (2022). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan penyakit tidak menular. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pharmacon*, 3(2), 112–120.
- Ministry of Health Republic of Indonesia. (2019). Pedoman pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Kemenkes RI.
- Mohamed, S., Chipeta, M. G., Kamninga, T., Nthakomwa, L., Chifungo, C., Mzembe, T., Vellemu, R., Chikwapulo, V., Peterson, M., Abdullahi, L., Musau, K., Wazny, K., Zulu, E., & Madise, N. (2023). Interventions to prevent unintended pregnancies among adolescents: A rapid overview of systematic reviews. *Systematic Reviews*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s13643-023-02361-8>

- Musdalifah, M., Andriani, S., & Rahman, A. (2025). Penguatan kapasitas masyarakat dalam respons kejadian luar biasa berbasis komunitas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 77–86.
- Nies, M. A., & McEwen, M. (2019). *Community and public health nursing: Promoting the public's health* (7th ed.). Elsevier.
- Rifkin, S. B. (2014). Examining the links between community participation and health outcomes: A review of the literature. *Health Policy and Planning*, 29(Suppl. 2), ii98–ii106. <https://doi.org/10.1093/heapol/czu076>
- Stanhope, M., & Lancaster, J. (2020). *Public health nursing: Population-centered health care in the community* (10th ed.). Elsevier.
- Susilo, A., Susanti, R., & Sari, D. (2025). Community empowerment in non-communicable disease prevention: Evidence from Indonesia. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 6(1), 1–10.
- Syamsi Norma Lalla. (2024). Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Edukasi*, 2(1), 15–24.
- Wallerstein, N., Duran, B., Oetzel, J., & Minkler, M. (2018). *Community-based participatory research for health: Advancing social and health equity* (3rd ed.). Jossey-Bass.
- Whitehead, D. (2018). Health promotion and health education: Advancing the concepts. *Journal of Advanced Nursing*, 74(4), 812–822. <https://doi.org/10.1111/jan.13573>
- World Health Organization, & UNICEF. (2018). *Declaration of Astana*. WHO.
- World Health Organization. (2018). *Primary health care: Transforming vision into action*. WHO.
- World Health Organization. (2020). *Primary health care: Operational framework*. WHO.
- World Health Organization. (2022). *Noncommunicable diseases progress monitor 2022*. WHO.

J. Glosarium

Advokasi Kesehatan :

Upaya sistematis untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan publik guna mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.

Agen Perubahan:

Individu atau kelompok yang memfasilitasi terjadinya perubahan perilaku, sistem, atau kebijakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Assessment Komunitas :

Proses sistematis pengumpulan dan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan potensi kesehatan masyarakat.

Asuhan Keperawatan Komunitas:

Proses keperawatan yang diterapkan pada kelompok masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Capacity Building:

Proses peningkatan kapasitas individu dan komunitas agar mampu mengelola masalah kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan.

Community Development:

Pendekatan pembangunan berbasis partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan.

Community Engagement:

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan.

Community Organizing:

Strategi mobilisasi masyarakat untuk mengidentifikasi masalah bersama dan melakukan aksi kolektif.

Continuity of Care:

Kesinambungan pelayanan kesehatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan sesuai kebutuhan klien.

Deteksi Dini:

Upaya identifikasi penyakit atau faktor risiko pada tahap awal sebelum menimbulkan komplikasi

Determinans Sosial Kesehatan:

Faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi status kesehatan individu dan kelompok.

Edukasi Kesehatan:

Proses pemberian informasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku hidup sehat.

Empowerment (Pemberdayaan):

Proses meningkatkan kontrol individu atau komunitas terhadap keputusan dan tindakan yang memengaruhi kesehatan mereka.

Evidence-Based Practice:

Pendekatan praktik profesional yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dengan pengalaman klinis dan preferensi klien.

Health Belief Model:

Model teori perilaku kesehatan yang menjelaskan tindakan individu berdasarkan persepsi risiko dan manfaat.

Health Literacy:

Kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan secara efektif.

Health Promotion:

Upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor penentu kesehatan.

Home Care:

Pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian pasien.

Imunisasi:

Upaya pencegahan primer melalui pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan terhadap penyakit tertentu.

Interprofessional Collaboration:

Kerja sama lintas profesi dalam pelayanan kesehatan untuk mencapai hasil yang optimal.

Kader Kesehatan:

Anggota masyarakat yang dilatih untuk membantu pelaksanaan program kesehatan di komunitas.

Keadilan Kesehatan:

Prinsip pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kemitraan:

Hubungan kerja sama sejajar antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam pengelolaan kesehatan.

Kesehatan Lingkungan:

Kondisi lingkungan fisik dan sosial yang mempengaruhi kesehatan manusia.

Kesehatan Primer:

Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mudah diakses dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kesehatan Reproduksi:

Keadaan sehat secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

Kewenangan Profesional:

Hak dan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik sesuai standar kompetensi.

Kolaborasi Lintas Sektor:

Kerja sama antara sektor kesehatan dan non-kesehatan untuk mendukung pencapaian tujuan kesehatan.

Literasi Digital Kesehatan:

Kemampuan memahami dan memanfaatkan informasi kesehatan melalui media digital.

Manajemen Kasus:

Pendekatan terstruktur dalam pengelolaan pasien untuk memastikan perawatan yang efektif dan terkoordinasi.

Monitoring dan Evaluasi:

Proses pemantauan dan penilaian program untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan.

Musyawarah Masyarakat:

Forum partisipatif untuk membahas dan menetapkan prioritas masalah kesehatan komunitas.

Otonomi Profesional:

Kemampuan perawat dalam mengambil keputusan klinis secara mandiri sesuai standar praktik.

Partisipasi Masyarakat:

Keterlibatan aktif individu dan kelompok dalam setiap tahapan program kesehatan.

Pencegahan Primer:

Upaya mencegah timbulnya penyakit sebelum terjadi melalui promosi kesehatan dan perlindungan khusus.

Pencegahan Sekunder:

Upaya deteksi dini dan intervensi segera untuk mencegah komplikasi.

Pencegahan Tersier:

Upaya mengurangi dampak dan kecacatan akibat penyakit melalui rehabilitasi.

Pengendalian Penyakit:

Upaya terpadu untuk menurunkan kejadian, prevalensi, dan dampak penyakit.

Pengkajian Keperawatan:

Tahap awal proses keperawatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan klien atau komunitas.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS):

Serangkaian perilaku yang dipraktikkan berdasarkan kesadaran untuk meningkatkan kesehatan.

Preventif:

Upaya pencegahan penyakit melalui pengendalian faktor risiko.

Primary Health Care (PHC):

Pendekatan pelayanan kesehatan dasar yang menekankan akses universal, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.

Program Berbasis Masyarakat:

Kegiatan kesehatan yang dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan komunitas sebagai pelaku utama.

Promotif:

Upaya peningkatan kesehatan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Rehabilitatif:

Upaya pemulihan fungsi setelah terjadinya gangguan kesehatan.

SDGs (Sustainable Development Goals):

Tujuan pembangunan berkelanjutan global yang mencakup aspek kesehatan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Self-Care:

Kemampuan individu dalam merawat dan menjaga kesehatannya secara mandiri.

Self-Efficacy:

Keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melakukan tindakan kesehatan.

Self-Management:

Kemampuan individu dalam mengelola penyakit kronis dan kondisi kesehatannya.

Social Cognitive Theory:

Teori yang menjelaskan interaksi timbal balik antara individu, perilaku, dan lingkungan.

Surveilans Epidemiologi:

Kegiatan pemantauan dan analisis data penyakit secara sistematis dan berkelanjutan.

Transisi Epidemiologi:

Perubahan pola penyakit dari dominasi penyakit menular ke penyakit tidak menular.

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM):

Kegiatan kesehatan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat guna meningkatkan kemandirian kesehatan.

PROFIL PENULIS



A. Miftahul Khair, S.Kep., Ns., M.Kep., lahir 22 Desember 1985 di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Menempuh pendidikan formal di SMAN 1 Maros lulus tahun 2004. Melanjutkan kuliah S1 Keperawatan di Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar dan lulus tahun 2009. Lulus menjadi ASN pada tahun 2010 di Poltekkes Kemenkes Maluku dan menjadi salah satu staf dosen tetap DIII Keperawatan Prodi Keperawatan Masohi. Penulis meneruskan profesi Ners di STIKES Nani Hasanuddin Makassar tahun 2009 -2013 dan memperoleh gelar Ners (Ns). Pada tahun 2017 kembali melanjutkan kuliah S2 Keperawatan di Program Studi Magister Keperawatan Universitas Padjadjaran Bandung dan mengambil peminatan keperawatan kritis (*critical care*) dan selesai pada tahun 2019 dengan gelar Magister Keperawatan (M.Kep). Terhitung sejak 2010 sampai saat ini aktif sebagai Dosen yang aktif melaksanakan tugas TRI DHARMA Perguruan Tinggi di Prodi Keperawatan Masohi. Penulis juga menulis beberapa judul chapter buku yang diterbitkan penerbit Nasional diantaranya Buku Pendidikan Kewirausahaan, Manajemen Keperawatan Keperawatan Kegawatdaruratan, Manajemen Bencana, Pemeriksaan Fisik, Manajemen Nyeri, Buku ajar keperawatan anak. Serta beberapa publikasi penelitian dan pengabdian masyarakat pada Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional terakreditasi Dikti. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: miftakhair85@gmail.com



Dr. Ns. Febriyanti, M.Kep., merupakan dosen dan akademisi di bidang keperawatan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dan Magister (S2) Keperawatan di Universitas Andalas (UNAND). Selanjutnya, penulis meraih gelar Doktor (S3) pada Program Studi Kesehatan Masyarakat di Universitas Andalas, dengan fokus kajian pada pengembangan kesehatan masyarakat dan keperawatan berbasis promotif dan preventif serta metodologi penelitian. Bidang keahlian dan minat riset penulis meliputi keperawatan pada penyakit degeneratif, promosi dan edukasi kesehatan, manajemen keperawatan, kesehatan masyarakat, serta pengembangan model edukasi dan intervensi keperawatan berbasis holistik dan teknologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah di bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat, khususnya yang berorientasi pada pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas terutama pada penyakit degeneratif. E-mail: febrianti160911@gmail.com

PROFIL PENULIS



Yourisna Pasambo, Ners., M.Kes., lahir di Toraja Utara, pada tanggal 06 Oktober 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Hasanuddin tahun 2002-2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Biomedik (Fisiologi) Universitas Hasanuddin dan lulus tahun pada tahun 2012. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan pada Program Studi S3 Keperawatan di Universitas Airlangga Surabaya. Penulis mengawali karirnya sebagai dosen tetap di Akper Sandi Karsa Makassar. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan pengajaran, menulis buku, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yourisna@poltekkes-manado.ac.id.



Dr. Bd. Silvia Nova, SST., M.Kes., Penulis Lahir di Duri pada tanggal 21 Maret 1985. Penulis adalah Dosen DIII Prodi Kebidanan Institut Kesehatan Helvetia Pekanbaru. Penulis menjalani pendidikan DIII Kebidanan di Akademi Kebidanan Deli Husada Deli Tua Medan. Untuk Pendidikan D IV Kebidanan, Profesi Bidan dan S2 Kesehatan Masyarakat penulis menjalani di STIKes Helvetia Medan. Penulis menyelesaikan pendidikan S3 Kesmas di Universitas Airlangga. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: silvianova@helvetia.ac.id

Buku yang pernah ditulis antara lain: Farmakologi Dasar, latihan Soal Uji Kopetensi DIII dan Profesi Bidan Edisi I, Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kesehatan Mental pada Ibu Hamil dan Ibu Pasca Melahirkan. Penulis memiliki ketertarikan di bidang kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah bidang kesehatan. Penulis juga tergabung sebagai anggota IBI dan AIPKIND kota Pekanbaru. Penulis berkeinginan mengembangkan Ilmu Kebidanan melalui beberapa buku yang ditulis. Semoga bermanfaat bagi pembaca baik mahasiswa maupun Dosen Kebidanan serta masyarakat umum.

PROFIL PENULIS



Hega Valentine, SKM., MKM., Lahir di Lubuk Alung, 09 Februari 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Baiturrahmah lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR.Hamka dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005, terhitung 20 tahun dari sekarang telah menjadi dosen dan menumbuhkan keyakinan bahwa saya memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi instansi tempat saya bekerja yaitu Universitas Sumatera Barat. Saat ini penulis bekerja di Universitas Sumatera Barat mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Antropologi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, jurnal bereputasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hegavalentine09@gmail.com. Motto: "There is no such thing as giving up when it comes to education and educating the nation's children"



apt. Afifah Fauziyyah, S.Farm., M.Farm., Lahir di Bengkulu Selatan, 15 Oktober 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Apoteker pada Fakultas Farmasi, Universitas Ahmad Dahlan tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 sebagai apoteker penanggung jawab pada salah satu apotek di Bekasi, selanjutnya bekerja sebagai *pharmacy manager* di apotek kimia farma citra garden kalideres, sempat menjadi dosen partime di STIKES Al-Fatah, dan saat ini bekerja sebagai dosen tetap di prodi D3 farmasi Universitas Bengkulu. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, serta pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: afauziyyah@unib.ac.id.

PROFIL PENULIS



Salman, SKM, M.Kes., Lahir di Pariaman Sumatera Barat, 16 Agustus 1963. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Akademi Gizi Depkes Padang (Jenjang D3) lulus tahun 1986. Selanjutnya jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Gizi dan Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin lulus tahun 1993. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gajah Mada Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dan lulus tahun pada tahun 2002. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1987 sebagai pelaksana gizi di RSU Gunung Wenang Manado. Sejak 1995 sampai dengan 2008 dosen tetap di Akademi Gizi Manado (sekarang Jurusan Gizi) Poltekkes Manado. Sejak 2008 sampai sekarang sebagai dosen tetap di jurusan Gizi Poltekkes Gorontalo. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Dietetika Penyakit Infeksi, Dietetika Penyakit Tidak Menular, Etika Profesi, Patologi Penyakit Tidak Menular, Asuhan Klinik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti, pengabdian masyarakat, seminar dll. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: slmnlukman@gmail.com. Motto: "Living your life well"



Dr. Rahima., S.ST., M.Kes., AIFO., lahir di Bajubang, Jambi, pada 01 Oktober 1984. Pendidikan Tinggi yang ditempuh oleh penulis yakni jenjang D4/S1 Keperawatan Pada Program Studi Keperawatan Gawat Darurat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi Tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2012. Melanjutkan pendidikan Doktorat pada Program Studi Ilmu Kedokteran & Kesehatan di Universitas Diponegoro, Semarang Tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali dengan menjadi Staf Laboratorium dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih Jambi Tahun 2006-2012, kemudian menjadi dosen tetap di Universitas Baiturrahim dari Tahun 2013-sekarang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai peneliti dan pengabdian kepada masyarakat di Forum Layanan IPTEKS bagi Masyarakat (FlipMas) Kajanglako Jambi, Reviewer eksternal penelitian di Jurnal Nasional Terakreditasi, pemakalah diseminar nasional maupun internasional, dan publikasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ira.aja1984@gmail.com

Motto: "Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya" (Sufyan Bin Uyainah)

Sinopsis

Bunga rampai "Peran Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan" menghadirkan kumpulan tulisan lintas disiplin yang menegaskan pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat masa kini. Buku ini menyoroti bahwa upaya pengendalian masalah kesehatan tidak dapat bergantung pada layanan kuratif semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif tenaga kesehatan, sistem pelayanan yang kuat, serta partisipasi masyarakat yang berdaya.

Pembahasan diawali dengan peran tenaga kesehatan dalam pencegahan penyakit menular, mencakup surveilans, edukasi, imunisasi, pencegahan penularan, dan respons cepat berbasis komunitas. Selanjutnya, buku ini mengulas pencegahan penyakit tidak menular (PTM) melalui deteksi dini, pengendalian faktor risiko, pendampingan perubahan perilaku, serta intervensi berbasis keluarga dan lingkungan. Bab tentang promosi gaya hidup sehat memperkuat strategi komunikasi kesehatan, kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, hingga penguatan kebiasaan sehat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada bagian kesehatan ibu dan anak, bunga rampai ini menguraikan peran kebidanan dalam mencegah berbagai masalah melalui pelayanan antenatal, persalinan, nifas, neonatal, serta konseling berkelanjutan untuk mendukung keselamatan ibu dan tumbuh kembang anak. Isu kesehatan reproduksi wanita usia subur dibahas melalui pendekatan *evidence-based practice*, yang menekankan pengambilan keputusan klinis berbasis bukti ilmiah, pengalaman klinis, dan preferensi pasien sehingga intervensi yang diberikan lebih efektif, aman, dan terukur.

Buku ini juga menyoroti aspek keselamatan pasien melalui kontribusi farmasi dalam pencegahan kesalahan penggunaan obat, seperti edukasi obat, rekonsiliasi obat, peningkatan kepatuhan, serta penguatan budaya *patient safety*. Dalam ranah gizi, pembahasan peran gizi dalam pencegahan masalah gizi dan penyakit terkait menekankan intervensi nutrisi sepanjang daur kehidupan, pencegahan stunting dan anemia, serta manajemen diet pada kondisi risiko. Sebagai penutup, buku ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi kesehatan, pembentukan kader, penguatan jejaring lokal, serta kolaborasi lintas sektor agar pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan berjalan berkelanjutan.

Dengan bahasa yang sistematis dan aplikatif, bunga rampai ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, dan pembaca umum yang ingin memahami peran strategis profesi kesehatan dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Buku ini diharapkan menjadi referensi yang memperkuat sinergi antarprofesi dan mendorong lahirnya praktik pencegahan yang efektif, berbasis bukti, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bunga rampai “Peran Tenaga Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan” menghadirkan kumpulan tulisan lintas disiplin yang menegaskan pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat masa kini. Buku ini menyoroti bahwa upaya pengendalian masalah kesehatan tidak dapat bergantung pada layanan kuratif semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif tenaga kesehatan, sistem pelayanan yang kuat, serta partisipasi masyarakat yang berdaya.

Pembahasan diawali dengan peran tenaga kesehatan dalam pencegahan penyakit menular, mencakup surveilans, edukasi, imunisasi, pencegahan penularan, dan respons cepat berbasis komunitas. Selanjutnya, buku ini mengulas pencegahan penyakit tidak menular (PTM) melalui deteksi dini, pengendalian faktor risiko, pendampingan perubahan perilaku, serta intervensi berbasis keluarga dan lingkungan. Bab tentang promosi gaya hidup sehat memperkuat strategi komunikasi kesehatan, kampanye perilaku hidup bersih dan sehat, hingga penguatan kebiasaan sehat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada bagian kesehatan ibu dan anak, bunga rampai ini menguraikan peran kebidanan dalam mencegah berbagai masalah melalui pelayanan antenatal, persalinan, nifas, neonatal, serta konseling berkelanjutan untuk mendukung keselamatan ibu dan tumbuh kembang anak. Isu kesehatan reproduksi wanita usia subur dibahas melalui pendekatan evidence-based practice, yang menekankan pengambilan keputusan klinis berbasis bukti ilmiah, pengalaman klinis, dan preferensi pasien sehingga intervensi yang diberikan lebih efektif, aman, dan terukur.

Buku ini juga menyoroti aspek keselamatan pasien melalui kontribusi farmasi dalam pencegahan kesalahan penggunaan obat, seperti edukasi obat, rekonsiliasi obat, peningkatan kepatuhan, serta penguatan budaya patient safety. Dalam ranah gizi, pembahasan peran gizi dalam pencegahan masalah gizi dan penyakit terkait menekankan intervensi nutrisi sepanjang daur kehidupan, pencegahan stunting dan anemia, serta manajemen diet pada kondisi risiko. Sebagai penutup, buku ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi kesehatan, pembentukan kader, penguatan jejaring lokal, serta kolaborasi lintas sektor agar pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan berjalan berkelanjutan.

Dengan bahasa yang sistematis dan aplikatif, bunga rampai ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, dan pembaca umum yang ingin memahami peran strategis profesi kesehatan dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Buku ini diharapkan menjadi referensi yang memperkuat sinergi antarprofesi dan mendorong lahirnya praktik pencegahan yang efektif, berbasis bukti, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

ISBN 978-634-7556-61-5



9

786347

556615

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

